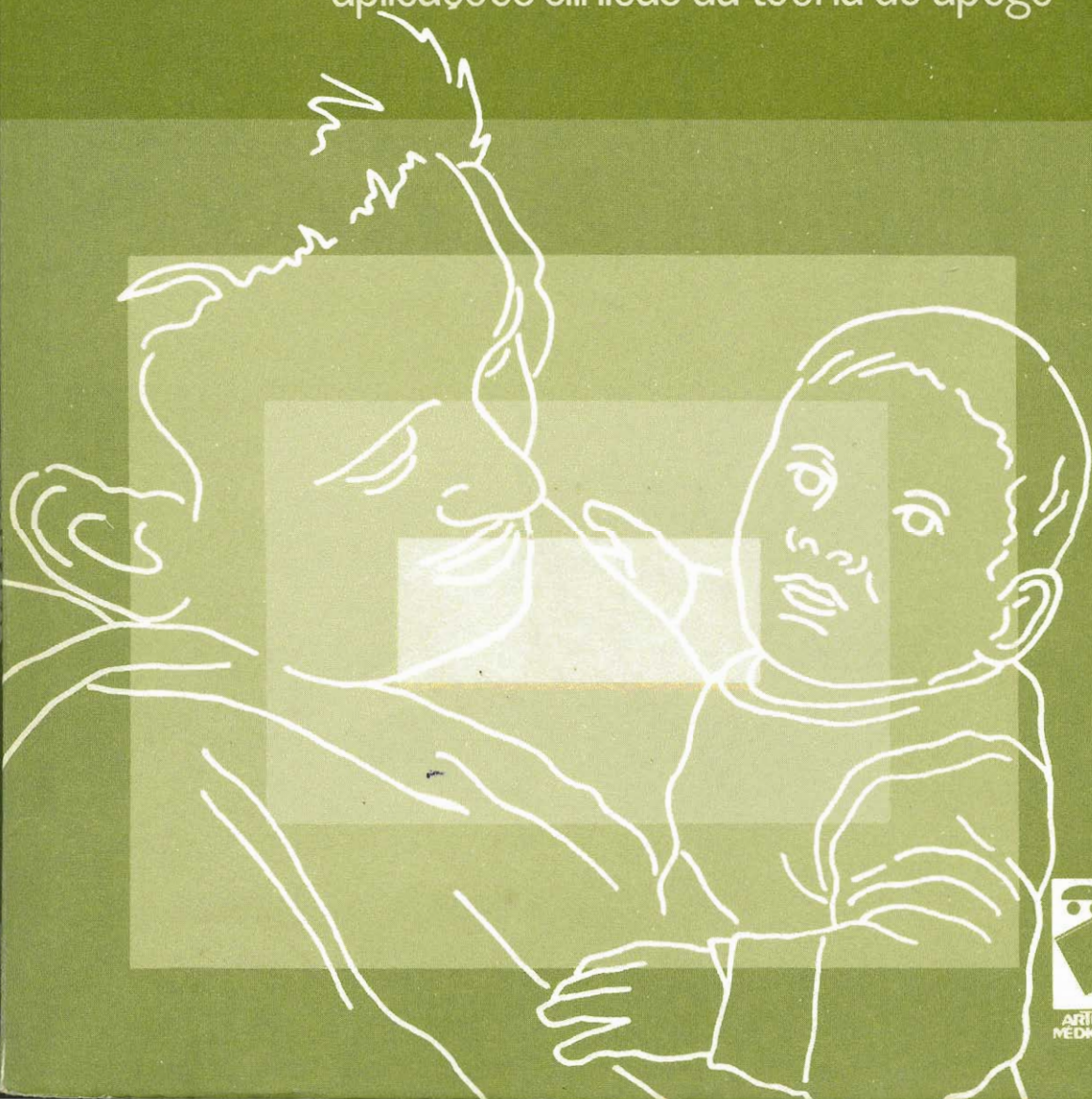


JOHN BOWLBY

UMA BASE SEGURA

aplicações clínicas da teoria do apego



JOHN BOWLBY

UMA BASE SEGURA

Aplicações clínicas da teoria do apego

Tradução

Sonia Monteiro de Barros

Revisão

Maria de Lourdes Teixeira de Resende

Membros da Escola Brasileira de Psicanálise e Etologia

Revisão técnica

Dra. Elizabeth Brasil Paulon

Diretora Geral da Escola Brasileira de Psicanálise e Etologia



PORTO ALEGRE — 1989

B787b Bowlby, John

Uma base segura : aplicações clínicas da teoria do apego
/ John Bowlby . — Porto Alegre : Artes Médicas, 1989.
202p.

1. PSICANÁLISE 2. PERSONALIDADE

I. Título

CDD 616.8917

155.2

CDU 159.923

159.964.2

ÍNDICE ALFABÉTICO PARA CATÁLOGO SISTEMÁTICO

Personalidade 159.923

Psicanálise 159.964.2

Bibliotecária Neiva Vieira CRB10/563

Agradecimentos

Nos últimos dez anos venho sendo beneficiado pela constante comunicação com os alunos e com o pessoal da Clínica Tavistock e, também, com um certo número de colegas engajados em estudos pioneiros de como os modelos de apego se desenvolvem durante a infância. A todos eles eu devo minha gratidão, por sugestões úteis e freqüentes, pelas correções necessárias e, também, pelo estímulo e coragem. À minha secretária Dorothy Southern, eu também devo uma profunda gratidão pelos muitos anos de dedicação, durante os quais ela fez seus os meus interesses.

Meus agradecimentos a Molly Townsend, pela assistência editorial na preparação destas conferências para publicação, assim como pela preparação do índice.

As seis primeiras conferências deste livro aparecem em outras publicações e fico grato pela permissão dos editores para reproduzi-las aqui. A conferência nº 1 foi a de nº 18 em: *Paternalidade: Uma Perspectiva Psicodinâmica* editada por Rebecca S. Cohen, Bertram J. Cohler e Sidney H. Weissman, Guilford Press, Nova York (1984); a conferência nº 2 com o título "Apego e Perda: Retrospectiva e Perspectiva" foi publicada no *American Journal of Orthopsychiatry* 52:664-78 (1982); a conferência nº 3, "Psicanálise como Arte e Ciência", na *International Review of Psychoanalysis* 6:3-14 (1979); a conferência nº 4, "Psicanálise como Ciência Natural", na *International Review of Psychoanalysis* 8:243-56 (1981); a conferência nº 5, "Violência na Família: Uma Desordem nos Sistemas de Apego e de Cuidados", no *The American Journal of Psychoanalysis* 44:9-27 (1984); a conferência nº 6 constituiu o capítulo 6 de *Cognição e Psicoterapia* editado por Michael J. Mahoney e Artur Freeman, Plenum Publishing Corporation, Nova York e Londres (1985) e foi ampliada a partir de "Saber o que você não deve saber e sentir o que você não deve sentir", no *Canadian Journal of Psychiatry* 24:403-8 (1979).

Apresentação à Edição Brasileira

Ler este livro é ler sobre Psicanálise Científica. Bowlby conquista para a psicanálise o seu devido lugar entre as ciências naturais tão almejada por Freud. Desde os anos de 1925/1928 que a atenção do cientista inglês voltava-se para as experiências da vida real e seus efeitos patogênicos.

Na década de 40 já escrevia sobre a relação entre separações prolongadas da figura materna e o desenvolvimento de um caráter especial.

Em 1950 a Organização Mundial de Saúde requisita-lhe um relatório sobre a saúde mental das crianças sem lar. Este trabalho marca, então, a fundamental questão bolbyana: "Qual a natureza desse laço rompido?"

Em 1951 descobre Lorenz e Tinbergen e acompanha os experimentos de Harlow e Hinde.

A partir de então, Bowlby começa a elaborar um método científico pertinente com as questões psicanalíticas.

Em 1969 escreve *Apego*, em 1973 *Separação* e em 1980, *Perda*, sua tão famosa trilogia já traduzida em seis idiomas e adotada nos países mais desenvolvidos cientificamente.

A teoria do apego elimina as crassas deficiências científicas da teoria anterior, tão criticada por filósofos da ciência, biólogos e psicanalistas verdadeiramente clínicos. Críticas, como por exemplo: não usar metodologia científica, método retrospectivo, clínicos sem treinamento científico, entre outras.

Encontramos agora, com a Psicanálise Científica (Attachment Theory), a vinculação ao *corpus* principal da Biologia moderna, por exemplo:

- ao ser formulada nos moldes da teoria do controle, ao invés da teoria das pulsões. O sistema de controle central está inscrito no sistema nervoso central, controlando a ativação ou a finalização de um dado comportamento, de acordo com determinados sinais ou certas condições ambientais. Os dois conceitos centrais de sistema são: informação e organização. Não se postula a existência de nenhuma energia especial distinta da energia física;
- ao ser formulada de acordo com a teoria da evolução das espécies de Darwin (adaptação biológica, meio ambiente e social);
- método experimental adicional;
- a teoria do apego é testável, utilizando uma combinação dos métodos retrospectivo e prospectivo. Desde Newton, em ciência natural há: observa-

ção + hipótese + experimentação. Das hipóteses são deduzidas predições testáveis e as hipóteses se sustentam ou caem, dependendo da exatidão das predições verificadas experimentalmente.

Está comprovado que a propensão de estabelecer laços emocionais íntimos com pessoas especiais é básico da natureza humana e permanece durante todo o ciclo vital.

Existem alguns conceitos básicos para a compreensão dessa nova estrutura conceitual, que fundamenta nossa postura.

- Comportamento de apego — significa qualquer comportamento que resulte em uma pessoa alcançar e manter proximidade com algum outro indivíduo claramente identificado.

- Comportamento de cuidado — complementar ao anterior. Se alguém se apega é porque alguém oferece cuidado.

- Comportamento exploratório — quanto mais seguro (de apego) o indivíduo se encontra, para mais distante e por mais tempo ele está capacitado a explorar.

Ainsworth, em 1971, definiu o modelo típico de interação entre a criança e seus pais, assim: "Exploração a partir de uma base segura".

O título deste livro é, então, um outro conceito fundamental da Psicanálise Científica, o de Base Segura — uma vivência familiar feliz, segura com suas figuras de apego acessíveis, disponíveis e receptivas. Uma satisfatória homeostase ambiental.

Tendo trabalhado durante muitos anos em instituições psiquiátricas, instituições penais e orfanatos com psicóticos, delinquentes e crianças abandonadas, me mantive desde sempre insatisfeita com as explicações tradicionais que a formação ortodoxa me oferecia. Na verdade, a vida real dos pacientes, caracterizada em sua maioria por separações, perdas, abandonos ou falta de cuidados e atenções sinceras, exigia de mim, como terapeuta, ser a figura (de apego) capaz de lhes inspirar segurança e confiança afetiva e constante. Aos meus olhos, parecia ser esta a condição absolutamente real e necessária para que os fatos dolorosos vividos pelos pacientes pudessem ser elaborados e aceitos. No entanto, a estas e outras questões colocadas pela prática clínica, faltava uma adequada estrutura conceitual que lhes sustentasse e desse ordenamento. Eu a encontrei na *Teoria do Apego* de John Bowlby.

Quando em 1986 estive junto ao Dr. Bowlby, além das fortes impressões que me causaram sua vasta experiência e sua genialidade, fui honrada com a descoberta gratificante do pioneirismo de representar uma escola de formação em Psicanálise Científica, a ESCOLA BRASILEIRA DE PSICANÁLISE E ETOLOGIA, pois, até então, só havíamos recebido parabenização por parte de psicanalistas sul e norte-americanos. Pude registrar, também, sua alegria de saber sobre a abrangência social que nosso trabalho vem cunhando no Brasil.

Nossos 12 anos de trabalhos didáticos, teóricos, técnicos, práticos e comunitários e os avanços de nossas pesquisas fizeram com que em julho de 1988, em Londres, escrevêssemos, juntos, o livro: *Scientific Psychoanalysis — A Coming Together of Endearment and Science* (Psicanálise Científica — Um Encontro de Ternura e Ciência), que espero ver, também, publicado no Brasil, por essa tão séria, no campo científico editorial, “Artes Médicas”.

Creio que obra tão importante no mundo da ciência, como a de Dr. Bowlby — ampliada e enriquecida agora com este novo livro — terá a devida repercussão em todos aqueles interessados na natureza humana e na saúde e que acompanham com seriedade e sem preconceitos os progressos de nossa ciência, encontrando-se agora com o editor certo.

Dra. Elizabeth Brasil Paulon
Diretora-Geral da Escola Brasileira
de Psicanálise e Etologia

Rio de Janeiro, 1989

Prefácio

Em 1979, sob o título de *Formação e Rompimento dos Laços Afetivos*, publiquei uma pequena coleção de conferências que havia dado para platéias variadas nas duas décadas anteriores. Apresento, neste volume, outra seleção de conferências dadas desde então. As cinco primeiras dirigiram-se a uma platéia especial, numa ocasião também especial; pormenores sobre cada uma estão descritos em um breve preâmbulo. As três conferências restantes são versões ampliadas de conferências dadas para uma audiência composta de profissionais de saúde mental, em países da Europa e nos Estados Unidos da América. Achei melhor, como na seleção anterior, transcrever cada conferência da forma mais próxima possível daquela em que foi originalmente publicada.

Posto que a teoria do apego oferece as bases para cada uma das conferências, algumas modificações foram necessárias a fim de evitar um excesso de repetição. Esperamos que da forma como ficou, apresentando as mesmas idéias em contextos diferentes, fiquem esclarecidos e enfatizados os aspectos distintos da teoria.

Na medida que a teoria do apego foi formulada por um clínico para o uso em diagnóstico e tratamento de pacientes e famílias emocionalmente perturbadas, não é surpreendente que seu uso tenha, anteriormente, se dirigido a promover pesquisas na psicologia do desenvolvimento. Enquanto dou boas-vindas às descobertas desta pesquisa, porquanto ampliam nossa compreensão sobre o desenvolvimento da personalidade e psicopatologia e são, por isso, da maior importância clínica, tem sido bastante desapontador verificar que os clínicos têm sido muito lentos na testagem do uso dessa teoria. Existem, possivelmente, muitas razões para isso. Uma delas é que os dados relacionados parecem ser impropriamente comportamentais. Uma outra razão é que os clínicos são pessoas extremamente ocupadas e, conseqüentemente, se mostram relutantes em "perder tempo" tentando dominar uma estrutura conceitual nova e diferente, até que tenham fortes razões para acreditar que, com isso, irão aprimorar sua compreensão clínica e sua habilidade terapêutica. Para aqueles que decidiram que já é tempo de verificar o que esta nova perspectiva tem a oferecer, espero que as conferências reunidas aqui possam servir de introdução conveniente.

Índice

✕ 1. O cuidado com as crianças	17
✕ 2. As origens da teoria do apego	33
3. Psicanálise como arte e ciência	49
4. Psicanálise como ciência natural	66
✕ 5. Violência na família	82
✕ 6. Saber o que você não deve saber e sentir o que você não deve sentir	100
✕ 7. O papel do apego no desenvolvimento da personalidade	117
✕ 8. Apego, comunicação e o processo terapêutico	133
Referências	150
Índice de nomes	164
Índice de assuntos	168

Conferência 1✓

O cuidado com as crianças

Durante os primeiros meses de 1980, estava proferindo conferências nos Estados Unidos da América. Entre os convites que me chegaram, um foi da equipe de psiquiatria do Hospital Michael Reese, em Chicago, para que eu desse uma conferência sobre "paternalidade".

Um papel social indispensável

Acredito que em alguns momentos de suas vidas, a maioria dos seres humanos deseja ter filhos e que seus filhos cresçam saudáveis, felizes e autoconfiantes. Para aqueles que o conseguem, as recompensas são grandes; mas para os que têm filhos e fracassam em ajudá-los a se tornarem saudáveis, felizes e autoconfiantes, as penalidades em termos de ansiedade, frustração, atritos e, talvez, vergonha e culpa, podem ser severas. Portanto, ter um filho e cuidar dele é apostar alto. Mais do que isto — um cuidado bem-sucedido é a chave principal para a saúde mental da geração seguinte. Portanto, precisamos conhecer não só a natureza de um cuidado bem-sucedido mas, também, as inúmeras condições sociais e psicológicas que influenciam, positiva ou negativamente, o seu desenvolvimento. O tema é extenso e tudo que posso fazer nesta contribuição é rascunhar a abordagem que eu mesmo adoto ao pensar sobre o assunto. Essa abordagem é etológica.

Entretanto, antes de entrar em detalhes, quero assinalar alguns pontos gerais. Ser um pai ou uma mãe bem-sucedidos significa muito trabalho árduo. Cuidar de um bebê ou de uma criança que já engatinha é uma tarefa

que toma 24 horas por dia, sete dias por semana e é sempre uma tarefa preocupante. E mesmo quando essa carga se torna um pouco mais leve, à medida que as crianças crescem e se desenvolvem bem, ainda assim requer muito tempo e atenção. Para muitas pessoas, hoje, essas verdades são desagradáveis. Dar tempo e atenção às crianças significa sacrificar outros interesses e atividades. Acredito não haver dúvidas a respeito da evidência dessas afirmações. Estudos após estudos, incluindo aqueles, em Chicago, tendo Grinker (1962) como pioneiro e que foram continuados por Offer (1969), atestaram que adolescentes e adultos saudáveis, felizes e autoconfiantes são produtos de lares estáveis, nos quais tanto o pai quanto a mãe despendem grande parte do tempo e muito de sua atenção com as crianças.

Quero também enfatizar que, apesar de opiniões contrárias, cuidar de um bebê ou criança não é tarefa para uma só pessoa. Para que essa tarefa seja bem feita e não leve a pessoa que se ocupa basicamente da criança à exaustão, é necessário prestar-lhe uma grande assistência. A fonte de ajuda é variável, freqüentemente vem do parceiro; em muitas sociedades, inclusive mais freqüentemente do que a nossa, essa ajuda vem da avó. Também as adolescentes e as mulheres jovens são solicitadas a cooperar. Na maioria das sociedades, essas verdades foram e ainda são consideradas como ocorrendo naturalmente e as sociedades são organizadas de acordo com isso. Paradoxalmente, as sociedades mais ricas do mundo foram levadas a ignorar essas verdades básicas. A força de trabalho do homem e da mulher, devotados à produção de bens materiais, conta como um ponto a mais em todos os índices da nossa economia. A força de trabalho do homem e da mulher devotados à produção de crianças felizes, saudáveis e autoconfiantes, em seus próprios lares, não conta absolutamente. Nós criamos um mundo de pernas para o ar.

Mas não quero entrar em complexas questões políticas e econômicas. Minha razão para assinalar esses pontos é lembrar que a sociedade em que vivemos não é apenas, em termos evolutivos, um produto do passado, mas, de muitas formas, uma sociedade muito peculiar. Conseqüentemente, existe o enorme perigo de adotarmos normas equivocadas. Pois, assim como uma sociedade onde exista uma insuficiência crônica de alimentos pode considerar um nível inadequado e deplorável de desnutrição como normal, uma outra sociedade onde os pais de crianças pequenas as deixam sozinhas com uma insuficiência crônica de ajuda, também pode considerar este estado normal.

Uma abordagem etológica

Disse, anteriormente, que a minha abordagem para a compreensão do comportamento de cuidados, como uma atividade humana, era etológica. Deixe-me explicar.

Ao reexaminar a natureza da ligação da criança à sua mãe, tradicionalmente referida como dependência, achei útil considerá-la como o resultado de um conjunto distinto, e em parte programado, de modelos de comportamento que, num meio ambiente comum, se desenvolvem durante os primeiros meses de vida e têm por efeito manter a criança mais ou menos próxima de sua figura materna (Bowlby, 1969). No fim do primeiro ano, o comportamento está se tornando ciberneticamente organizado, isto é, entre outras coisas, o comportamento é ativado sempre que certas condições são encontradas. Por exemplo, o comportamento de apego de uma criança é ativado especialmente pela dor, fadiga, qualquer coisa que cause medo e, também, por uma mãe, que seja ou pareça ser, inacessível. As condições que põem fim a este comportamento variam de acordo com a intensidade em que ele surgiu. Numa intensidade baixa, pode ser simplesmente a visão ou o som da mãe, tendo um efeito especial, um sinal que denote a presença dela. Numa intensidade mais alta, o término pode requerer o seu contato ou mesmo estar "grudado" a ela. Na intensidade mais alta, quando a criança está ansiosa, nada será mais eficaz do que um abraço prolongado. A função biológica desse comportamento é postulada como sendo a proteção, especialmente a proteção contra predadores.

Nesses exemplos as pessoas em questão são a criança e sua mãe. No entanto, é evidente que o comportamento de apego não é, de forma alguma, restrito às crianças. Embora seja, em geral, menos prontamente estimulado, nós também podemos observá-lo em adolescentes e adultos de ambos os sexos, quando estão ansiosos ou sob *stress*. Ninguém deveria se surpreender, portanto, quando uma mulher grávida ou uma mãe cuidando de seu bebê tem um forte desejo de ser, ela mesma, cuidada. A ativação do comportamento de apego nessas circunstâncias é, provavelmente, universal e deve ser considerado como uma norma.*

Um traço do comportamento de apego, clinicamente de grande importância e sem considerar a idade do indivíduo em questão, é a intensidade da emoção que o acompanha, o tipo de emoção que surge de acordo com a qualidade da relação entre a pessoa apegada e a figura de apego. Se tudo vai bem, há satisfação e um senso de segurança. Se a relação está ameaçada, existe ciúme, ansiedade e raiva. Se ocorre uma ruptura, há dor e depressão. Finalmente, existe uma forte evidência de que a forma segundo a qual o comportamento de apego de um indivíduo se organiza, depende, em alto grau, dos tipos de experiências que ele teve com sua família de origem ou, se ele não teve sorte, fora dela.

* Um crescente desejo de ser cuidada, tanto pelo marido como pela mãe, foi relatado em estudos de grupos representativos de mulheres por Wenner (1966) e Ballou (1978).

Creio que esse tipo de teoria tem muitas vantagens sobre as teorias até então correntes em nosso campo. Ela não só se aproxima dos dados observados, como é uma estrutura teórica compatível com a adotada na biologia moderna e na neurofisiologia. Creio que o comportamento de cuidados pode ser abordado do mesmo ponto de vista etológico. Isso requer a observação e a descrição do conjunto de modelos característicos do comportamento de cuidados; das condições que ativam e finalizam cada um; das mudanças dos modelos à medida que a criança cresce; das formas variadas que o comportamento de cuidados assume em indivíduos diferentes e do enorme número de experiências que influenciam a forma como ele se desenvolve em cada pessoa.

Está implícito, nessa abordagem, assumirmos que o comportamento de cuidados, como o comportamento de apego, está, em alto grau, pré-programado e pronto para se desenvolver ao longo de certas linhas, quando as condições forem favoráveis. Isso quer dizer que, no curso normal dos acontecimentos, um dos pais de um bebê vivencia uma forte tendência para se comportar de certas formas típicas como, por exemplo, embalar a criança, acalmá-la quando chora, mantê-la aquecida, protegida e alimentada. Claro que tal ponto de vista não implica que os modelos apropriados de comportamento se manifestem completamente em cada detalhe desde o primeiro. Isso, certamente, não ocorre dessa forma nos seres humanos, nem em outras espécies de mamíferos. Todos os detalhes são aprendidos, alguns durante a interação com os bebês e crianças e muitos através da observação de como outros pais se comportam. O processo começa na infância desse futuro pai, na forma como seus pais o trataram e a seus irmãos/irmãs.

Essa nova visão do desenvolvimento comportamental contrasta com os dois paradigmas anteriores, um dos quais, invocando o instinto, superenfatiza o componente pré-programado, e o outro, reagindo contra o instinto, superenfatiza o comportamento aprendido. O comportamento de cuidados nos seres humanos não é, certamente, produto de alguns instintos paternos invariáveis, mas também não é correto considerá-lo um mero produto de aprendizagem. O comportamento de cuidados, como eu o vejo, tem fortes raízes biológicas, o que explica as emoções muito fortes a ele associadas; mas a forma específica que o comportamento toma em cada um de nós é modificada pela nossa experiência — especialmente durante a infância, adolescência, antes e durante o casamento, e com cada criança.

Assim, é útil considerarmos o comportamento de cuidados como um exemplo de uma classe limitada de tipos de comportamento de raízes biológicas, entre os quais o comportamento de apego é um exemplo, o comportamento sexual, outro exemplo, e o comportamento exploratório e o comportamento alimentar, outros. Cada um desses tipos de comportamento contribui, em sua forma específica, para a sobrevivência tanto do indivíduo como de seus descendentes. É justamente porque têm uma função tão vital

que cada um desses tipos de comportamento é, em algum grau, pré-programado. Deixar o seu desenvolvimento sob a responsabilidade dos caprichos da aprendizagem individual seria a maior tolice biológica.

Você perceberá que, ao esboçar essa estrutura, conceituei diferentemente cada um desses tipos de comportamento. Isso, com certeza, contrasta com a teoria tradicional da libido, que os considera expressões variadas de um único impulso. São muitas as razões para manter tal distinção. Uma delas é que cada tipo de comportamento mencionado serve à sua própria função biológica — proteção, reprodução, nutrição, conhecimento do meio ambiente. Uma outra, é que muitos dos modelos detalhados de comportamento em cada tipo geral são também distintos: “se grudar” a um dois pais é diferente de consolar e confortar uma criança; sugar ou mastigar um alimento é diferente de se envolver num intercurso sexual. Além disso, os fatores que influenciam o desenvolvimento de um desses tipos de comportamento não são necessariamente os mesmos que influenciam o desenvolvimento dos outros. Ao mantê-los distintos, nós não só ficamos aptos a estudar as formas nas quais eles diferem, mas, também, a estudar as formas nas quais eles coincidem e interagem uns com os outros — o que, evidentemente, ocorre.

O início da interação mãe-filho

Na década passada tivemos um notável avanço em relação à compreensão sobre as fases iniciais da interação mãe-filho, graças à pesquisa imaginativa de estudiosos dos dois lados do Atlântico. Os trabalhos de Klaus e Kennel são bastante conhecidos agora. Suas observações a respeito de como as mães se comportam com seus bebês, logo após o parto, quando lhes é permitida inteira liberdade de ação, são de especial interesse aqui. Klaus, Trause e Kennel (1975) descrevem como uma mãe, imediatamente após o nascimento de seu bebê, levanta-o e começa a acariciar o seu rosto com a ponta dos dedos. Ao fazê-lo, o bebê se aquieta. Logo, ela começa a tocar sua cabeça e seu corpo com a palma de sua mão e, em cinco ou seis minutos, ela tende a colocá-lo em seu peito. O bebê responde com prolongadas lambidas no bico do seio. “Imediatamente depois do parto”, eles observaram, “as mães parecem em estado de êxtase” e, bastante interessante, os observadores também ficaram deslumbrados. Desde o momento em que o bebê nasce, toda a atenção se volta para ele. Tudo que se refira ao bebê tende a chamar a atenção não só da mãe e do pai, mas, também, de todos os que estiverem presentes. Se lhe for permitido, a mãe tende a passar alguns dias olhando, horas e horas, para sua nova “possessão”, embalando-o e conhecendo-o. Normalmente, chega um momento em que ela sente que o bebê é ela própria. Para alguns, esse momento chega muito cedo, talvez quando o segura pela primeira vez ou quando olha pela primeira vez em seus olhos.

Entretanto, para um certo número de primíparas, que tiveram seu filho em hospital, isso pode ocorrer apenas uma semana após, freqüentemente depois que voltam para casa (Robson & Kumar, 1980).

As pesquisas mais recentes têm dedicado atenção a fenômenos da maior importância, como: o potencial do neonato para estabelecer uma forma elementar de interação social e o potencial da mãe comum, sensível, para participar com sucesso dessa interação.*

Quando uma mãe e seu filho de duas ou três semanas estão se olhando, fases de intensa interação social se alternam com fases de desengajamento. Cada fase de interação começa com um cumprimento inicial mútuo e continua com uma animada troca composta de expressões faciais e vocalizações, durante as quais a criança se direciona para a mãe com movimentos excitados dos braços e das pernas. Depois, suas atividades diminuem e terminam com o bebê desejando um período de tempo, antes que a nova fase de interação comece. Durante esses ciclos, o bebê tende a ser tão espontaneamente ativo quanto sua mãe. Os papéis diferem quanto ao *timing* de suas respostas. Considerando que a interação de uma criança e a sua interrupção tendem a seguir o seu próprio ritmo, autônomo, uma mãe sensível regula seu comportamento de forma a que se harmonize com o de seu bebê. Além de regular, ela também modifica seu comportamento para se adaptar ao do bebê: sua voz é gentil, porém num tom mais agudo do que o normal, seus movimentos são mais vagarosos e cada ação subsequente é ajustada, tanto em relação à forma quanto ao *timing* com que o bebê atua. Assim, ela permite que ele puxe a canção e, pela habilidade em tecer suas respostas com as do bebê, cria um diálogo.

A velocidade e eficiência com que esses diálogos se desenvolvem e a satisfação mútua que eles geram mostram claramente a pré-adaptação de cada participante para essa troca. Por um lado, é a presteza da intuição materna para permitir que suas intervenções sejam palmilhadas pelo bebê. Por outro lado, é a presteza com que a criança modifica gradualmente seu ritmo, ajustando-o ao *timing* das intervenções de sua mãe. Numa parceria, que se desenvolve de maneira feliz, cada um está se adaptando ao outro.

Seqüências alternadas muito semelhantes foram registradas em outros tipos de trocas entre mãe e filho. Por exemplo, Kaye (1977), observando o comportamento da mãe e da criança durante a alimentação, descobriu que a

* Ver, em especial, o trabalho de Stern (1977), Sander (1977), Brazelton, Koslowski e Main (1974) e Schaffer (1977). Para uma excelente revisão, veja Schaffer (1979) e Stern (1985). O estado de sensibilidade aumentada, que se verifica numa mulher durante e especialmente próximo ao fim da gestação e que a capacita a "se adaptar delicada e sensitivamente" às necessidades de seu bebê, é um processo para o qual Winnicott (1975) chamou a atenção.

mãe tende a interagir com seu bebê em sincronia precisa com o modo de a criança sugar e descansar. Durante a sucção, a mãe fica geralmente quieta e inativa, durante as pausas, ela embala e conversa com ele. Outro exemplo de como a mãe observa o que o seu bebê faz é relatado por Collis e Schaffer (1975), no caso de uma criança observada entre os cinco e doze meses. A mãe e seu bebê são levados a um local onde existem muitos brinquedos coloridos, que rapidamente lhe despertam a atenção visual. A observação do comportamento deles mostra duas coisas: primeiro, como uma regra, os dois parceiros olham o mesmo objeto ao mesmo tempo. Em segundo lugar, o exame do *timing* mostra, quase invariavelmente, que o bebê lidera e a mãe o segue. O interesse espontâneo do bebê pelos brinquedos é evidentemente monitorizado * pela mãe que, quase automaticamente, o segue olhando na mesma direção. Estabelecendo-se um foco de interesse mútuo, a mãe tende a elaborá-lo, dando opiniões sobre os brinquedos, nomeando-os e manipulando-os. "Houve, portanto, a eclosão de uma experiência partilhada, instigada pela ação espontânea da criança no meio ambiente, mas estabelecida pela mãe que permite que ela seja palmilhada pelo bebê".

Um outro exemplo, também relatado por Schaffer (Schaffer, Collis e Parsons, 1977), se refere à troca vocal entre a mãe e a criança em nível pré-verbal. Numa comparação entre dois grupos de crianças de doze e vinte e quatro meses, descobriu-se que a habilidade desse par em trocar e em evitar se sobrepor, não foi somente inteiramente eficiente como também uma característica das crianças mais jovens e das mais velhas. Então, muito antes da aparição das palavras, o modelo de tal variação tão característico da conversa humana já está presente. Aqui, novamente, a evidência sugere que cabe à mãe o maior papel na tarefa de garantir transições leves de um *speaker* para outro.

Sou motivado a dar esses exemplos, por acreditar que eles ilustram alguns princípios básicos tanto sobre o comportamento de cuidados, quanto sobre a natureza da criatura que é cuidada. Esses estudos evidenciam que a mãe sensível comum entra rapidamente em sintonia com o ritmo natural de seu bebê e, por estar atenta aos detalhes de seu comportamento, descobre o que mais lhe agrada e se comporta de modo a satisfazê-lo. Ao fazê-lo, ela não somente o torna feliz como, também, obtém a sua cooperação. Porque, embora inicialmente a capacidade de adaptação do bebê seja limitada, não é de todo ausente e se for permitido que ele cresça em seu devido tempo, logo o bebê estará dando recompensas. Mary Ainsworth e seus colegas perceberam que as crianças cujas mães tinham respondido de modo sensível a seus sinais durante o primeiro ano de vida, não apenas choravam menos durante a segunda metade desse ano do que os bebês de mães que deram menos

* N. T. O termo "monitorizado" se refere a controle, à orientação e guia.

respostas, como, também, desejavam mais atender aos desejos dos pais (Ainsworth *et al.*, 1978). Podemos seguramente concluir que os bebês humanos, como os bebês de outras espécies, são pré-programados para se desenvolverem de uma forma socialmente cooperativa; se isso ocorre ou não depende do modo como são tratados.

Este ponto de vista da natureza humana difere radicalmente da visão, por muito vigente, nas sociedades ocidentais e que marcou tanto a teoria clínica como a prática que herdamos. Certamente, o nosso enfoque aponta para uma concepção radicalmente diferente do papel dos pais.

O papel das mães e dos pais: semelhanças e diferenças

Nos exemplos dados até agora, o foco de atenção tem sido a mãe. Isso é quase inevitável, porque, para propósitos de pesquisa, é relativamente fácil obter amostras de crianças que estão sendo cuidadas basicamente pela mãe, enquanto crianças cuidadas principalmente pelos pais são, comparativamente, raras. Deixe-me, entretanto, descrever, de forma sucinta, um dos vários estudos recentes que procura equilibrar essa questão.

Centenas de crianças foram estudadas em situações artificiais elaboradas por Mary Ainsworth (Ainsworth *et al.*, 1978), o que permitiu observar como as crianças respondem, primeiro, na presença dos pais, depois, quando são deixadas sozinhas e, mais tarde, quando seus pais retomam. Essa observação permitiu classificar as crianças tendo em vista o seu modelo de apego. Verificou-se a existência de crianças com um modelo de apego seguro à mãe e outras que apresentavam uma das duas formas principais de apego inseguro à sua mãe. Como esses modelos mostraram ter uma estabilidade considerável durante os primeiros anos de vida, pode-se prever de que forma uma criança de creche-escola, na faixa de quatro anos e meio a seis anos, vai abordar uma nova pessoa e lidar com uma nova tarefa (Arend, Gove & Sroufe, 1979). A importância desse procedimento, como um método de avaliação do desenvolvimento social e emocional da criança, não precisa ser enfatizada.

Até agora, quase todos os estudos usando esse procedimento levaram à observação de crianças com suas mães. Main e Weston (1981), entretanto, ampliaram o trabalho ao observarem sessenta crianças, primeiro, com um dos pais e, seis meses mais tarde, com o outro. Descobriu-se que, quando vistas como um grupo, os modelos de apego das crianças em relação aos pais assemelhavam-se muito aos modelos apresentados em relação às mães, havendo aproximadamente a mesma percentagem de distribuição dos modelos. Mas, houve uma segunda descoberta ainda mais interessante. Quando foram examinados os modelos apresentados por cada criança individualmente, não foi encontrada nenhuma correlação entre o modelo que ela apresentava

com um dos pais e o que ela apresentava com o outro. Assim, uma criança pode ter um relacionamento seguro com a mãe e não com o pai, ou outra pode tê-lo com o pai mas não com a mãe, uma terceira pode ter esse tipo de relacionamento com ambos e uma outra pode não o ter nem com um nem com outro. No que se refere à abordagem de novas pessoas e novas tarefas, as crianças apresentaram uma série gradual de modelos. As que tinham um relacionamento seguro com os dois pais eram as mais confiantes e competentes; as que não o tinham com nenhum dos dois eram as menos confiantes e aquelas com relacionamento seguro com um dos pais, mas não com o outro, ficavam no meio. Como já está provado que o modelo de apego que uma criança não traumatizada no nascimento desenvolve em relação à sua mãe é produto de como essa mãe a trata (Ainsworth *et al.*, 1978) é mais do que provável, de forma semelhante, que o modelo que ela desenvolve com seu pai seja o resultado de como seu pai a trata.

Esse estudo, junto com outros, sugere que um pai, sendo a figura de apego para uma criança, pode estar preenchendo um papel que se assemelha muito ao preenchido pela mãe, embora na maioria das culturas, se não em todas, os pais preencham esse papel com muito menos frequência do que as mães, pelo menos quando as crianças ainda são pequenas. Na maioria das famílias com crianças pequenas, o papel do pai é diferente. Ele tende, mais do que a mãe, a se engajar em atividades físicas e a dramatizar histórias e se torna o companheiro preferido de brincadeiras do filho, principalmente quando se trata de um menino.*

Promovendo uma base segura

Isto me traz a um ponto central do meu conceito de comportamento de cuidados — a provisão, por ambos os pais, de uma base segura a partir da qual uma criança ou um adolescente podem explorar o mundo exterior e a ele retornar certos de que serão bem-vindos, nutridos física e emocionalmente, confortados se houver um sofrimento e encorajados se estiverem amedrontados. Essencialmente, estar disponível, pronto para responder quando solicitado, para encorajar e, talvez, dar assistência, porém só intervindo ativamente quando for claramente necessário. É um papel semelhante ao de um oficial que comanda uma base militar da qual parte uma força expedicionária e para a qual ela pode voltar caso se depare com um impedimento. Na maior parte do tempo, o papel da base é estar pronta para ajudar, mas não é esse, no entanto, o seu papel vital. Porque o comandante da força expedicionária só ousa ir avanti e correr riscos, quando confia na segurança de sua base.

* Estudos recentes e relevantes são os de Lamb (1977), Parke (1979), Clarke-Stewart (1978) e Mackey (1979).

No caso de crianças e adolescentes, nós os vemos, à medida que crescem, se aventurando firmemente, cada vez mais, longe da base e por espaços de tempo cada vez maiores. Quanto mais confiantes eles são de que suas bases são seguras e estão prontas para responder quando necessário, mais eles podem se aventurar. Se um dos pais adoece ou morre, o imenso significado da base para o equilíbrio emocional da criança, do adolescente ou do adulto jovem se torna, imediatamente, evidente. Como já assinala, há inúmeras provas obtidas em estudos cuidadosos de adolescentes e adultos jovens, assim como de crianças em fase escolar de idades diversas — da creche-escola em diante — de que os emocionalmente mais estáveis e que aproveitam ao máximo as oportunidades são aqueles cujos pais, ao mesmo tempo em que encorajam a autonomia de seus filhos, estão disponíveis e prontos a responder quando requisitados. Infelizmente, o contrário também é verdade. Nem a mãe nem o pai estarão aptos a prover uma base segura para seu filho em crescimento, se não tiverem uma compreensão intuitiva e respeito pelo que chamo de comportamento de apego da criança, e não o considerarem uma parte intrínseca e valiosa da natureza humana, como eu acredito que seja. E aqui fica evidente a influência negativa do tradicional conceito de dependência. Dependência encerra sempre uma conotação pejorativa e tende a ser considerada uma característica dos primeiros anos apenas, devendo desaparecer com o crescimento. Conseqüentemente, no círculo clínico, tem acontecido freqüentemente, sempre que o comportamento de apego se manifesta nos anos posteriores, ser considerado lamentável e apelidado de regressivo. Eu creio que isto seja um terrível mal-julgamento.

Ao discutir o comportamento de cuidados, focalizei o papel dos pais de oferecer a uma criança uma base segura, porque, embora intuitivamente bastante reconhecido, esse papel tem sido, até então, conceitualizado inadequadamente. Mas existem, é claro, muitos outros papéis que os pais têm que desempenhar. Um deles é o de influenciar o comportamento de seu filho em uma ou outra direção, o que envolve o uso de uma variedade de técnicas. Embora algumas dessas técnicas sejam necessariamente restritivas e algumas outras tenham um intuito disciplinar, muitas são do tipo encorajador. Chamar a atenção da criança para um brinquedo ou algum aspecto do meio ambiente, ou dar uma ajuda na resolução de um problema, que ela não pode resolver sozinha, são alguns exemplos. O repertório de técnicas usadas varia enormemente de pais para pais — de grande ajuda e encorajamento até muitas restrições e punições. Um interessante estudo, da variação das técnicas usadas por pais de bebês que engatinham, foi feito por Scheffer e Crook (1979) na Escócia.

Condições peri e pós-natal que ajudam ou atrapalham

Meu objetivo, até agora, nesta conferência, tem sido o de descrever algumas das formas observadas do comportamento de cuidados de pais de crianças que se desenvolveram bem, social e emocionalmente. Felizmente, muito desse comportamento é natural em muitas mães e pais, que sentem como agradável e recompensadora a interação com seus filhos. Ainda assim, é evidente que, mesmo quando as condições sociais e econômicas são favoráveis, esses relacionamentos mutuamente satisfatórios não ocorrem em todas as famílias. Vamos então considerar aquilo que sabemos das condições psicológicas que ajudam e das que impedem essa interação feliz.

Em vários pontos, eu me referi à mãe sensível, comum, que se harmoniza com as ações e sinais de seu filho, que responde a esses sinais e ações com uma certa adequação e que está apta a detectar em seu filho os efeitos do seu comportamento e a modificá-lo no que for necessário. A mesma descrição, sem dúvida, se aplicaria ao pai sensível, comum. É claro que para que um dos pais se comporte dessa forma é necessário um tempo adequado e uma atmosfera relaxada. Por isso, um dos pais, principalmente a mãe que normalmente é quem agüenta a parte mais árdua dos cuidados com o filho durante os primeiros meses ou anos, precisa de toda ajuda possível - não em relação aos cuidados com o bebê, que é sua tarefa, mas em todas as tarefas domésticas.

Uma amiga minha, antropóloga social, observou que nas ilhas dos Mares do Sul, onde ela estava trabalhando, era costume a ajuda à futura mãe durante e após o nascimento do seu bebê por parte de duas mulheres da família que cuidavam das tarefas domésticas desde o primeiro mês, deixando-a livre para cuidar de seu bebê. Minha amiga ficou tão impressionada com esses arranjos, que quando seu próprio bebê nasceu na ilha, ela aceitou ser cuidada dessa forma VIP e não teve motivo para arrependimentos. Além da ajuda prática, a companhia de uma outra mulher tende a oferecer à nova mãe um suporte emocional ou, na minha terminologia, oferecer-lhe o tipo de base segura de que todos nós precisamos em condições de stress e sem a qual é difícil relaxar. Em quase todas as sociedades, um arranjo desse tipo é a regra. Na verdade, nas cento e cinquenta culturas estudadas pela antropóloga, com exceção de uma, um membro da família ou uma pessoa amiga, normalmente uma mulher, permanecem com a mãe durante o trabalho de parto e o parto propriamente dito (Raphael, 1966, repetido por Sosa *et al.*, 1980).

Voltando à nossa própria sociedade, descobertas preliminares - que, se confirmadas, são do maior interesse e importância prática - foram recentemente relatadas pelo grupo de Klaus e Kennell, que dirigiram um estudo num hospital maternidade na Guatemala (Sosa *et al.*, 1980). Um grupo de mulheres entrou em trabalho de parto e no parto propriamente

dito; de acordo com a prática de rotina da unidade, foram deixadas sozinhas a maior parte do tempo. Um outro grupo recebeu um suporte amigo, constante, por parte de uma mulher leiga e sem treinamento desde a admissão no hospital até o final do parto - uma mulher durante o dia e outra à noite. No grupo que recebeu essa ajuda, o trabalho de parto demorou menos da metade do tempo do outro; 8,7 horas contra 19,3*. Além disso, a mãe permaneceu acordada na maior parte da primeira hora de vida de seu filho, durante a qual era possível vê-la embalando-o, sorrindo e falando com ele.

Resultados semelhantes a esse são, hoje em dia, bastante conhecidos, sempre que a mãe pode ter um contato adicional com seu bebê logo após o parto. Entre as diferenças observadas por Klaus e Kennell, quando os bebês tinham um mês de idade, verificou-se que a mãe que tivera esse contato extra tendia mais a confortar seu bebê durante as estressantes visitas clínicas, a acariciá-lo e a trocar olhares com ele durante a alimentação. Diferenças desse mesmo porte foram observadas quando os bebês tinham doze meses e, novamente, aos dois anos. Nesses estudos, o aumento do contato foi de uma hora extra nas primeiras três horas após o nascimento, com posteriores cinco horas de contato, cada tarde, nos três dias seguintes (Kennel *et al.*, 1974; Ringler *et al.*, 1975).**

As descobertas baseadas num outro estudo sobre o papel que esses tipos de experiências peri e pós-natal desempenham, tanto em dar assistência à mãe para que ela desenvolva um relacionamento de amor e sensibilidade com seu bebê, como para impedi-lo, são relatadas por Peterson e Mehl (1978). Num estudo longitudinal de quarenta e seis mulheres e seus maridos, entrevistados e observados durante a gravidez, trabalho de parto e em quatro ocasiões durante os seis primeiros meses do bebê, a variável mais significativa, predizendo diferenças nos laços maternos, era a extensão de tempo em que a mãe tinha permanecido separada de seu bebê, durante as horas e os dias após o seu nascimento. Outras variáveis que tinham um papel significativo, embora menor, eram a experiência de nascimento e as atitudes e expectativas expressas pela mãe durante a gravidez.

*Num estudo posterior e mais amplo, também ocorrido na Guatemala e pelo mesmo grupo de pesquisadores, todas as descobertas se repetiram. Amostras de duzentas e setenta e nove mulheres no grupo de rotina de cento e oitenta e seis no grupo de suporte. Não só o trabalho de parto, como também as complicações perinatais foram reduzidas à metade (Klaus *et al.*, 1986).

** Já que muitos estudos recentes, e.g., Svejda, Campos e Emde (1980), fracassaram em repetir as descobertas iniciais dos efeitos do contato inicial mãe-filho, o assunto permanece em dúvida. Pode ser que nessa área sensível, os detalhes de como e por quem esse contato inicial ocorre possam explicar as discrepâncias.

A influência das experiências da infância dos pais

Existem, certamente, muitas provas clínicas de que o sentimento e o comportamento da mãe em relação a seu bebê são também profundamente influenciados por suas experiências pessoais prévias, especialmente as que teve e talvez ainda esteja tendo, com seus próprios pais; e, embora a prova dessa influência em relação às atitudes do pai sejam menos abundantes, as que dispomos nos dirigem claramente para a mesma conclusão.

Os estudos sistemáticos de crianças jovens evidenciam claramente este fato. A influência exercida pelos pais, no desenvolvimento do modelo de cuidados de seus filhos, começa muito cedo. Por exemplo, Zahn-Waxler, Radke-Yarrow e King (1979) descobriram que ajudar e confortar na aflição é um modelo de comportamento que se desenvolve comumente no segundo ano de vida da criança e, mais ainda, que a sua forma é muito influenciada pela maneira como a mãe trata seu filho. As crianças, cujas mães respondem com sensibilidade a seus sinais e fornecem um contato corporal reconfortante, são as que respondem mais rápida e apropriadamente à aflição dos outros.*

Além disso, freqüentemente, o que a criança faz em tais circunstâncias é uma réplica clara do que ela viu sua mãe fazer ou do que ela própria vivenciou com a mãe. Observar um grupo de crianças que apresentaram essas diferenças iniciais seria de grande interesse.

Uma outra linha de estudos, referente à influência da experiência infantil nos cuidados da mulher com seu filho, vem de pesquisas feitas em Londres. Por exemplo, um estudo de Frommer e O'Shea (1973) mostra que mulheres que, durante a gravidez, contaram uma história de separação de um ou de ambos os pais, antes de onze anos, tendem a ter, especialmente, dificuldades matrimoniais e psicológicas após o nascimento de seus filhos, além de relatarem, também, problemas com a alimentação e o sono de seus bebês. Um outro estudo, feito também em Londres por Wolkind, Hall e Pawlby (1977), aplica essa descoberta mostrando que mulheres, com esse tipo de história na infância, interagem significativamente menos com filhos de cinco meses de idade do que as mulheres que tiveram infâncias mais felizes. Essas observações, feitas por um etólogo, duraram o tempo necessário para registrar cinquenta minutos da vida desperta do bebê, não considerando o tempo gasto com sua alimentação. Para isso, foi necessário que o pesquisador observasse toda a manhã. As mães, originariamente separadas

* O papel do contato físico com a mãe durante a infância foi estudado especialmente por Ainsworth. Ela descobriu que as crianças que desenvolvem um apego seguro à mãe são as que, durante a primeira infância, foram mantidas no colo por mais tempo e de forma muito amorosa (Ainsworth *et al.*, 1978).

de suas famílias, não só passavam, em média, duas vezes mais tempo longe da vista de suas crianças como, também, no contato com seu bebê despendiam menos tempo segurando-o, olhando-o e falando com ele. Além disso, quando lhes era feita a pergunta: "Você já sente que começa a ver o seu bebê como uma pessoa?" as mães separadas de suas famílias tendiam muito menos a dizer que sentiam (Hall, Pawlby & Wolkind, 1979). O que desejo enfatizar aqui, entretanto, é que os estudos já oferecem firmes provas de que as mulheres cujas infâncias foram perturbadas tendem a uma interação menor com seus filhos do que as que tiveram infâncias felizes - num período da vida do bebê em que o montante da interação é basicamente determinado pela mãe.

Algumas das provas mais claras, relativas ao forte peso das experiências da infância na determinação, anos mais tarde, do modo como um dos pais trata seu filho, surgem dos estudos de pais dos quais se sabe que abusam fisicamente de seus filhos (Parke e Collmer 1979). Um quadro comum inclui uma infância na qual o cuidado dos pais era, na melhor das hipóteses, errado e, na pior, ausente; as críticas e as culpas eram freqüentes e amargas e os pais ou os padrastos se comportavam violentamente nas suas relações mútuas e, algumas vezes, embora nem sempre, na relação com as crianças. Um traço emergente de um estudo de DeLozier, de mães que abusam fisicamente de seus filhos (o estudo está descrito em detalhes na Conferência 5), é que, quando crianças, grande parte delas tinha vivido em constante pavor de que um ou ambos os pais se ausentassem e, conseqüentemente, elas fossem mandadas para uma outra casa ou instituição, além de viverem freqüentemente ameaçadas com pancadas violentas ou coisa pior. Não era surpreendente que essas meninas tivessem crescido perpetuamente ansiosas, temendo que seus maridos ou namorados se ausentassem, considerando a violência física como algo natural e esperando muito pouco ou nenhum amor ou ajuda de qualquer fonte.

Nem toda mulher, com experiências infantis desse tipo, bate em seus filhos; tampouco uma mulher, que abusa fisicamente de um de seus filhos, o fará necessariamente com os outros. O que ocasiona essas diferenças? As provas sugerem que as mulheres fortemente inclinadas, devido a experiências anteriores, a manifestar atitudes maternas desfavoráveis, têm uma sensibilidade maior ao que acontece com elas durante e após o nascimento de seus bebês. Parece que, para essas mulheres, experiências adversas durante esse período podem significar a gota d'água.

Num estudo feito em Oxford, por exemplo, Lynch (1975) comparou as histórias de vinte e cinco crianças, que tinham sofrido abusos físicos, com as de seus irmãos, que nada tinham sofrido. As crianças, que sofreram abuso, eram, numa proporção significativamente maior do que seus irmãos, fruto de uma gravidez, trabalho de parto ou parto propriamente dito anormais, além de terem sido separadas de suas mães por quarenta e oito horas, ou mais,

logo após o nascimento e de terem vivenciado separações de outros tipos durante os primeiros seis meses de vida. Durante o primeiro ano de vida, essas crianças tendiam muito mais a ficar doentes do que seus irmãos, que não tinham sofrido abusos; e as mães, também, tendiam a adoecer mais durante o primeiro ano de vida do filho que sofrera abusos, do que no primeiro ano dos irmãos. Já que, nesse estudo, as personalidades e as histórias das infâncias dos pais eram as mesmas — tanto para crianças que sofreram abusos, quanto para os irmãos que não sofreram — o destino de cada um parece decorrente, em grande parte, das experiências da mãe com a criança durante o período perinatal e o início do pós-natal. As descobertas de Cater e Easton (1980) apontam para a mesma conclusão.*

De todos os outros modelos de perturbação do comportamento de cuidados que podem ser descritos, pelo menos em parte, como decorrentes de experiências da infância, existe um bem documentado em estudos de abusos maternos (e.g., Morris & Gould, 1963; Steele & Pollock, 1968; Green, Gains & Sandgrun, 1974; DeLozier, 1982). Essa perturbação se caracteriza pela tendência das mães em esperar e requisitar cuidado e atenção de seus próprios filhos, ou seja, pela tendência de inverter o relacionamento. Durante a entrevista elas descreveram como, em crianças, tinham se sentido responsáveis pelo cuidado de seus pais, ao invés de os pais terem cuidado delas.

A maioria dos pais, ou talvez todos, que esperam que seus filhos cuidem deles, vivenciaram, em criança, cuidados muito inadequados. Infelizmente, então, muito freqüentemente, eles criam problemas psicológicos maiores para seus filhos. Em outro artigo (Bowlby, 1973, 1980), assinala-se que uma inversão da relação pais-filhos desse tipo está por trás de uma proporção significativa de casos de inadaptação à escola (escolafobia)** e agorafobia e, provavelmente, de depressão também.

A melhor forma de ajuda

Nessa conferência, dei especial atenção àquilo que conhecemos sobre comportamento de cuidados bem-sucedido e a algumas variáveis que facilitam ou dificultam os jovens e as jovens a se tornarem pais cuidadosos e sensíveis. Em consequência, estou apto a refletir um pouco sobre os muitos e variados

* Ao interpretar as descobertas desses dois estudos é necessária uma certa precaução, porque em nenhum estudo há a certeza de que, em todos os casos, a mãe da criança é quem comete o abuso.

** N.T. Tradução literal de "scholl phobia".

modelos de comportamento de cuidados distorcidos e deficientes com que nos deparamos clinicamente. Outro tema omitido diz respeito à melhor forma de ajudarmos os jovens e as jovens a se tornarem pais bem-sucedidos, o que, eu creio, todos desejam. Entretanto, concluindo, deixe-me esclarecer o que eu creio serem os pontos iniciais desse trabalho: que procuremos sempre ensinar pelo exemplo e não pela prescrição; pela discussão e não pela instrução. Quanto mais oportunidades dermos aos jovens de se depararem e observarem, em primeira mão, como os pais sensíveis e zelosos tratam seus filhos, mais eles tenderão a segui-los. Aprender diretamente com esses pais sobre as dificuldades encontradas e as recompensas obtidas, discutir com eles tanto os erros quanto os sucessos, valem, creio eu, por centenas de conversas instrutivas. Para um programa desse tipo, que em alguns lugares pode ser uma extensão dos grupos de auto-ajuda materna, que estão agora começando a florescer, precisaríamos fazer uma lista de cooperação ativa de pais sensíveis e zelosos. Felizmente, existem, ainda, vários deles em nossa sociedade e acredito que muitos desejariam e ficariam orgulhosos em ajudar.

Conferência 2 ✓

As origens da teoria do apego

Na primavera de 1981, a American Orthopsychiatric Association me convidou a ir a New York para receber o prêmio Fourth Blanche Ittleson e para falar aos membros da associação sobre o desenvolvimento do meu trabalho no campo de apego e perda. Depois de agradecer aos membros a honra que estavam me concedendo, aproveitei a oportunidade para expressar minha profunda gratidão a três fundações americanas — a Josiah Macy Junior, a Ford e a Fundação para Fundos e Pesquisas em Psiquiatria, que mantiveram nosso trabalho na Clínica Tavistock durante a década crítica que teve início em 1953.

Depois dessa reunião, o editor do jornal da Associação me pediu que ampliasse as minhas observações, fazendo um relatório sobre o que sabíamos, naquele tempo, sobre o campo que venho explorando, como chegamos a tal conhecimento e quais as direções que as pesquisas futuras podem tomar. Ao responder-lhe, expliquei que não estou na posição de ser um historiador objetivo, num campo que somente agora está deixando de ser controverso e que tudo que eu poderia tentar seria descrever a história, como eu lembro, e alguns estudos empíricos e idéias teóricas que foram de grande influência para moldá-la. Minhas predisposições pessoais, expliquei, serão evidentes em qualquer lugar.

Durante os anos 30 e 40, um certo número de clínicos, dos dois lados do Atlântico, em sua maioria trabalhando independentemente, fizeram observações dos efeitos doentios no desenvolvimento da personalidade, decorrentes de cuidados institucionais prolongados ou de trocas freqüentes da

figura materna durante os primeiros anos de vida. Seguiram-se publicações de influência, incluindo — em ordem alfabética de sobrenomes — Lauretta Bender (Bender e Yarnell, 1941, Bender, 1947) John Bowlby (1940, 1944), Dorothy Burlingham e Anna Freud (1942, 1944), William Goldfarb (1943 a, b e c e seis outros trabalhos sumarizados, 1955), David Levy (1937), e René Spitz (1945, 1946). Já que cada autor era analista qualificado (exceto Goldfarb que fez seu treinamento mais tarde), não causou surpresa o fato de as descobertas terem criado um certo alvoroço fora dos círculos analíticos.

No final de 1949, um jovem e imaginativo psiquiatra britânico, orientado analiticamente e recentemente apontado para ser o chefe de Seção da Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde, interveio. Requisitado para contribuir com as Nações Unidas com um estudo sobre as necessidades de crianças sem lar, Ronald Hargreaves* decidiu escolher um consultor, por um certo período, para fazer um relatório sobre os aspectos da saúde mental concernentes a esse problema e, sabendo do meu interesse nesse campo, me convidou para essa tarefa. Para mim, foi uma oportunidade excelente. Depois de cinco anos como psiquiatra do exército, eu tinha voltado à psiquiatria infantil determinado a explorar, mais profundamente, os problemas com os quais havia começado a trabalhar antes da guerra; e eu já havia escolhido James Robertson como meu primeiro assistente para pesquisas; ele era um assistente social psiquiátrico, recentemente formado, que tinha trabalhado com Anna Freud no Hampstead Nurseries durante a guerra.

Os seis meses que passei com a Organização Mundial de Saúde, em 1950, me deram não só a chance de ler toda a literatura sobre o assunto e discutir com os autores como, também, de encontrar muitos grupos, na Europa e nos Estados Unidos, com experiência no campo. Logo após o fim do meu contrato, submeti meu relatório, que foi publicado no início de 1951, como uma monografia para a Organização Mundial de Saúde, sob o título Cuidados Maternos e Saúde Mental. Neste trabalho, fiz uma revisão sobre a evidência, então disponível, considerada de pouca importância, relativa às influências adversas, no desenvolvimento da personalidade, do cuidado materno inadequado durante a primeira infância; chamei a atenção para o desconforto intenso das crianças pequenas, que se acham separadas daqueles que conhecem e amam e fiz recomendações quanto à melhor forma de evitar, ou pelo menos diminuir, os efeitos maléficos a curto e a longo prazo. Nos anos seguintes, esse relatório foi traduzido para uma série de línguas e também apareceu numa edição barata, em inglês.

Apesar da influência que a palavra escrita possa frequentemente ter, não será como o impacto emocional de um filme. Durante os anos 50, o

*A morte prematura de Ronald Hargreaves, em 1962, quando era professor de psiquiatria em Ledds, foi uma perda dolorosa para a psiquiatria preventiva.

filme de René Spitz — *O sofrimento: um perigo na infância* (1947) e, logo depois, o de James Robertson *Uma criança de dois anos vai para o hospital* (1952) — tiveram, juntos, uma enorme influência. Eles não só chamaram a atenção dos profissionais para o desconforto imediato e a ansiedade de crianças pequenas numa instituição, como provaram ser instrumentos poderosos para promover mudanças na prática. Nesse campo, Robertson teve um papel muito importante (e.g. Robertson 1958, 1970).

Embora, no final dos anos 50, muitos daqueles que trabalhavam com psiquiatria e psicologia infantil e com trabalhos sociais e, também, alguns daqueles na pediatria e na enfermagem de crianças, aceitassem as descobertas das pesquisas e estivessem implementando modificações, a controvérsia aguda, que surgiu com as primeiras publicações e filmes, continuou. Os psiquiatras, treinados em psiquiatria tradicional, e os psicólogos que adotavam uma abordagem da teoria da aprendizagem, jamais pararam de apontar as deficiências de provas e a ausência de uma explicação adequada de como os tipos de experiências implicados poderiam ter os efeitos que eram apontados no desenvolvimento da personalidade. Muitos psicanalistas, especialmente aqueles cujas teorias focavam o papel da fantasia na psicopatologia e a exclusão relativa da influência de fatos na vida real, permaneceram não convencidos e, em alguns momentos, muito críticos. Enquanto isso, as pesquisas continuaram. Por exemplo, em Yale, Sally Provence e Rose Lipton faziam um estudo sistemático de crianças de instituição, no qual comparavam o desenvolvimento destas com o de crianças que viviam em família. Na Tavistock, os membros do meu pequeno grupo de pesquisa estavam ativos, colhendo dados sobre os efeitos, a curto prazo, em uma criança pequena que estivesse sob os cuidados de uma pessoa estranha, em um lugar estranho, por semanas ou até por meses (ver, especialmente, os estudos de Christoph Heinicke, 1956 e Ilse Westheimer, 1966), enquanto eu me direcionei para os problemas teóricos que surgiram desses dados.

O campo continuava mudando continuamente. Uma influência importante foi a publicação, pela Organização Mundial de Saúde, em 1963, de uma coleção de artigos nos quais os vários efeitos dos diversos tipos de experiência cobertos sob a denominação "privação de cuidados maternos" foram reavaliados. Dos seis artigos, o mais completo foi o de minha colega Mary Ainsworth (1962). Nesse artigo, ela faz não somente uma revisão das diversas e extensas evidências, mas, também, considerações sobre os vários aspectos que deram margem à controvérsia, assim como identifica um grande número de problemas que requerem pesquisas posteriores.

Uma segunda importante influência foi a publicação, que teve início no fim dos anos 50, dos estudos de Harlow sobre os efeitos da privação materna dos macacos rhesus; novamente, o filme teve um papel importante. O trabalho de Harlow, nos Estados Unidos, foi estimulado pelos relatórios de Spitz. No Reino Unido, os estudos complementares de Robert Hinde foram

estimulados pelo nosso trabalho na Clínica Tavistock. Na década seguinte, o fluxo de resultados experimentais desses dois cientistas, somando-se à revisão de Ainsworth (ver os sumários em Harlow e Harlow, 1965 e de Hinde e Spencer-Booth, 1971), enfraqueceu a oposição. Entretanto, pouco mais foi dito da inadmissibilidade inerente às nossas hipóteses e as críticas tomaram-se mais construtivas.

Muito, é claro, permaneceu incerto. Mesmo, se a realidade de um desconforto, por um período curto de tempo, e a perturbação comportamental ocorrerem, que prova existe, perguntou-se, de que os efeitos maléficos possam persistir? Que traços da experiência ou combinação de traços são responsáveis por esse desconforto? E se fosse provado ser verdade que em alguns casos os efeitos maléficos persistem, como podem ser explicados? Como podem algumas crianças, tendo passado por experiências muito desfavoráveis, estar relativamente incólumes? Quão importante é para um criança ser cuidada por uma figura zelosa principal na maior parte do tempo? Em sociedades menos desenvolvidas, foi considerado (erradamente) que a maternagem múltipla não é incomum. Somando-se a todas essas questões legítimas, no entanto, existiram alguns mal-entendidos. Alguns supunham e defendiam o ponto de vista de que a criança deveria ser cuidada, na maior parte do tempo, por uma figura materna principal e que essa figura deveria ser a mãe verdadeira da criança — a tão famosa teoria do laço sanguíneo. Outros, supunham que defendendo a tese de que uma criança deveria “experimentar uma relação calorosa, íntima e contínua com sua mãe (ou mãe substituta permanente)”, estariam propondo um regime no qual a mãe teria que cuidar de sua criança vinte e quatro horas por dia, sem descanso. Num campo onde os sentimentos fortes surgem e quase todo mundo tem algum tipo de interesse, ter um pensamento claramente não tendencioso, nem sempre é fácil.

Uma revisão na teoria

A monografia *Cuidados Maternos e Saúde Mental* tem duas partes. A primeira revê as provas relativas aos efeitos adversos da privação materna; a segunda discute os meios de prevenir tais efeitos. O que estava faltando, como vários revisores apontaram, era alguma explicação de como as experiências incluídas sob o amplo título de privação materna poderiam ter efeitos no desenvolvimento da personalidade dos tipos mencionados. A razão para essa omissão era simples: os dados não estavam inseridos em nenhuma teoria até então corrente e, no curto tempo do meu trabalho na Organização Mundial de Saúde, não havia possibilidade de desenvolver uma nova teoria.

O laço da criança à sua mãe

Naquele tempo, era largamente aceito que a razão pela qual a criança desenvolve um forte laço com sua mãe é o fato de que esta a alimenta. Dois tipos de impulso são postulados, primário e secundário. O alimento é tido como primário; a relação pessoal, referida como "dependência", como secundário. Essa teoria não me parecia se adaptar aos fatos. Por exemplo, se isso fosse verdade, uma criança de uma ano ou dois deveria prontamente aceitar quem quer que a alimentasse e isso, claramente, não era o caso. Uma teoria alternativa, da escola húngara de psicanálise, postulava uma relação objetual primitiva desde o início. Em sua versão mais conhecida, aquela defendida por Melanie Klein, o seio materno é postulado como o primeiro objeto e a maior ênfase é dada ao alimento, à oralidade e à natureza infantil de "dependência". Nenhum desses dados coincidiam com minha experiência com crianças. Mas, se as teorias correntes de dependência eram inadequadas, qual era a alternativa?

Durante o verão de 1951, um amigo mencionou o trabalho de Lorenz sobre as respostas de filhotes de patos e gansos. Ler sobre isso e sobre o trabalho relativo ao comportamento instintivo revelou um novo mundo, no qual cientistas de grande valor estavam investigando, nas espécies não humanas, muitos dos problemas com os quais nós estávamos lutando na espécie humana, especialmente as relações relativamente duradouras que se desenvolvem em muitas espécies, primeiro entre os jovens e os pais, e mais tarde entre casais, e algumas das formas nas quais essas relações poderiam se deteriorar. Perguntei a mim mesmo se esse trabalho poderia lançar luz num problema central da psicanálise, que é o "instinto" nos seres humanos.

Em seguida, passei por uma longa fase durante a qual comecei a tentar dominar os princípios básicos e a aplicá-los aos nossos problemas, começando com a natureza do laço da criança à mãe. Nesse ponto, o trabalho de Lorenz sobre a resposta de patinhos e gansinhos (Lorenz, 1935) foi de especial interesse. Ele me mostrou que, em algumas espécies animais, um forte laço com a figura materna poderia se desenvolver sem a mediação do alimento; já que pequenos pássaros não são alimentados por seus pais e sim, alimentam-se sozinhos, agarrando insetos. Aqui estava, então, um modelo alternativo que tinha um certo número de facetas, que pareciam servir ao caso dos seres humanos. Depois, como minha compreensão dos princípios etológicos aumentou e eu os apliquei em vários casos clínicos, me tornei crescentemente confiante de que essa era uma abordagem promissora. Então, tendo adotado esse novo ponto de vista, decidi "seguir no exame de todo material, já que as suas aplicações pareciam ter resultados" (para usar, emprestada, uma frase de Freud).

De 1957, quando *A Natureza do Laço da Criança à Sua Mãe* foi inicialmente apresentado, até 1969, quando *Apego* apareceu e até 1980,

com a publicação de *Perda*, me concentrei nessa tarefa. A estrutura conceitual* resultante é configurada para acomodar todos os fenômenos para os quais Freud chamou atenção, por exemplo, relação de amor, ansiedade de separação, luto, defesa, raiva, culpa, depressão, trauma, separação emocional, períodos sensíveis no início da vida, e, então, oferecer uma alternativa para a metapsicologia tradicional da psicanálise e ainda adicionar uma outra variante às outras tantas variantes da teoria clínica agora existente. Somente o tempo irá provar o sucesso de tais idéias.

Como Kuhn enfatizou, qualquer estrutura conceitual nova é difícil de ser aprendida, especialmente por aqueles que já estão há muito tempo familiarizados com outras anteriores. Descrevo, somente, algumas das muitas dificuldades encontradas na compreensão da estrutura defendida. Uma delas é que, ao invés de começar com uma síndrome clínica dos últimos anos e tentar traçar suas origens retrospectivamente, comecei com uma classe de trauma infantil e tentei traçar suas seqüelas prospectivamente. Uma segunda dificuldade é que, ao invés de começar com os pensamentos e sentimentos particulares de um paciente, expressos no jogo ou na livre associação e tentar construir uma teoria do desenvolvimento da personalidade partindo desses dados, comecei com a observação do comportamento de crianças em certos tipos de situações definidas, incluindo gravações dos sentimentos e pensamentos que elas expressavam e tentei construir uma teoria do desenvolvimento da personalidade partindo desses dados. Outras dificuldades surgiram em relação ao meu uso de conceitos, tais como sistema de controle (ao invés de energia psíquica) e caminho desenvolvimental (ao invés de fase libidinal) que embora hoje em dia estejam firmemente estabelecidos como conceitos-chave em todas as ciências biológicas, ainda são estranhos para o pensamento corrente da maioria dos psicólogos e clínicos.

Tendo descartado o impulso secundário, a teoria de dependência do laço de uma criança à sua mãe e, também, a alternativa kleiniana, a primeira tarefa era formular uma outra para ocupar esse lugar. Isso me levou ao conceito de comportamento de apego, como uma classe especial de comportamento com dinâmica distinta do comportamento de alimentação ou sexo, as duas fontes de motivação humana há muito consideradas como as mais fundamentais. Um suporte de força para esse passo veio logo depois da descoberta de Harlow de que, em outra espécie de primatas — macaco rhesus — os jovens mostram uma preferência marcante por uma "mãe-boneca" macia, apesar de ela não os alimentar, ao invés de uma "mãe-boneca" dura (de arame) que os alimenta (Harlow e Zimmermann, 1959).

O comportamento de apego é qualquer forma de comportamento que resulta em uma pessoa alcançar e manter proximidade com algum outro

*Este é o termo que, agora, Thomas Kuhn (1974) usa no lugar de "paradigma", termo usado por ele em seu trabalho anterior (Kuhn, 1962).

indivíduo claramente identificado, considerado mais apto para lidar com o mundo. Este comportamento é bastante óbvio quando a pessoa está assustada, fatigada ou doente e tenta-se diminuir seu sofrimento com o conforto e o zelo. Em outros momentos, o comportamento é menos evidente. No entanto, o conhecimento de que uma figura de apego está disponível e oferece respostas, fornece um sentimento de segurança forte e de grande extensão e, então, encoraja a pessoa a valorizar e a continuar a relação. Apesar do comportamento de apego ser mais óbvio na primeira infância, ele pode ser observado durante todo o ciclo da vida, especialmente em emergências. Já que ele é visto, virtualmente, em todos os seres humanos (embora variando os modelos), é considerado como uma parte integrante da natureza humana e que nós compartilhamos (numa extensão variada) com membros de outras espécies. A função biológica atribuída ao comportamento é a proteção. Permanecer num ponto de fácil acesso a um indivíduo familiar que se sabe estar pronto e desejando vir nos auxiliar numa emergência é, claramente, uma boa política de segurança, qualquer que seja nossa idade.

Ao conceitualizar o apego dessa maneira, como uma forma fundamental de comportamento, com sua própria motivação interna distinta da alimentação e do sexo, e de igual importância para a sobrevivência, o comportamento e a motivação estão de acordo com um *status* teórico nunca antes dado a eles — embora os pais e os clínicos tenham estado, intuitivamente, por muito tempo, cientes de sua importância. Até agora, os conceitos de “dependência” e “necessidade de dependência” foram usados para se referir a eles, mas esses termos têm sérias desvantagens. Em primeiro lugar, dependência tem um tom pejorativo, em segundo, não sugere uma relação emocional com uma pessoa ou com poucas pessoas claramente preferidas e, em terceiro lugar, nenhuma função de valor biológico foi jamais atribuída a ela.

Já faz trinta anos que a noção de apego foi inicialmente usada como uma maneira útil de conceitualizar uma forma de comportamento de importância central, não só para os clínicos e para os psicólogos do desenvolvimento, mas para todos os pais também. Durante esse tempo, a teoria de apego foi amplamente clarificada e ampliada. Os contribuidores mais notáveis foram Roberto Hinde que, além de sua própria publicação (e.g., 1974), guiou constantemente o meu pensamento e o de Mary Ainsworth que, começando no final dos anos 50, foi pioneira em estudos empíricos do comportamento de apego, tanto na África (1963, 1967) como nos Estados Unidos (Ainsworth e Witting 1969; Ainsworth *et al.*, 1978) e que também ajudou grandemente a desenvolver a teoria (e.g. 1969, 1982). O trabalho dela, juntamente com o de seus alunos e de outros que sofreram sua influência (que se expandiu enormemente desde que essa conferência foi dada e que é descrito, com detalhes, na Conferência 7), levaram a teoria do apego a ser largamente considerada como, provavelmente, a melhor teoria disponível a

dar suporte ao desenvolvimento sócio-emocional (Rajecki, Lamb e Obmascher, 1978; Rutter, 1980; Parkes e Stevenson-Hinde, 1982; Sroufe, 1986).

Já que meu ponto de partida na teoria do desenvolvimento foi a observação do comportamento, alguns clínicos assumiram que a teoria nada mais era do que uma versão do behaviorismo. Esse equívoco se deve, em grande parte, à falta de familiaridade com a estrutura conceitual proposta e, em parte, ao meu próprio fracasso, nas formulações iniciais, em deixar clara a distinção a ser observada entre o apego e o comportamento de apego. Ao falar de uma criança (ou pessoa mais velha), que esteja apegada ou que tenha um apego a alguém, quero dizer que esta pessoa está fortemente disposta a procurar proximidade e contato com esse alguém e a fazê-lo, principalmente, em certas condições específicas. A disposição de se comportar dessa maneira é um atributo da pessoa apegada, um atributo persistente, que se modifica vagarosamente e que não é afetado pela situação do momento. O comportamento de apego, em contraste, se refere a qualquer das várias formas de comportamento, nas quais a pessoa se engaja, de tempos em tempos, para obter ou manter uma proximidade desejada.

Existem provas abundantes de que quase toda criança escolhe habitualmente uma pessoa, usualmente a figura materna, para procurar em situações de desconforto e que, em sua ausência, escolherá outra pessoa, de preferência alguém muito conhecido dela. Nessas ocasiões, a maioria das crianças mostra uma clara hierarquia de preferência que, em casos extremos, não havendo ninguém disponível, até mesmo um estranho gentil poderá ser abordado. Então, enquanto o comportamento de apego pode, em circunstâncias diferentes, ser mostrado a uma variedade de indivíduos, um apego duradouro ou laço de apego é restrito a muito poucos. Uma criança que não tem sucesso em mostrar claramente tal distinção tende a ser severamente perturbada.

A teoria do apego é uma tentativa de explicar tanto o comportamento de apego, com seus aparecimentos e desaparecimentos esporádicos, como, também, os apegos duradouros, que crianças e outros indivíduos estabelecem com outros em especial. Nessa teoria, o conceito-chave é o de sistema comportamental. Ele é concebido em analogia com um sistema fisiológico organizado homeostaticamente, para assegurar que uma certa medida fisiológica, tal como temperatura do corpo ou pressão sangüínea, seja mantida em limites apropriados. Ao propor o conceito de sistema comportamental, para explicar a maneira pela qual uma criança, ou uma pessoa mais velha, mantém relação com sua figura de apego em certos limites de distância ou acessibilidade, nada é feito além de usar esses princípios bem compreendidos para explicar uma forma diferente de homeostase, onde o limite é concernente às relações do organismo com uma pessoa claramente identificada no meio ambiente, ou seja, onde os limites são mantidos pelos meios comportamentais, ao invés dos meios fisiológicos.

Ao postular a existência de uma organização psicológica interna, com um certo número de traços altamente específicos, que incluem modelos representativos do *self* e da(s) figura(s) de apego, a teoria proposta pode ser vista como tendo as mesmas propriedades básicas que caracterizam outras formas de teoria estrutural, das quais a psicanálise é uma das variantes mais conhecidas, o que a diferencia tão agudamente do behaviorismo, em suas formas variadas. Historicamente, a teoria do apego foi desenvolvida como uma variante da teoria das relações objetais.

A razão para eu ter feito tantas considerações sobre o conceito e a teoria do apego é que, uma vez esses princípios aprendidos, existe pouca dificuldade em compreender como os outros tantos fenômenos de importância central para os clínicos são explicados dentro da estrutura proposta.

Ansiedade de separação

Por exemplo, uma nova luz é lançada no problema da ansiedade de separação, quer dizer, ansiedade de perder ou de tornar-se separado de alguém amado. Tem-se considerado um mistério a "mera separação" causar ansiedade. Freud lutou com esse problema e adiantou um certo número de hipóteses (Freud, 1926, Strachey, 1959). Quase todos os analistas importantes fizeram o mesmo. Não possuindo meios para avaliá-lo, muitas escolas de pensamento divergentes proliferaram.

Creio que o problema se encontra na proposição examinada, não só por psicanalistas como também por psiquiatras tradicionais, de que o medo surge numa pessoa mentalmente saudável somente em situações que qualquer pessoa perceberia como intrinsecamente dolorosa ou perigosa, ou que são assim percebidas por uma pessoa, porque ela tornou-se condicionada a tais situações. Já que o medo da separação e da perda não se adapta a esta fórmula, os analistas concluíram que o temido seria, realmente, uma outra situação; e uma grande variedade de hipóteses foram adiantadas.

Entretanto, as dificuldades desaparecem quando é adotada uma abordagem etológica. Dessa forma, torna-se evidente que o homem, assim como outros animais, responde com medo a certas situações, não porque elas possuam um alto risco de dor ou perigo, mas porque elas sinalizam um aumento de risco. Então, assim como animais de muitas espécies, inclusive o homem, estão dispostos a responder com medo a rápidos movimentos ou a modificações marcantes no nível de som ou de luz, porque fazê-lo tem valor de sobrevivência, assim também muitas espécies, inclusive o homem, estão dispostas a responder à separação de uma figura potencialmente zelosa pelas mesmas razões.

Quando a ansiedade de separação é vista sob essa luz, como uma disposição humana básica, estamos somente a um pequeno passo de

compreender porque as ameaças de abandonar uma criança, freqüentemente usadas como meio de controle, são tão aterrorizantes. Tais ameaças, assim como a ameaça de suicídio de um dos pais, são, sabemos agora, causas comuns de intensificada ansiedade de separação. A extraordinária negligência na teoria clínica tradicional é devida, creio eu, não somente a uma inadequada teoria de ansiedade de separação, mas à falha em não dar o peso certo aos efeitos poderosos, em todas as idades, de acontecimentos da vida real.

As ameaças de abandono não só criam intensa ansiedade, elas também fazem surgir a raiva, freqüentemente, em intenso grau, especialmente em crianças mais velhas e adolescentes. Essa raiva, cuja função é dissuadir a figura de apego de continuar a ameaça, pode facilmente tornar-se disfuncional. Creio que, sob essa luz, nós possamos entender o comportamento absurdamente paradoxal do adolescente relatado por Burnham (1965) que, tendo assassinado sua mãe, exclamou: "eu não podia suportar ela ter me deixado".

Outras situações familiares patogênicas são prontamente compreendidas em termos da teoria do apego. Um exemplo bastante comum é o da criança que tem uma relação tão estreita com sua mãe, que apresenta dificuldade em desenvolver uma vida social fora da família — um relacionamento às vezes descrito como simbiótico. Na maioria de tais casos, a causa do problema é a mãe que, tendo crescido ansiosamente apegada como resultado de uma infância difícil, está, agora, procurando fazer de seu próprio filho sua figura de apego. Longe de estar sendo muito indulgente, a criança, como às vezes é reconhecido, está, na verdade, carregando um fardo enorme ao ter que cuidar de sua própria mãe. Então, nesses casos, o relacionamento normal de uma criança apegada a um dos pais zelosos é tido como sendo invertido.

Luto

Enquanto a ansiedade de separação é a resposta usual a uma ameaça ou a algum outro risco de perda, o luto é a resposta usual a uma perda, depois de ela ter ocorrido. Durante os primeiros anos da psicanálise, um certo número de analistas identificavam as perdas ocorridas durante a infância ou mais tarde, como tendo um papel causal na perturbação emocional, especialmente nas desordens depressivas; por volta de 1950, um certo número de teorias sobre a natureza do luto e outras respostas à perda foram adiantadas. Além disso, uma controvérsia muito acentuada já tinha surgido. Essa controvérsia, que começou durante os anos 30, surgiu das teorias divergentes sobre o desenvolvimento da criança, elaborada em Viena e Londres. Exemplos representativos dos diferentes pontos de vista sobre o luto são aqueles expressos por Helene Deutsch em *Ausência do Luto* (1937) e Melanie Klein, em *Luto e sua Relação com os Estados Maníaco-Depressivos* (1940). Enquanto

Deutsch defendia que, devido ao desenvolvimento psíquico inadequado, as crianças não estavam capacitadas ao luto, Klein sustentava que elas não só estavam aptas como assim o faziam. Mantendo-se fiel à sua forte ênfase na alimentação, ela sustentava que o objeto do luto era o seio perdido; além disso, ela atribuía um complexo fantasia-vida à criança. Embora opostas, essas posições teóricas foram, ambas, construídas com a mesma metodologia, quer dizer, pelas interferências sobre as fases iniciais do desenvolvimento psicológico, a partir de observações feitas durante a análise de indivíduos mais velhos e emocionalmente perturbados. Nenhuma das duas teorias foi verificada pela observação direta de como crianças comuns, de idades diferentes, respondem à perda.

Ao abordar o problema prospectivamente, fui levado a conclusões diferentes. Durante o início da década de 50, Robertson e eu tínhamos generalizado a seqüência de respostas observadas em crianças pequenas, durante uma separação temporária da mãe, como protesto, desespero e desapego (Robertson e Bowlby, 1952). Alguns anos mais tarde, lendo um relatório de Morris (1958) sobre como as viúvas respondem à perda do marido, fiquei estarrecido pela semelhança das respostas, que ele havia descrito com aquelas observadas em crianças pequenas. Isso me levou a um estudo sistemático da literatura sobre o luto, especialmente o luto em adultos sadios. A seqüência de respostas que ocorrem comumente, ficou claro, era muito diferente daquela que os clínicos teóricos vinham sustentando. O luto, em adultos mentalmente sadios, não só dura mais do que os seis meses, freqüentemente, sugeridos naquele tempo, como também muitos componentes das respostas, amplamente referidas como patológicas, eram comumente encontrados em lutos sadios. Elas incluem raiva dirigida a terceiros, ao *self* e, às vezes, à pessoa perdida, a descrença de que a perda tenha ocorrido (por engano considerada como uma negação) e uma tendência, freqüentemente, inconsciente, embora nem sempre, a procurar a pessoa perdida na esperança de reencontrá-la. Quanto mais claro se torna o quadro das respostas de luto nos adultos, mais claras ficam as semelhanças das respostas observadas na infância. Essa conclusão, quando apresentada pela primeira vez (Bowlby, 1960, 1961) foi muito criticada, mas agora tem sido amplamente sustentada pelos estudos subseqüentes (e.g. Parkes, 1972; Kliman, 1965; Furman, 1974; Raphael, 1982).

Uma vez que tenha sido obtido um quadro detalhado de um luto sadio, torna-se possível identificar traços que são verdadeiramente indicadores de patologia. Torna-se possível, também, discernir muitas das condições que promovem o luto sadio e aquelas que levam a uma direção patológica. A crença de que as crianças não são aptas ao luto pode, então, ser vista como devida a generalizações feitas a partir de análises de crianças cujo luto tinha seguido um curso atípico. Em muitos casos isso era devido ao fato de a criança nunca ter recebido informação adequada sobre o que tinha acontecido ou

mesmo não havia ninguém que fosse simpático e que ajudasse, gradualmente, o indivíduo a chegar a um acordo sobre sua perda e, em decorrência desse fato, havia o profundo desejo do pai ausente, a raiva e a dor.

Processos defensivos

O próximo passo, nessa reformulação da teoria, foi considerar como os processos defensivos poderiam ser melhor conceitualizados, um passo crucial, já que os processos defensivos sempre estiveram no coração da teoria psicanalítica. Embora, como clínico, eu tenha estado inevitavelmente preocupado com toda a extensão das defesas, como pesquisador dirigi minha atenção, especialmente, à maneira como a criança pequena se comporta frente à sua mãe, depois de um período num hospital ou creche residencial, sem ter sido visitada. Em tais circunstâncias, é comum a criança tratar sua mãe como se ela fosse quase uma estranha; então, depois de um intervalo, normalmente de horas ou dias, a criança torna-se intensamente "grudada", ansiosa, com medo de perdê-la novamente e com raiva. De alguma forma, todos os seus sentimentos por sua mãe e todo o comportamento em relação a ela, nós acreditamos, desapareceram repentinamente (embora mantendo-se dentro de um certo limite e, mais notoriamente, voltando a ela quando com medo ou ferida) - e somente reapareceram depois de um intervalo. Essa foi a condição que Robertson e eu denominamos desapego e que acreditamos ser o resultado de algum processo defensivo, que se opera na criança.

Enquanto Freud, em suas teorizações científicas, ficou restrito a modelos conceituais, que explicassem todos os fenômenos físicos ou biológicos, em termos de disposição de energia, nós, hoje, temos modelos conceituais disponíveis de muito maior variedade. Muitos abordam conceitos, tais como organização, molde e informação, enquanto as atividades significativas de organismos biológicos podem ser concebidas em termos de sistemas de controle estruturados de certas formas. Com suprimento de energia física disponível, esses sistemas tornam-se ativos no recebimento de certos tipos de sinais e inativos no recebimento de sinais de outros tipos. Dessa forma, o mundo da ciência, no qual vivemos, é radicalmente diferente do mundo no qual Freud viveu, na virada do século, e os conceitos disponíveis para nós são imensuravelmente melhor adaptados aos nossos problemas, do que aqueles restritos conceitos disponíveis no seu tempo.

Voltando, então, ao estranho comportamento de desapego, que uma criança pequena apresenta depois de estar por algum tempo em lugar estranho com pessoas estranhas, o que certamente se mostra peculiar é a ausência do comportamento de apego em circunstâncias nas quais nós, certamente, esperaríamos observar. Mesmo quando seriamente ferida, essa criança não mostra nenhum sinal de busca de conforto. Assim, os sinais, que

normalmente ativariam o comportamento de apego, estão falhando. Isso sugere que, de alguma forma e por alguma razão, esses sinais não estão conseguindo alcançar o sistema comportamental responsável pelo comportamento de apego, que eles estão sendo bloqueados e que o sistema comportamental, dessa forma, está imobilizado. Isto significa que um sistema que controla tal comportamento crucial, como o de apego, pode em certas circunstâncias ser considerado, temporária ou permanentemente, incapaz de ser ativado e toda a gama de sentimentos e desejos, que normalmente o acompanham, podem ser considerados como impossibilitados de estimulação.

Ao considerar de que forma essa desativação poderia ocorrer, eu me voltei para o trabalho dos psicólogos cognitivos (e.g., Norma, 1976; Dixon, 1971, 1981) que, durante os últimos vinte anos, revolucionaram nossa compreensão de como percebemos o mundo e como construímos as situações nas quais nos encontramos. Essa revolução, na teoria cognitiva, não só confere aos processos mentais inconscientes o lugar central na vida mental que os analistas sempre reclamaram, como apresenta um quadro de aparato mental, como apto a encerrar um suprimento de informações de certo tipo específico e de fazê-lo seletivamente, sem que a pessoa se dê conta do que está acontecendo.

Nas crianças emocionalmente desapegadas, descritas anteriormente, e também, creio, em adultos que desenvolveram o tipo de personalidade que Winnicott (1960) descreveu como *false-self* e Kohut (1977) como narcisista, a informação bloqueada é de um tipo muito especial. Longe de ser uma exclusão rotineira de informação irrelevante e potencialmente perturbadora, com a qual nos ocupamos o tempo todo, e que é prontamente reversível, o que está sendo excluído nessas condições patológicas são os sinais que surgem tanto do interior como do exterior da pessoa, sinais que ativariam seu comportamento de apego e que o capacitariam tanto a amar como a vivenciar ser amado. Em outras palavras, as estruturas mentais responsáveis pela rotina de exclusão seletiva estão sendo empregadas (alguém poderia dizer, exploradas) com um propósito especial e potencialmente patológico. Essa forma de exclusão à qual me refiro, por razões óbvias, como exclusão defensiva, é, certamente, apenas uma outra forma de descrever repressão. Assim como Freud considerou a repressão como processo-chave em todas as formas de defesa, assim vejo o papel da exclusão defensiva*. Uma explicação completa dessa abordagem de processo sobre o problema da defesa, na qual as defesas são classificadas em processos defensivos, crenças defensivas e atividades defensivas é dada em um dos capítulos iniciais de *Perda* (Bowlby 1980).

* Assim como Spiegel (1981) aponta, meu termo "exclusão defensiva" traz um significado muito semelhante ao termo de Sullivan, "desatenção seletiva".

Uma estrutura alternativa

Durante o período no qual a estrutura conceitual descrita aqui foi desenvolvida, Margareth Mahler preocupou-se com muitos dos mesmos problemas clínicos e alguns dos mesmos traços de comportamento infantil; ela também desenvolveu uma estrutura conceitual revisada para explicá-los, integralmente encontrada em *O Nascimento Psicológico da Criança* (Mahler, Pine e Bergman 1975). Comparar estruturas alternativas nunca é fácil, como Huhn (1962) enfatizou, e não existe nenhuma tentativa de fazê-lo aqui. Em outro texto (e.g., Bowlby, 1981), descrevi o que acredito serem alguns dos sustentáculos da estrutura à qual sou favorável, incluindo sua estreita relação com dados empíricos, tanto clínicos como desenvolvimentais, e sua compatibilidade com as idéias correntes da biologia evolucionária e da neurofisiologia; enquanto o que eu vejo como sendo as falhas da estrutura de Mahler foi exaustivamente criticado por Peterfreund (1978) e Klein (1981).

Em resumo, as teorias de Mahler sobre o desenvolvimento normal, incluindo as fases normais - postuladas por ela - do autismo e da simbiose, não se baseiam em observações, mas em preconceitos baseados na teoria psicanalítica tradicional e, ao fazê-lo, ignoram quase que inteiramente o notável corpo de novas informações sobre a primeira infância que foi construída a partir de estudos empíricos cuidadosos nas duas últimas décadas. Embora algumas das implicações clínicas da teoria de Mahler não sejam muito diferentes daquelas da teoria do apego, e o seu conceito de retorno à base para "reabastecer" seja semelhante àquele do uso da figura de apego, como base segura a partir da qual a exploração pode ocorrer, os conceitos-chave a partir dos quais as duas teorias foram construídas são muito diferentes.

Pesquisa

Nada tem sido tão recompensador como a imensa quantidade de pesquisa cuidadosa que o trabalho sobre privação materna deu início. A literatura, agora, é enorme, impossibilitando, assim, que as informações sejam sumarizadas. Felizmente, isso é desnecessário, já que uma revisão nova, compreensiva e crítica sobre esse campo foi publicada por Rutter (1979), que concluiu, referindo-se ao "acúmulo contínuo de evidências mostrando a importância da privação e as desvantagens no desenvolvimento psicológico da criança", e expressou o ponto de vista de que os argumentos originais "foram amplamente confirmados". Uma descoberta importante, de um trabalho recente, é o fato de que duas ou mais experiências adversas interagem de forma que o risco de uma perturbação psicológica seja multiplicado muitas vezes. Um exemplo dessa interação do efeito de experiências adversas é

encontrado nas descobertas de Brown e Harris (1978), derivadas dos seus estudos sobre as desordens depressivas em mulheres. (Durante a última década, esse grupo publicou muitas outras descobertas, também de grande interesse, veja em Harris (no prelo).)

As experiências adversas não provocam somente esse forte efeito interativo, mas também uma crescente tendência naqueles que tiveram uma experiência adversa, em vivenciar uma outra. Por exemplo "... pessoas que cresceram em lares infelizes ou com separação têm uma tendência maior a terem filhos ilegítimos, a se tomarem mães ainda muito novas, a terem um casamento infeliz e a se divorciarem" (Rutter 1979). Assim, as experiências adversas na infância têm pelo menos dois tipos de efeito. Primeiro, elas tornam o indivíduo mais vulnerável a experiências adversas posteriores. Segundo, elas fazem com que aumente a tendência da pessoa em se deparar com tais experiências. Considerando que as primeiras experiências adversas tendem a ser inteiramente independentes da ação do indivíduo em questão, as posteriores tendem a ser as consequências de suas próprias ações, ações que surgem de suas próprias perturbações de personalidade, para as quais as experiências iniciais foram a causa.

Dos muitos tipos de perturbação psicológica que, pelo menos em parte, são traçados para um ou outro modelo de privação materna, os efeitos no comportamento parental e, dessa forma, na geração seguinte são, potencialmente, os mais sérios. Dessa forma, uma mãe que, devido a experiências adversas durante a infância, cresce tomando-se ansiosamente apegada, está inclinada a buscar o cuidado em seu próprio filho e, dessa forma, a levar a criança a se tornar ansiosa, culpada e possivelmente fóbica (ver revisão em Bowlby, 1973). Uma mãe que, em criança, sofreu negligências e sérias e freqüentes ameaças de ser abandonada ou espancada, está mais inclinada do que as outras a ser severa fisicamente com seu filho (Delozier, 1982), resultando em efeitos adversos no desenvolvimento da personalidade da criança, registrados, entre outros, por George e Main (1979). Pesquisas sistemáticas, sobre os efeitos das experiências infantis na maneira pela qual mães e pais tratam suas crianças, começaram recentemente e parecem ser um dos campos de pesquisa mais fértil. Outros exemplos de pesquisa são descritos num recente simpósio editado por Parkes e Stevenson-Hinde (1982).

Minha razão para dar tanta atenção ao desenvolvimento da teoria não é somente porque isso ocupou tanto tempo de minha vida, mas porque, como Kurt Lewin chamou atenção algum tempo atrás: "não há nada tão prático como uma boa teoria" e, certamente, nada tão desvantajoso como uma teoria pobre. Sem uma boa teoria como guia, a pesquisa tende a ser dificilmente planejada e improdutiva, e as descobertas difíceis de serem interpretadas. Sem uma teoria, razoavelmente válida da etiologia, medidas sistemáticas de prevenção nunca serão mantidas. Minha esperança é que, a longo prazo, o maior valor da teoria proposta possa provar ser a luz que

lança nas condições que mais tendem a promover um desenvolvimento sadio da personalidade. Somente quando essas condições estiverem fora de dúvida, é que os pais saberão o que é melhor para seus filhos e as comunidades estarão desejosas em ajudá-los a conseguirem-no.

Conferência 3

Psicanálise como arte e ciência

Durante o verão de 1978, fui convidado a dar uma série de conferências no Canadá. Entre os convites estava o da Sociedade Psicanalítica do Canadá, para que eu fizesse a conferência acadêmica no encontro anual da Sociedade, que ocorreria em Quebec. O tópico que escolhi é motivo da minha atenção há muitos anos e, creio, ainda seja motivo de muitos pensamentos confusos.

Ao escolher meu tema psicanálise como arte e ciência, quero chamar atenção para o que eu acredito serem os dois aspectos diferentes da nossa disciplina — a arte da terapia psicanalítica e a ciência da psicologia psicanalítica — e ao fazê-lo, enfatizar, por um lado, o valor distinto de cada um, e por outro lado, o abismo que os separa considerando que ambos deveriam ser julgados com critérios diferentes e necessitariam de enfoques mentais diferentes. Ao enfatizar tais distinções, vocês compreenderão que não posso deixar de lamentar o fato de a palavra *psicanálise* ter sido usada, desde o início, ambigualmente, como o próprio Freud descreveu. “Enquanto era, originalmente, o nome de um método terapêutico”, escreveu em sua autobiografia (1952), “hoje em dia tornou-se o nome de uma ciência — a ciência dos processos mentais inconscientes”.

A distinção para a que estou chamando atenção, é claro, não está restrita à psicanálise. Ela se aplica a todos os campos nos quais a prática de uma profissão ou ocupação produz um corpo de conhecimento científico — do ferreiro ao metalúrgico, do engenheiro civil ao mecânico de solo, do fazendeiro ao fisiólogo de plantas e do médico ao cientista médico. Em cada

um desses campos, os papéis diferem. De um lado estão os profissionais, de outro os cientistas com um número limitado de tentativas individuais para combinar os dois papéis. Como a história mostra, esse processo de diferenciação frequentemente se apresenta doloroso e os mal-entendidos são frequentes. Desde que eu acredito estar a diferenciação também prestes a ocorrer em nossa área e, talvez, já esteja tardia, vamos considerar algumas das dificuldades e mal-entendidos para que, com alguma facilidade, possamos ter esperança de evitá-los ou diminuir suas consequências.

Começo contrastando os papéis do terapeuta e do cientista e o faço sob três títulos, usando o caso da medicina como um exemplo.

Focos de estudo

O objetivo do terapeuta é levar em consideração tantos aspectos quantos forem possíveis, de cada problema clínico, com os quais ele tem que lidar. Isso requer dele não somente a aplicação de algum princípio científico, que lhe pareça relevante, mas, também, o uso de experiências pessoais adquiridas como um recurso e, especialmente, estar atento à única combinação de fatores que se encontra em cada paciente. Sabendo o quanto cada paciente é diferente de outro, um clínico experiente reconhece que uma forma de tratamento que se aplica bem a um seria totalmente inadequada a outro. Levar todos os fatores em consideração e dar, a cada um, o seu peso correto é a arte do julgamento clínico.

O ponto de vista de um cientista pesquisador é bastante diferente. No esforço de elaborar moldes gerais, baseados nas variáveis individuais, ele ignora as particularidades e luta para simplificar, arriscando-se assim a uma excessiva simplificação. Se ele for inteligente irá, provavelmente, concentrar sua atenção num aspecto limitado de um problema limitado. Se ao fazer essa seleção, ele se mostrar sagaz ou simplesmente com sorte, poderá não somente elucidar o problema selecionado como também desenvolver idéias aplicáveis a uma extensão maior. Se sua seleção se mostrar pouco inteligente ou sem sorte, ele poderá meramente acabar sabendo cada vez mais sobre cada vez menos. Esse é o risco que todo pesquisador corre. A arte de pesquisar encontra-se na seleção de um problema limitado, passível de ser lido e os métodos que melhor irão resolvê-lo. Isso me leva ao segundo ponto.

Formas de adquirir informação

Nos métodos disponíveis para adquirir informações, o terapeuta tem grandes vantagens sobre o cientista pesquisador, mas também tem grandes desvantagens. Começemos com as vantagens.

No seu papel de ajudar, o terapeuta tem acesso a informações de certo tipo, que permanecem fechadas aos cientistas: como um amigo meu gosta de dizer, "somente aos cirurgiões é permitido cortar uma pessoa para ver o que tem dentro". De uma forma análoga, somente tratando um paciente terapeuticamente é possível ao psicanalista ter acesso ao que ocorre de importante na mente de uma pessoa. Além disso, em ambas as profissões, lhes é permitido que intervenham de forma específica e lhes é dado o privilégio de observar quais as consequências de tais intervenções. Essas vantagens são imensas e os psicanalistas não têm sido lentos para explorá-las.

Nenhuma ciência pode prosperar por muito tempo sem o suporte de novos métodos que possam verificar as observações e hipóteses provenientes de métodos mais velhos. Nesse ponto, o cientista pesquisador tende a ter vantagens. Nas ciências médicas, os psicólogos e patologistas fizeram enorme avanço através de experimentos animais, cultura de tecido, análise bioquímica e mil outras técnicas engenhosas. Na verdade, o que leva a marca registrada de um cientista criativo é poder pensar em novas formas, nas quais os fenômenos, talvez já bastante estudados por outros métodos, possam ser observados de uma nova maneira.

É nessa área, creio, que o uso ambíguo da palavra psicanálise foi o de maior dano. Levou alguns analistas a supor que o único método de investigação apropriado ao avanço da ciência psicanalítica era o de tratar um paciente psicanaliticamente. Já que acredito ser tal afirmação um imenso mal-entendido, falarei mais sobre isso. Porém, antes de fazê-lo, preciso dizer umas palavras sobre o papel do ceticismo e da fé nos mundos do cientista e do terapeuta, respectivamente.

Ceticismo e fé

No seu trabalho diário é necessário ao cientista exercitar um alto grau de crítica e autocritica; e no mundo em que vive, nem os dados nem as teorias de um líder — mesmo que este seja admirado pessoalmente — estão isentos de desafio e crítica. Não existe lugar para autoridade.

O mesmo não é verdade na prática de uma profissão. Se a intenção é ter resultados, o terapeuta tem que ser preparado para agir como se certos princípios e certas teorias fossem válidos; e ao decidir quais devem ser adotados, ele tende a ser guiado por aqueles já experimentados pelas pessoas com as quais ele aprendeu. Além disso, já que existe em todos nós uma tendência nos impressionarmos cada vez que a aplicação de uma teoria parece ter sido bem-sucedida, os terapeutas correm um risco especial de darem mais importância a uma teoria do que a evidência disponível poderia justificar.

Do ponto de vista da prática clínica, isso não é uma coisa ruim. Ao contrário, existe uma evidência abundante de que a grande maioria dos pacientes é ajudada pela fé e pela esperança que o terapeuta traz em seu trabalho; enquanto isso, é freqüente muitos pesquisadores excelentes serem terapeutas mal-sucedidos, pela ausência dessas mesmas qualidades.

Ainda assim, embora a fé, na validade de dados *especiais* e em teorias *especiais*, esteja fora de propósito para um cientista, não desejo deixar implícito que ele seja somente um cético. Ao contrário, toda a sua maneira de viver está baseada na fé; fé de que o melhor caminho par um conhecimento real e confiável é, afinal, a aplicação de um método científico.

Certamente, estou ciente de que existem muitos psicanalistas que não compartilham dessa fé e acreditam que os tipos de problemas com os quais lidamos estão longe da abrangência da ciência. Isto é um ponto de vista, eu respeito, embora não compartilhe dele; certamente, nem Freud compartilhava. Ainda assim, mesmo aqueles entre nós que são entusiastas da aplicação de métodos científicos em nosso campo, têm que reconhecer que podem muito bem surgir problemas que o método científico seja incapaz de resolver. Nós, simplesmente, não sabemos. Nossa tarefa, como eu a vejo, é aplicar nosso método tão habilmente quanto possamos, acreditando, por um lado, que a área de conhecimento real e confiável terá, então, uma extensão maior e, por outro lado, aceitando que existam grandes áreas com tendências a sempre permanecerem estáticas, localizadas além da abrangência de qualquer modo de questionamento científico existente.

Temo que para muitos de vocês, que devem estar engajados na prática terapêutica, mas também esperançosos em contribuir para o avanço da ciência psicanalítica, os contrastes para os quais estou chamando atenção entre os papéis de um terapeuta e um cientista, dificilmente, sejam bem-vindos. Ainda assim, acredito que seja somente ao reconhecer essas diferenças e agir de acordo com elas, é que as forças de cada papel poderão ser usadas para a obtenção de todas as vantagens — ou que qualquer pessoa possa ocupar ambas com algumas esperanças de sucesso. Como terapeutas, trabalhamos com complexidades; como cientistas, nosso esforço é para simplificar. Como terapeutas, usamos a teoria como guia; como cientistas, questionamos desafiadoramente essas teorias. Como terapeutas, aceitamos modos restritos de questionamento; como cientistas, admitimos todos os métodos possíveis.

Anteriormente, chamei atenção para a necessidade de cada ciência em desenvolvimento pensar em novos métodos para a obtenção de dados. A razão para tal necessidade é que embora qualquer método possa ser produtivo, ele tende a ter limitações, mas existe sempre uma perspectiva de que algum outro método venha a compensar as limitações do anterior. No entanto, o método novo pode não ser superior ao antigo; na verdade, ele pode ter grandes limitações. Sua utilidade está, simplesmente, no fato de que sua

força e suas limitações são diferentes. Talvez eu possa ilustrar esse ponto com referências ao meu próprio trabalho.

Quando me qualifiquei como psicanalista, em 1937, os membros da Sociedade Britânica estavam ocupados em explorar o mundo da fantasia dos adultos e das crianças e era considerado até como fora do interesse apropriado de um analista dar atenção sistemática às experiências reais de uma pessoa. Era o tempo em que a famosa mudança de Freud, em 1897, relacionada à histeria* levou ao ponto de vista de que qualquer pessoa que desse ênfase ao que as *experiências reais* de uma criança pudessem ter sido, ou ainda estivessem sendo, era considerada inteiramente ingênua. Quase que por definição assumia-se que qualquer pessoa interessada no mundo externo não poderia estar interessada no mundo interno, estando, na verdade, separando-se mais e mais deste.

Como biólogo, esse contraste entre interno e externo, de organismos e meio ambiente nunca havia me atraído. Além disso, como psiquiatra engajado no trabalho com crianças e famílias e profundamente influenciado pelos insights de dois assistentes sociais, analiticamente orientados, eu era diariamente confrontado com o impacto, nas crianças, dos problemas emocionais que os pais sofriam. Aqui estão dois exemplos que eu lembro com clareza. Em um deles, um pai estava profundamente preocupado com a masturbação de seu filho de oito anos de idade e em resposta às minhas questões, explicou que sempre que o pegava com as mãos nos seus órgãos genitais, ele colocava embaixo da torneira de água fria. Isso me levou a perguntar ao pai se ele mesmo nunca tinha se preocupado com masturbação e ele iniciou uma longa e patética história sobre o quanto havia lutado, toda a vida, com esse mesmo problema. Em um outro caso, o tratamento punitivo da mãe de uma menina de três anos, que tinha ciúmes do bebê mais novo, foi rapidamente vinculado ao seu próprio ciúme de um irmão mais novo.

Observações desse tipo me levaram a concluir que é tão importante e necessário para o analista estudar a maneira pela qual uma criança é realmente tratada por seus pais, como é necessário estudar as representações internas que a criança tem deles, embora, na verdade, o principal foco de nossos estudos deva ser a interação de um com o outro, do interno com o externo. Acreditando que isso só seria possível se tivéssemos um conhecimento muito maior e sistemático sobre os efeitos, em uma criança, das experiências que ela teve durante os seus primeiros anos com sua família, concentrei minha atenção nessa área. Foram várias as razões que me levaram a selecionar como meu campo de estudo especial — a remoção de uma criança nova de seu lar para uma creche residencial ou hospital — mais do que o campo tão vasto da interação pais-filhos. Inicialmente, era um evento

*Efron (1977) discutiu as circunstâncias nas quais a mudança de opinião abrupta de Freud aconteceu.

que eu acreditava que poderia ter sérios efeitos doentios no desenvolvimento da personalidade de uma criança. Em segundo lugar, poderia não haver dúvida sobre se isso tinha ocorrido ou não, o que contrastaria fortemente com a dificuldade de se obterem informações válidas de como os pais tratam a criança. Em terceiro lugar, isso parecia ser um campo onde as medidas preventivas seriam possíveis. Talvez, devesse acrescentar, considerando como um quarto lugar, que eu estava estimulado pela total e absoluta incredulidade com a qual meus pontos de vista eram encarados por alguns dos meus colegas, embora não por todos, quando dei alguns passos à frente deles, pouco antes da guerra.

Os resultados de nossos estudos seguintes, com o aval de dois pesquisadores que subseqüentemente qualificaram-se como analistas, James Robertson e Christoph Heinicke, são bastante conhecidos hoje em dia; e acredito que eles tiveram efeitos significativos no pensamento psicanalítico. Os pontos que desejo esclarecer, agora, relacionam-se à estratégia da pesquisa. Apesar do trabalho pioneiro de analistas tão reconhecidos como Anna Freud, René Spitz, Ernst Kris, Margaret Mahler e outros, houve, durante muito tempo, uma tendência, nos círculos psicanalíticos, de considerar a observação direta de crianças jovens e a gravação do que elas diziam somente como um método auxiliar de pesquisa, cujos resultados eram de interesse quando confirmavam conclusões já alcançadas pelo método tradicional de tratar pacientes, mas que não contribuíam com coisa alguma original. A noção de que a observação direta de crianças — dentro e fora do ambiente familiar — não é somente um método valioso para o avanço da ciência psicanalítica, mas também indispensável para a mesma, tem sido aceita lentamente.

Creio que as principais contribuições desses estudos diretos são as de lançar alguma luz em como as crianças se desenvolvem emocional e socialmente, quais são as extensões das variações em relação ao grande número de parâmetros relevantes e quais os tipos de experiência familiar que tendem a influenciar o desenvolvimento das crianças, de uma forma mais que de outra. Deixem-me dar alguns exemplos de descobertas feitas por colegas que trabalham em ciências irmãs — etologia e psicologia do desenvolvimento — que eu acredito serem altamente relevantes para a nossa compreensão clínica.

O primeiro exemplo é o trabalho de Mary Salter Ainsworth (1977), que pertencia, inicialmente, à Johns Hopkins University e, agora, à University of Virginia. Treinada, inicialmente, como psicóloga clínica, Mary Ainsworth trabalhou conosco na Tavistock durante o início dos anos 50 e, então, passou alguns anos estudando mães e crianças em Uganda. Seu estudo definitivo é relativo ao desenvolvimento da interação mãe-filho, durante o primeiro ano de vida, nas famílias brancas, da classe média, em Baltimore, Maryland. Ela foi analisada e tem uma consciência aguçada sobre os tipos de problemas que os analistas consideram importantes.

Durante seus estudos sobre mães e crianças em Uganda, Ainsworth impressionou-se com crianças que, uma vez capacitadas para andar normalmente, usam a mãe como ponto de partida — base — para suas explorações. Quando as condições eram favoráveis, a criança distanciava-se da mãe em pequenas excursões exploratórias e voltava a ela de tempos em tempos. Com cerca de oito meses de idade, quase todas as crianças observadas, que tinham tido uma figura materna estável, à qual estavam apegadas, mostraram esse comportamento; mas, se a mãe se ausentava, tais excursões organizadas tornavam-se menos evidentes ou cessavam. Como resultado dessas descobertas e de outras similares, tanto para crianças como para filhotes de macacos, desenvolveu-se a noção de que uma mãe comum e devotada dá a uma criança a base segura para sua exploração e a qual ela pode voltar, quando preocupada ou amedrontada. Observações semelhantes, é claro, foram feitas por Margaret Mahler (Mahler, Pine e Bergman, 1975), embora ela as interprete em termos de uma estrutura teórica diferente daquela que Ainsworth e eu usamos. Esse conceito de “base para segurança pessoal”, da qual uma criança, um adolescente ou um adulto pode partir para explorar e retornar de tempos em tempos, é o que passei a considerar como crucial para a compreensão de como uma pessoa se desenvolve e funciona de uma forma emocionalmente estável por toda sua vida.

Em seu projeto, em Baltimore, Ainsworth não só pôde estudar esse tipo de comportamento mais de perto, como descreveu muitas variações individuais, onde serviam como amostra vinte três crianças de doze meses de idade. Foram feitas observações de comportamento exploratório e de apego das crianças, e as diferenças entre quando as crianças estavam em casa com a mãe e quando eram colocadas em uma situação de teste, um pouco estranhas a elas. Tendo obtido dados sobre o tipo de maternagem, que cada criança vinha recebendo durante seu primeiro ano de vida (por meio de sessões de observação prolongada com intervalos de três semanas na casa da criança), Ainsworth estava na posição de propor hipóteses que unissem certos tipos de desenvolvimento emocional e comportamental aos doze meses, com certos tipos de experiência de maternagem anteriores.

As descobertas desse estudo (veja a revisão de Ainsworth, 1977) mostram que a maneira pela qual uma criança de doze meses se comporta com e sem a mãe em casa e a maneira como ela se comporta com e sem ela, numa situação de teste um pouco estranha, tem muito em comum. Baseada em informações do comportamento, em ambos os tipos de situação, ficou possível classificar três grupos distintos, de acordo com dois critérios: (a) quão muito e quão pouco elas exploram quando estão com ou sem a mãe e (b) como elas tratam a mãe quando ela está presente, quando ela se afasta e, especialmente, quando ela retorna.

Ainsworth teve que considerar o comportamento global de oito crianças, no seu primeiro aniversário, como bastante promissor para o futuro.

Tais crianças exploravam ativamente, em especial quando estavam na presença das mães e usavam as mães como base segura, ficando cientes do lugar onde elas estavam, trocando olhares e, de tempos, retornando a elas para dividirem o contato mutuamente agradável. Quando a mãe tinha estado ausente, por um curto período de tempo, ela era calorosamente recebida em seu retorno. Chamarei esse grupo de X.

Havia não menos de onze crianças cujo comportamento global foi motivo de preocupação e que eu chamarei de grupo Z. Três delas eram passivas, tanto em casa quanto em situações de teste; elas exploravam um pouco, chupavam o pelegar ou se embalavam. Constantemente ansiosas sobre onde as mães estavam, elas choravam muito em suas ausências, mas se mostravam arredias e difíceis nos seus retornos. As outras oito desse grupo alternavam entre parecerem muito independentes e ignorarem as mães e, então, de repente, tornarem-se ansiosas e tentarem encontrá-las. Ainda assim, quando elas as encontravam, pareciam não apreciar o contato e, freqüentemente, lutavam para se livrarem novamente. De fato, elas apresentavam um quadro clássico de ambivalência.

As quatro crianças restantes (do grupo das vinte e três estudadas) foram consideradas ocupantes de uma posição intermediária, entre aquelas que receberam um prognóstico positivo no primeiro aniversário e aquelas que receberam um prognóstico de cautela. Eu as chamarei de grupo Y.

Já que os pesquisadores tinham passado, a cada três semanas, três horas de sessão na casa das crianças, observando e gravando o comportamento das mães e da criança, eles possuíam dados em primeira mão para avaliar o comportamento da mãe em relação à criança. Ao fazer essa avaliação, Ainsworth usou quatro escalas de nove pontos; mas, já que as avaliações nessa escala eram altamente correlatas, para o propósito presente, uma escala era suficiente — uma escala que medisse o grau de sensibilidade ou intensidade que uma mãe mostra aos sinais e comunicações de seu bebê. Enquanto uma mãe sensível parece estar constantemente “afinada” para receber os sinais de seu bebê, tende a interpretá-los corretamente e a respondê-los pronta e acertadamente, uma mãe não sensível, com freqüência, vai deixar de notar os sinais de seu bebê, vai interpretá-los mal quando os notar e os responderá tardia ou inapropriadamente, ou simplesmente não responderá. Quando as avaliações nessa escala para mães e crianças, em cada um dos três grupos, foram examinadas, descobriu-se que as mães das oito crianças do grupo X foram avaliadas uniformemente bem (variando entre 5,5 a 9,0), as mães das onze crianças no grupo Z foram avaliadas uniformemente mal (variando entre 1,0 a 3,5) e aquelas das quatro crianças do grupo Y ficaram no meio (variando entre 4,5 e 5,5). Essas diferenças foram estatisticamente significativas.

Para que seja possível a elaboração de conclusões com alto grau de confiabilidade, faz-se necessário um grande trabalho anterior. No entanto, os

moldes gerais do desenvolvimento da personalidade e a interação visível mãe-filho aos doze meses são suficientemente parecidos com o que é visto do desenvolvimento da personalidade e da interação pais-filhos nos anos posteriores, porque é plausível acreditarmos que um é o antecessor do outro. No mínimo, as descobertas de Ainsworth mostram que uma criança cuja mãe é sensível, acessível, que lhe oferece respostas, aceita seu comportamento e coopera ao lidar com ela, está longe de ser uma criança que exija muito ou que seja infeliz, como algumas teorias poderiam sugerir. No lugar disso, a maternagem desse tipo é evidentemente compatível com a criança que está desenvolvendo uma medida limitada de autoconfiança na altura do seu primeiro aniversário, combinada com o alto grau de confiança em sua mãe e o prazer que tem na sua companhia.

De maneira oposta, mães que são insensíveis aos sinais de seus bebês — talvez porque estejam preocupadas com outras coisas — que ignoram seus bebês ou interferem em suas atividades de uma forma arbitrária ou, simplesmente, os rejeitam, tendem a fazer com que as crianças sejam ansiosas, infelizes e difíceis. Qualquer pessoa que tenha trabalhado numa clínica vendo crianças ou adolescentes perturbados, dificilmente ficará supreso com isso.

Embora as descobertas de Ainsworth, de que existe uma correlação entre as respostas de uma mãe a seu filho e a maneira como ele se comporta em relação a ela aos doze meses de idade, sejam altamente significativas estatisticamente e tenham sido confirmadas por estudos subsequentes, é sempre possível discutir que o parceiro que tem o papel mais importante para determinar se a interação se desenvolve de forma feliz ou não é a criança e não a mãe. Algumas crianças nascem difíceis, prossegue a discussão, e as relações adversas da mãe para com elas são esperadas.

Não acredito que as provas sejam suficientes para manter tal ponto de vista. Por exemplo, as observações feitas durante os três primeiros meses de vida dessas crianças não mostraram nenhuma correlação entre a quantidade de choro do bebê e a maneira com que sua mãe o estava tratando; enquanto que, ao final do primeiro ano, as mães que tinham atendido prontamente ao choro do bebê, tinham bebês que choravam muito menos do que os bebês cujas mães os haviam deixado chorar.

Existem outras descobertas, algumas das quais foram mencionadas na Conferência 6, que também mantém o ponto de vista de que, em todos, exceto numa pequena minoria de casos, é a mãe a principal responsável pela maneira como a interação se desenvolve.

Baseando-se na observação feita na própria casa, Ainsworth fez um gráfico do que pode acontecer. Por exemplo, ela observou, em algumas casas, o tempo que a mãe levava para responder quando um bebê chorava ininterruptamente. Em alguns casos, elas esperavam o tempo que agüentavam, acreditando que seria ruim para os bebês e talvez os fizesse chorar

ainda mais se elas os atendessem — crença essa que Ainsworth desaprova, baseada em suas experiências. Em outros casos, a mãe poderia estar muito ocupada com outros afazeres. Em outros, ainda, parecia que a mãe não havia percebido que o bebê estava chorando — situação que a observadora considerava penosa. Normalmente, essas mulheres sofrem de ansiedade e depressão e são realmente incapazes de participar de qualquer outra coisa.

Agora, será evidente para todos que observações detalhadas e acuradas desses tipos — que demonstram o quanto podem ser diferentes as experiências com diferentes crianças — são obtidas somente pelos métodos usados por esses pesquisadores. Se os observadores não estivessem presentes para ver e ouvir o que estava acontecendo e, ao invés disso, tivessem confiado no que as mães contassem, os quadros que eles teriam, em muitos casos, teriam se mostrado inteiramente falsos; e toda esperança de descobrir correlações significativas entre a maneira pela qual uma criança se desenvolve e a maneira pela qual é tratada pelos pais teria desaparecido. Ainda assim, como vimos, quando são usados métodos de observação confiáveis — mesmo que com uma amostragem pequena — correlações altamente significativas são encontradas.

Ao enfatizar o papel que a mãe desempenha como determinante no estabelecimento de moldes de interação com seu bebê, que eu considero evidente, não imponho uma culpa. Cuidar de um bebê ou de uma criança que já engatinha ou mesmo de uma criança mais velha não é só uma tarefa que requer aptidão, mas, também, uma tarefa difícil e exigente. Mesmo para uma mulher que teve uma infância feliz e que esteja agora tendo suporte e ajuda do marido e, talvez, até da própria mãe e que não tenha sido “inundada” por conselhos inadequados sobre o perigo de estragar seu bebê, essa tarefa é muito árdua. Não é surpresa que uma mulher que não tenha nenhuma dessas vantagens apresente um desconforto emocional — certamente, não caberia aqui uma culpa. Parece que existem poucas dúvidas de que quando os bebês e/ou as crianças são sujeitos de uma maternagem insensitiva, misturada, talvez, com ocasiões de rejeição inegáveis e, mais tarde, à uma separação ou ameaça de separação, os efeitos são deploráveis. Tais experiências aumentam muito o medo das crianças de perderem a mãe como, também, aumentam a exigência de sua presença e a raiva em suas ausências, podendo levá-las ao desespero de terem sempre um relacionamento de amor e segurança com qualquer um.

Embora essas idéias sejam muito mais familiares e mais aceitas hoje em dia, nos círculos analíticos, do que foram nas gerações passadas — graças à influência de Balint, Fairbairn, Winnicott e muitos outros — estou inclinado a achar que tais implicações, tanto na teoria, como na prática, ainda estão longe de serem digeridas.

Deixem-me ilustrar esse ponto considerando os problemas etiológicos e terapêuticos apresentados pelo tipo de paciente que, no Reino Unido, tende

a ser descrito como "personalidade esquizóide" (Fairbairn, 1940) ou como *false-self* (Winnicott, 1960) e que, na América do Norte, é considerado como personalidade *borderline* ou sofrendo de narcisismo patológico (e. g., Kohut, 1971; Kernberg, 1975).

O quadro que essa pessoa apresenta é o de independência segura e auto-suficiência emocional. De forma nenhuma ela ficará presa a alguém e assim que ela estabeleça qualquer relacionamento, fará questão de reter o controle. Na maior parte do tempo, ela pode parecer lidar maravilhosamente bem, mas podem existir momentos em que ela fique deprimida e desenvolva sintomas psicossomáticos, freqüentemente, por razões que ela desconhece. Somente se os sintomas e a depressão tomarem-se agudos é que existe a possibilidade de ela procurar um tratamento, mas a tendência à procura das drogas será maior do que a de procurar um analista.

Quando esse tipo de pessoa procura análise, ela é cuidadosa em manter uma certa distância do analista e controla o que acontece. O que ela nos diz é lúcido, mas evita qualquer referência a sentimentos, exceto, talvez, quando diz o quanto está enfadada. As férias ou outras interrupções são consideradas bem-vindas, como se "economizasse seu tempo". Talvez ela considere a análise como "exercício interessante", embora não esteja muito convencida de sua utilidade. De qualquer forma, ela poderia, provavelmente, fazer a tarefa melhor se estivesse se auto-analisando!

Certamente, existe uma literatura vasta que discute a psicopatologia dessas condições e os problemas terapêuticos que se apresentam; mas quaisquer que sejam os pontos onde possa haver uma concordância, não existe nenhuma na etiologia. Levantaremos dois pontos contrastantes: Winnicott (1960, 1974) atribui essas condições diretamente ao fracasso do meio ambiente inicial, da seguinte maneira: "a maternagem não foi suficientemente boa"; Kernberg (1975), no seu tratado sistemático, não oferece nada além do que dois parágrafos sobre o possível papel da maternagem para influenciar o desenvolvimento, e faz somente algumas poucas referências à certeza de que alguns pacientes devem ter recebido maternagem inadequada. Essa experiência inicial, que pode ter papel-chave na determinação dessas condições, não é seriamente examinada por ele.

Claro que é da maior importância, no decorrer do tempo, nós chegarmos a um consenso sobre esse assunto; e, ao debatê-lo, acho que seríamos imprudentes se não dêssemos importância aos dados obtidos de todas as fontes que pudéssemos. Certas pesquisas sobre as condições epidemiológicas estão, agora, provando ser informativas, mas duvido que elas ainda tenham alguma coisa para nos informar sobre isso. No momento, devemos tentar lidar com os dados das duas fontes que nos são familiares: (a) o tratamento analítico de pacientes e (b) a observação direta de crianças novas e suas mães.

Em relação aos dados obtidos durante o tratamento, penso que seria útil, para algumas pessoas de mente aberta, dar uma vista geral na literatura

psicanalítica e juntar todos os relatórios de casos que incluíssem informações sobre as experiências da infância desses pacientes. Minha suposição é a de que, até o ponto em que nos é permitido ter informações, isso traria um suporte valioso ao ponto de vista de Winnicott, de que esses pacientes tiveram uma infância perturbada cuja maternagem foi, de uma forma ou de outra, predominantemente inadequada. Desde que eu não tenha feito tal pesquisa, não posso fazer mais do que ilustrar o tipo de descoberta que eu, confiantemente, esperaria. Os detalhes seguintes vêm de relatórios de casos publicados por três analistas, todos muito influenciados pelos pontos de vista de Winnicott.

Um desses relatórios é da viúva de Donald Winnicott, Clare Winnicott (1980). A paciente, uma profissional de quarenta e um anos, apresentou um quadro clássico de personalidade emocionalmente auto-suficiente que, em tempos recentes, desenvolveu uma variedade de sintomas psicossomáticos. Somente depois de longo tempo de análise ela divulgou os fatos de sua infância. Já que sua mãe trabalhava fora, em tempo integral, ela era cuidada por uma menina alemã que a abandonou, repentinamente, quando a paciente estava com dois anos e meio. Então, depois de seis meses de incertezas, ela foi levada pela mãe para tomar chá com uma amiga e logo reparou que estava sozinha numa cama estranha e que sua mãe havia desaparecido. No dia seguinte, ela foi levada para um colégio interno, onde essa amiga da mãe era a inspetora, e ficou lá até os nove anos, passando, geralmente, as férias na escola. Ela parece ter "se instalado bem" (expressão horrorosa!) e ter lidado com essa situação com sucesso, mas a partir dessa época sua vida emocional acabou.

Um segundo relatório, por Jonathan Pedder (1976), é de uma jovem professora com seus vinte e poucos anos, cuja personalidade e sintomatologia tinham uma forte semelhança com a paciente de Claire Winnicott. Apesar de essa paciente ter dado um quadro idealizado de sua infância, na entrevista inicial, logo surgiu o fato de que, aos dezoito meses, havia sido enviada para casa de uma tia, durante a gravidez seguinte de sua mãe. Depois de passar seis meses lá, começou a sentir que sua tia era uma mãe mais real para ela do que sua própria mãe e seu retorno ao lar foi sentido como uma experiência muito dolorosa. Depois disso, até os dez anos, ela ficou aterrorizada pela idéia de outra separação; ela, então, "desligou" sua ansiedade, "como se fecha uma torneira", como ela mesma coloca, e junto com sua ansiedade desapareceu, também, grande parte de sua vida emocional.

O terceiro relatório, por Elizabeth Lind (1973), refere-se a um jovem graduado de vinte e três anos, que embora severamente deprimido e planejando suicídio, sustentava que seu estado mental era muito mais "filosofia de vida" do que uma doença. Ele era o filho mais velho de uma família grande; quanto tinha três anos, dois outros irmãos já tinham nascido. Seus pais, disse

ele, brigavam freqüente e violentamente. Quando a família era mais jovem, o pai havia passado muitas horas longe de casa se preparando profissionalmente. A mãe era sempre imprevisível. Ela freqüentemente ficava tão “destroçada” com as brigas dos filhos que se trancava no quarto por dias a fio. Muitas vezes, ela saía de casa levando as filhas e deixando os filhos para trás. Contaram-lhe que havia sido um bebê infeliz, que comia pouco, dormia mal e que era, freqüentemente, deixado a chorar sozinho por longos períodos de tempo. O seu choro, foi dito, havia sido uma tentativa de controlar seus pais e ser mimado. Numa ocasião, ele teve apendicite e lembra ter passado a noite toda acordado, deitado numa cama, gemendo; seus pais não fizeram nada e, no dia seguinte, ele estava seriamente doente. Mais tarde, durante a terapia, ele relembrou o quanto costumava se perturbar ao ouvir seus irmãos e irmãs chorando por longo tempo e o quanto odiava os pais por isso, querendo mesmo matá-los.

Ele sempre se sentiu uma criança perdida e ficava confuso para compreender porque havia sido rejeitado. Ele contou que seu primeiro dia na escola foi o pior de sua vida. Parecia que essa seria a rejeição final de sua mãe; durante todo o dia havia estado desesperado e não tinha parado de chorar um só instante. Depois disso, começou a, gradualmente, esconder todos os desejos que tinha de ser amado e amparado; ele se recusava até a pedir ajuda ou a aceitar qualquer coisa feita para ele.

Agora, durante a terapia, ele estava receoso de que pudesse “desabar”, chorar e querer ser amado como filho. Isso poderia levar sua terapeuta, ele achava, a considerá-lo como absurdo e seu comportamento próprio de quem quer chamar atenção; e se ele dissesse alguma coisa pessoal para ela, temia que ela se ofendesse e, talvez, se trancasse em sua sala.

Nesses três casos, o *breakdown* recente dos pacientes ocorria após o colapso de um relacionamento significativo, embora frágil, sobre o qual cada membro do par tinha tido reservas, e para o fim do qual cada paciente tinha contribuído pessoalmente.

Ao tratar esses pacientes, todos os três analistas adotaram a técnica de Winnicott, de permitir a livre expressão daquilo que tradicionalmente é chamado de “sentimento de dependência”, tendo como resultado o fato de que cada paciente, em seu tempo, desenvolveu um apego intenso e ansioso com o seu analista, para usar a terminologia que eu prefiro (Bowlby, 1969, 1973). Isso permitiu que cada paciente resgatasse a vida emocional que havia perdido na infância e, com isso, recobrasse o senso de “real self”. Os resultados foram terapeuticamente bons.

Partindo desses três casos, temos que admitir que as descobertas não provaram nada. No entanto, elas são sugestivas e apóiam a teoria da etiologia de Winnicott. Mesmo assim, essa teoria está sempre aberta a críticas que lançam dúvidas sobre a validade do que um paciente lembra sobre sua infância e questionam se a seqüela de eventos recontados teve efeitos na sua

vida de sentimentos, como ele tão explicitamente reclama. (Cabe observar que o evento que cada um desses três pacientes traz como sendo o *turning point**, ocorreu depois do segundo aniversário.)

Parece claro, agora, que as controvérsias sobre etiologia nunca ficaram sanadas, já que confiamos unicamente em retrospectivas e, talvez, em algumas evidências preconcebidas, derivadas da análise de pacientes, sejam eles adultos ou crianças. O que se faz necessário é a evidência de um tipo diferente que proponha algum tipo de verificação indubitável. É aí que eu acredito serem as observações diretas de crianças pequenas e suas mães potencialmente úteis. Existe alguma evidência dessa natureza a sugerir que a vida de sentimentos de uma criança possa se tornar paralisada, tendo como causa um dos tipos de experiências descritas? A resposta, certamente, é que existe um grande número.

Aqui, naturalmente, eu aponto, primeiro, as observações feitas por James Robertson (1953) e, mais tarde, confirmadas por Cristoph Heinicke e Ilse Westheimer (1965), de como crianças entre doze e trinta e seis meses se comportam, quando retiradas de casa para um lugar estranho sob os cuidados de um estranho — tal como uma creche residencial ou um hospital — onde não existe ninguém para assumir o papel de mãe-substituta. Em tais condições, a criança passa a agir como se nem a maternagem nem o contato com os seres humanos fossem muito significativos para ela. À medida que as pessoas que cuidam dela chegam e se vão, ela pára de se apegar a qualquer pessoa e, depois de sua volta para casa, fica distante de seus pais por dias a fio e talvez por muito mais tempo, se for tratada de maneira pouco compreensiva.

Existe uma razão para acreditar que uma criança pequena possa desenvolver esse tipo de paralisação defensiva em resposta à mãe que a rejeita, sem que ocorra qualquer separação maior. Os exemplos dessa sequência são encontrados em observações registradas por Mahler (1971). Descobertas mais definitivas são relatadas por Mary Main (1977), uma colega de Mary Ainsworth, que fez um estudo especial de um grupo de crianças com idades variando entre doze e vinte meses, que não só deixaram de cumprimentar a mãe depois de ela ter se ausentado com um estranho por alguns minutos, como, deliberadamente, evitaram-na. Observando alguns videoteipes onde Main registrava as pesquisas, eu fiquei surpreso ao ver a que ponto algumas crianças chegavam. Uma delas abordou sua mãe rapidamente, mas com a cabeça virada ao contrário e logo se afastou. Uma outra, ao invés de se aproximar de sua mãe, colocou-se de frente para o canto da parede, como se estivesse de acordo com a punição, e logo se ajoelhou com o rosto voltado para o chão. Em todos os casos registrados em videoteipe,

*N.T. *Turning point* refere-se a um momento de mudança, ponto de partida para uma transformação.

dessas mães brincando com seus bebês, que engatinhavam durante uma sessão posterior, viu-se que elas se comportavam diferentemente das mães que não eram evitadas por seus bebês que engatinhavam: elas pareciam “zangadas, inexpressivas e desgostosas do contato físico com seus bebês”. Algumas repreendiam em tom zangado, algumas debochavam, outras falavam sarcasticamente com a criança ou mesmo sobre a criança. Dessa forma, mantendo-se afastada da mãe, a criança teria uma possibilidade óbvia de evitar ser tratada de uma forma hostil novamente.

Então, até onde ocorre o profundo exame oferecido por observações diretas de crianças pequenas e suas mães, elas tendem a apoiar o tipo de teoria de Winnicott. Colocando em minhas próprias palavras, a criança, mais tarde adulta, fica amedrontada em se permitir tornar-se apegada a alguém, por medo de uma futura rejeição, com toda agonia, ansiedade e raiva para as quais isso a levaria. Como resultado, existe um bloco maciço contra sua forma de expressar ou mesmo sentir, um desejo natural por um relacionamento confiável e mais próximo, por cuidado, conforto e amor — que eu considero como sendo as manifestações subjetivas de um sistema maior do comportamento instintivo.

Uma explicação desse tipo, embora muito menos complexa do que algumas outras propostas na literatura, mostra bem como essas pessoas se comportam tanto no mundo em geral, como conosco, analistas. Inevitavelmente, elas trazem os seus medos de entrar num relacionamento de confiança com os analistas, que nós vivenciamos como resistência maciça, então, quando os seus sentimentos estão recuperados, mais da metade dos pacientes esperam que nós os tratemos da forma como eles lembram terem sido tratados por seus pais. Consequentemente, esses pacientes vivem o medo de serem rejeitados e tomam-se intensamente irritados, caso suspeitem que nós os estamos abandonando. Frequentemente, a maneira como eles nos tratam — com abuso e rejeição — é vista como sendo uma versão do tratamento que eles lembram terem sido, eles próprios, sujeitos quando crianças.

Vocês verão que na explicação de como esses pacientes se comportam durante a análise, propus um certo número de hipóteses interligadas. Num programa de pesquisa, cada paciente requer uma observação detalhada e testes para esclarecer dados mais amplos. Juntamente com os muitos métodos que eu esperaria que se comprovassem de valor, está o estudo, num *setting* terapêutico, de pais e crianças interagindo uns com os outros. Além disso, ainda existe um lugar importante para observações mais amplas a serem feitas durante a análise individual de pacientes; embora eu acredite que a pesquisa clínica será levada a todo seu potencial, quando for perseguida de uma forma mais sistemática e direta do que tem sido até agora.

Para dar um exemplo: teria algum valor se fosse guardado um registro detalhado das respostas de um ou mais desses pacientes, antes e depois de

cada fim de semana, de cada período de férias e de cada interrupção inesperada das sessões, com um registro igualmente detalhado de como o analista lidava com elas. Isso nos capacitaria a saber o repertório de respostas que um dado paciente apresenta nessas ocasiões e, também, as mudanças nas respostas que ele apresenta com o passar do tempo. Também teria um valor especial, se nós pudéssemos ter uma noção detalhada das condições nas quais a maioria das mudanças terapêuticas ocorreram. Se, talvez, num programa de colaboração, os registros sobre um certo número de tais pacientes pudessem ser guardados, se seria possível descobrir se uma discussão franca e detalhada das experiências dolorosas que o paciente lembra ter tido no seu relacionamento com seus pais, os efeitos que essas experiências parecem ter tido, e ainda estão tendo, na maneira como ele trata as pessoas, incluindo-nos, certamente, promove mudanças terapêuticas, como eu predisse, ou impede as mudanças, como alguns analistas acreditam.

Naturalmente, ao optar por esse ou qualquer outro programa de pesquisa, um analista tem que ter em mente suas responsabilidades profissionais, porque com pacientes que apresentam um *false self* elas podem ser onerosas. Winnicott descreve o "período de extrema dependência" que tais pacientes vivem durante a terapia e avisa que "os analistas que não estão preparados para ir de encontro às necessidades dos pacientes, que se tornam dependentes dessa maneira, têm que ser cuidadosos para escolher seus casos, para que não incluam tipos de *false self*".

Isso me traz de volta à arte da terapia. Fornecer, sendo nós mesmos, as condições nas quais um paciente desse tipo possa descobrir e recuperar aquilo que Winnicott chama de seu *real self* e que eu chamo de sentimentos e desejos de apego, não é fácil. Por um lado, temos que ser realmente confiáveis e temos que genuinamente respeitar todos aqueles desejos intensos de afeto e intimidade, que cada um de nós tem, mas que nesses pacientes desapareceram. Por outro lado, não podemos oferecer mais do que podemos dar e não podemos ir mais rápido do que o paciente possa suportar. Para alcançar esse equilíbrio, faz-se necessária toda intuição, imaginação e empatia de que sejamos capazes. Mas, também, faz-se necessário um controle firme de quais são os problemas do paciente e do que estamos tentando fazer. Eis por que é tão importante que os problemas da etiologia e psicopatologia sejam esclarecidos, até o ponto em que a aplicação do método científico seja possível e, além disso, que os analistas sejam totalmente informados sobre as experiências familiares, do nascimento até a adolescência, que afetam — e existem provas crescentes — a maneira como a vida emocional de uma criança se desenvolve. Somente quando estivermos equipados dessa forma e com muito mais conhecimento é que estaremos na posição de encontrar exatamente o que Freud propõe em um de seus últimos escritos, no qual ele dirige a atenção ao "âmago da verdade" dos sintomas dos pacientes e do

valor terapêutico das construções na análise (1937). Nesse artigo, ele escreve: "Estamos à procura de uma quadro dos anos esquecidos do paciente, que seja igualmente digno de confiança e, em todos os aspectos essenciais, completo"*

*N.T. O texto citado encontra-se no artigo "Construções em Análise", 1937, S.E. 23, p. 292.

Conferência 4

Psicanálise como ciência natural

No outono de 1980, fui apontado como Professor Visitante de Psicanálise no Freud Memorial, no Colégio Universitário de Londres. Em minha conferência inaugural, retomei o tema que havia desenvolvido no Canadá, dois anos antes. Como sempre acreditei que o corpo de conhecimento rotulado de psicanálise deveria tornar-se uma parte da ciência natural, fiquei muito aborrecido, perturbado com a pressão da oposição. Aceitar que a psicanálise devesse abandonar seus objetivos de tornar-se uma ciência natural e, ao invés disso, considerar-se uma disciplina hermenêutica, me parecia não só o resultado de idéias obsoletas sobre ciência, mas, também, um conselho desesperado; isto porque, numa disciplina hermenêutica, não existem critérios cuja aplicação torne possível resolver alguma discordância.

Um problema com o qual todos os analistas, que propõem novas idéias teóricas, se deparam é a crítica de que a nova teoria "não é psicanálise". Tal crítica, sem dúvida, depende de como nós definimos psicanálise. Infelizmente, o mais comum é defini-la em termos das teorias de Freud. Isso contrasta com as definições adotadas pelas disciplinas acadêmicas, que sempre o fazem em termos dos fenômenos a serem estudados e dos problemas a serem resolvidos. Em tais disciplinas, o progresso sempre é sinalizado pelas mudanças teóricas, às vezes para uma forma revolucionária. Enquanto os analistas definirem psicanálise em termos de uma teoria especial, eles não poderão reclamar que a sua disciplina seja malcompreendida pelos acadêmicos. Além disso, ao defini-la assim, eles a estão condenando à inércia, a um congelamento.

A seguinte versão da conferência difere em muitos pontos da original, especialmente por abreviar a discussão de alguns temas já discutidos em conferências anteriores.

Desde 1895, quando Freud realizou sua primeira tentativa de esboçar uma estrutura teórica para a psicanálise, até 1938, um ano antes de sua morte, Freud havia determinado que sua nova disciplina deveria se adaptar aos requisitos de uma ciência natural. Assim sendo, na frase de abertura de seu Projeto, ele diz: "A intenção é oferecer uma psicologia que seja uma ciência natural..." (Freud, 1950, 295); enquanto no Esboço, encontramos um trecho onde ele afirma que "uma vez concebido o conceito de processo físico como inconsciente, a psicologia torna-se apta a tomar seu lugar como uma ciência natural como qualquer outra" (Freud, 1940, 158).

Na verdade, durante os anos intermediários, as idéias de Freud sobre a abrangência de sua ciência tinham mudado consideravelmente, desde a sua ambição inicial de "representar os processos psíquicos como estados quantitativamente determinantes de partículas de material específico" (1950, escrito em 1895), até sua definição posterior de psicanálise como "a ciência dos processos mentais inconscientes" (1925). Mas, de sua primeira idéia até a última, não há dúvida sobre o tipo de disciplina que Freud achava que a psicanálise era.

Não obstante, apesar de Freud não hesitar na sua intenção, o *status* científico da psicanálise permanece vago. De um lado, os filósofos da ciência como, por exemplo, Popper, cognominaram-na uma pseudociência pelo fato de que, por mais verdades que as teorias psicanalíticas possam conter, elas são lançadas de uma forma tão elástica que não são suscetíveis de fraude. Por outro lado, muitos psicanalistas desiludidos com as inadequações da metapsicologia de Freud e preocupados com a perspectiva pessoal, que é um requisito inquestionável no trabalho clínico, abandonaram os objetivos e reivindicações de Freud e declararam que o lançamento da psicanálise como uma ciência havia sido malfeito; deveria, ao invés disso, ser compreendida como uma ciência humana, e. g. Home (1966), Ricoeur (1970), e outros, na Europa. Tanto Schafer (1976) como George Klein (1976), reforçando esse aspecto, promoveram propostas alternativas às de Freud; mas, cada uma de suas reformulações, embora diferentes, parece uma versão de Hamlet sem o Príncipe. Todos os conceitos de causalidade e teorias de impulso com raízes biológicas desapareceram e, na versão de Schafer, desapareceram também os conceitos de repressão e atividade mental inconsciente.

Melanie Klein fez propostas muito diferentes, algumas das quais, certamente, não sofrem dessa deficiência, mas seria difícil dizer que a forma que elas tomaram ou a pesquisa que elas engendraram preencheram os requisitos científicos.

E, ainda, de forma alguma os analistas se tornaram desanimados em desenvolver sua disciplina como uma ciência natural. Atentos às deficiências da metapsicologia de Freud, especialmente seus conceitos de energia psíquica e impulso, alguns analistas estão tentando substituí-los com uma nova estrutura conceitual sólida, conforme o pensamento científico corrente. No centro dessas novas propostas estão as idéias tiradas da teoria de sistemas e o estudo do processo de informação humana. Dentre os que se dedicaram a este empreendimento estão Rubinstein (1967), Peterfreund (1971, 1982), Rosenblat e Thickstun (1977), Gedo (1979) e eu mesmo (1969, 1980). Enquanto isso, também existe um certo número de analistas que vêm procurando estender os dados básicos da disciplina, ao estudar o desenvolvimento social e emocional das crianças, usando observação direta. Alguns desses estudos foram atóricos, e.g. Offer (1969). Os autores desses estudos tentaram colocar novo vinho empírico em velhas garrafas teóricas, e.g. Spitz (1957), Mahler (Mahler, Pine e Bergman, 1975); enquanto, novamente outros, e.g. Sander (1964, 1980), Stern (1977) e eu mesmo (1958, 1969, 1973), procuraram novos modelos teóricos. Minha própria busca me levou não só à teoria do controle e ao processo de informação mas, também, às disciplinas biologicamente enraizadas, etologia e psicologia comparada. Isso prova que não há falta de novas iniciativas e que levará tempo para vermos qual delas ou, talvez, que combinação delas provará ser a mais produtiva para o avanço científico. Nessa conferência, meu objetivo é descrever uma certa iniciativa, a minha própria, e porque eu a considero promissora.

Na conferência anterior, descrevi as circunstâncias que me levaram a escolher, como campo de pesquisa, as respostas de uma criança retirada de sua mãe e colocada, por um certo tempo, em lugar estranho, com pessoas estranhas, e de que forma essas observações me levaram a formular a teoria do apego. Entre seus traços essenciais está o de que o bebê humano vem ao mundo geneticamente predisposto a desenvolver um conjunto de modelos comportamentais que, dado um meio ambiente apropriado, terá como resultado a manutenção da maior ou menor proximidade com quem quer que cuide dele e que essa tendência de manter proximidade serve à função de proteção da criança de uma série de perigos, entre eles, no meio ambiente de adaptabilidade evolutiva do homem, o perigo de predação tende a ter sido ampliado.

Um conceito que surgiu de estudos etologicamente orientados, de relacionamentos mãe-filho (Ainsworth, 1967), de grande valor clínico, é o de uma mãe ou uma mãe substituta oferecendo a uma criança uma base segura a partir da qual ela pode explorar. Nos últimos meses do primeiro ano de vida de uma criança, criada num lar afetoso e comum, é muito claro saber por quem essa criança prefere ser cuidada, preferência especialmente evidente, quer ela esteja cansada, assustada ou mesmo doente. Quem quer que seja — usualmente, é a mãe — então é capaz, pela sua presença ou total disponibilidade, de criar condições que permitam ao seu filho explorar seu

mundo de maneira confiante. Na ocasião de seu segundo aniversário, por exemplo, uma criança saudável, cuja mãe esteja descansando num banco de jardim, fará uma série de passeios para longe dela, cada vez voltando a ela antes de fazer novos passeios. Em algumas ocasiões, quando volta, a criança simplesmente sorri e marca sua presença; outras, ainda, ela quer subir em seu colo. Mas a criança nunca fica muito tempo, a menos que esteja assustada, cansada ou que pense que a mãe vai sair. Anderson (1972), que fez um estudo dessa espécie, num parque de Londres, observou que durante o segundo e o terceiro ano é muito raro uma criança ir mais longe do que mais ou menos trinta metros, antes de voltar. Se ela perder a mãe de vista, o passeio exploratório é esquecido. Sua prioridade, então, é recuperá-la; uma criança mais velha, procurando e uma criança mais nova, gritando.

É evidente que não existe uma maneira de explicar esse tipo de comportamento em termos de uma estrutura de energia psíquica que é, então, descarregada. Um modelo alternativo (já descrito em conferências anteriores) é pensar na manutenção da proximidade, por parte da criança, como sendo mediada por uma série de sistemas comportamentais organizados ciberneticamente. A ativação é intensificada em condições de dor, fadiga e qualquer coisa que seja assustadora; e é reduzida pela proximidade ou contato com a figura-materna. Podemos, então, postular que o comportamento que o leva para longe da mãe, em direção ao grande mundo, que é convenientemente chamado de comportamento exploratório, é incompatível com o comportamento de apego e tem uma prioridade menor. Então, é somente quando o comportamento de apego está relativamente inativo que o de exploração ocorre.

Deve ser observado que quando um indivíduo cresce, sua vida continua a ser organizada da mesma maneira, embora suas saídas tomem-se firmemente mais longas, tanto em termos de tempo quanto de espaço. Ao entrar na escola, elas duram horas ou dias. Durante a adolescência, podem durar semanas ou meses e é provável que novas figuras de apego sejam procuradas. Durante toda a vida adulta, a disponibilidade de uma figuras de apego, que ofereça respostas, permanece sendo a fonte dos sentimentos seguros de uma pessoa. Parece que todos nós, do berço ao túmulo, somos mais felizes quando a vida é organizada como uma sequência de saídas, longas ou curtas, da base segura suprida pela(s) nossa(s) figura(s) de apego.

Em termos de modelo teórico proposto, as mudanças pronunciadas na organização do comportamento de apego, que ocorrem durante o desenvolvimento do indivíduo, são consideradas, em parte, como sendo devidas ao limiar de sua atividade ter sido aumentado (talvez através de mudanças em níveis endócrinos) e, em parte, devido a os sistemas de controle terem se tornado cada vez mais sofisticados, especialmente ao se incorporarem aos modelos representacionais do meio ambiente e das pessoas importantes nele e, também, do *self* como uma pessoa ativa e viva.

Durante a ontogenia, o desenvolvimento de uma série de sistemas do tipo descrito nos seres humanos, bem como nos indivíduos de outras espécies, é atribuído à ação da seleção natural, a saber, indivíduos bem-dotados com potencial para desenvolver tais sistemas, tendo sobrevivido e se criado com mais sucesso do que os menos bem-dotados; em outras palavras, a evolução de Darwin. Desde que a disposição para mostrar o comportamento de apego, em certas circunstâncias, é considerada como uma parte intrínseca da natureza humana, a referência a ela como "dependência" não é só enganadora, mas seriamente inapropriada por causa das implicações pejorativas da palavra.

Será notado que uma vez que o comportamento de apego e outras formas de comportamento determinados biologicamente sejam expressos em termos de teoria de controle, o problema do propósito do comportamento é resolvido sem abandonar o conceito de causação. Além disso, a distinção entre causação e função, tristemente negligenciada na teoria psicanalítica tradicional, torna-se explícita. A ativação, na qual o surgimento da emoção e sua expressão têm um papel crítico e, subsequentemente, a terminação, a mudança de estado emocional, são causados quando um sistema construído de uma maneira especial recebe informações de tipos especiais. Das várias consequências que a ativação leva, a evidência sugere que a postulada como função biológica é a que levou o sistema ter nascido durante a filogenia. No caso do comportamento de apego, a função postulada é a de diminuir o risco do indivíduo de entrar em perigo.

Nesse ponto da análise, a questão da pessoa estar ciente do que está fazendo, não é relevante — sem considerar porque ela está fazendo. De fato, não é mais relevante a pessoa estar ciente de estar respirando do que porque está respirando. Os sistemas biológicos servindo de funções vitais, tanto num nível comportamental como fisiológico, devem ser capazes de operar automaticamente. Apesar disso, o fato de uma criança estar consciente do que está fazendo e, mais especialmente, consciente das condições que porão fim ao seu comportamento, surge logo, certamente, no fim do primeiro ano e é um fator de grande importância. Por que, uma vez que esteja claro que uma criança está atenta às condições que põem fim ao seu comportamento, começaremos a falar de intenção, do seu desejo de alcançar uma certa meta, da sua satisfação e felicidade quando atinge esse objetivo e frustração, ansiedade e raiva, quando falha; a satisfação trazendo prazer e a frustração trazendo o oposto.

Nesse ponto, desejo enfatizar a forte distinção entre as condições necessárias para pôr fim a uma certa forma de comportamento, comumente referido como sua meta, e a função biológica a que o comportamento serve. No caso do comportamento de apego na infância, considerando que nós comumente esperamos que tanto a mãe como a criança estejam atentas às condições necessárias para terminar, por exemplo, um certo grau de proxi-

midade, não esperamos consciência da função. O mesmo se afirma no caso de comer e no comportamento sexual. A maioria de nós está ciente que ingerir alimentos amenizará nossa fome e nós sentimos prazer em comer; mas só os "sofisticados"* estão preocupados com sua função nutricional. Da mesma forma, o desejo sexual pode ser atenuado sem a preocupação com a função reprodutiva. Em ambos os casos, todos, exceto os "sofisticados", estão preocupados somente com o desejo de se comportarem de uma certa maneira e com o prazer antecipado e recebido ao alcançar suas metas e não com a função biológica à qual o comportamento pode servir. De fato, frequentemente, quando nos sentimos emocionalmente impelidos a agir de uma certa maneira, que é prontamente explicável em termos de função biológica, inventamos "razões" para agir assim, razões essas que contêm pouca ou nenhuma relação com as causas do nosso comportamento. Por exemplo, uma criança ou adulto que, a fim de reduzir o risco, estão biologicamente dispostos a responder a sons estranhos, no escuro, procurando sua figura de apego, dão o medo a fantasmas como sendo suas razões. Isto é análogo às "razões" inventadas para o comportamento de alguém que, sem saber, está agindo sob uma sugestão pós-hipnótica.

A distinção que estabeleci entre a função a serviço de uma certa forma de comportamento e o nosso conhecimento, e nossa luta para alcançar as condições que terminam aquele comportamento, é o critério que distingue o domínio biológico do psicológico. Uma outra diferença está entre, de um lado, o sistema comportamental postulado como comportamento biológico, junto a algumas (embora nem todas) das condições que o ativam e o finalizam e, por outro lado, nossa consciência do impulso para alcançar uma certa meta e nosso esforço para encontrar meios de fazê-lo.

Anteriormente, observei que ao entender o desenvolvimento do indivíduo, também é necessário considerar o meio ambiente no qual cada indivíduo se desenvolve, assim como os potenciais genéticos com os quais ele é dotado. A estrutura teórica que melhor se adapta a esses propósitos é a dos caminhos de desenvolvimento proposta pelo biólogo C. H. Waddington (1957).

Dentro dessa estrutura, a personalidade humana é concebida como sendo uma estrutura que se desenvolve incessantemente ao longo de uma opção dentre caminhos possíveis e discretos. Parece que todos os caminhos começam juntos, de maneira que, no princípio, um indivíduo tem acesso a uma grande variedade de caminhos ao longo dos quais ele poderia caminhar. O caminho escolhido, afirma-se, faz voltas a cada passo, numa interação entre o organismo, como ele se desenvolveu até aquele momento e o meio ambiente no qual ele, então, se encontra. Assim, no princípio, o desenvolvimento depende da interação entre o genoma, recentemente formado, e o

* N.T. *Sophisticated* refere-se a pessoas mais exigentes, cultural e socialmente. Pessoas com maior nível de exigência.

meio ambiente intra-uterino; no nascimento, ele gira em volta da interação entre a constituição biológica do recém-nascido, incluindo sua estrutura mental germinal e a família — ou não-família — na qual ele nasceu; e a cada idade, sucessivamente, ele gira em volta das estruturas da personalidade, então presentes, e da família e, mais tarde, do meio ambiente social maior do momento.

O número total de caminhos, potencialmente abertos a um indivíduo, é determinado pela estrutura do genoma. Como o desenvolvimento prossegue e as estruturas se diferenciam progressivamente, o número de caminhos que permanecem abertos diminui.

Acredito que a variável principal no desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo seja o caminho ao longo do qual seu comportamento de apego passa a ser organizado e, ainda mais, que este caminho seja determinado, em alto grau, pela maneira pela qual as figuras parentais o tratam, não só durante o início de sua vida, mas através de sua infância e adolescência. O meio principal, pelo qual tais experiências influenciam o desenvolvimento da personalidade, é através de seus efeitos, através de como uma pessoa interpreta o mundo a sua volta e como ela espera que as pessoas a quem ela deveria se apegar se comportem; ambos são derivativos dos modelos representacionais de seus pais, que ela formou durante sua infância. A evidência sugere que esses modelos tendem a persistir, relativamente, sem modificação, num nível inconsciente, e são reflexões corretas de como seus pais realmente o tratavam, mais do que a opinião tradicional supunha. Dentro dessas estruturas, as observações de comportamento e sintomas neuróticos são imaginados como sendo devido às interações que ocorreram e que ainda podem estar ocorrendo entre a personalidade de um indivíduo, como ele até agora se desenvolveu, e a situação na qual esse indivíduo, agora, se encontra.

Paremos aqui, por um momento. Emboçando a estrutura conceitual que eu defendo, sem dúvida, já disse o suficiente para que vocês vejam um certo número de pontos nos quais ela difere da tradicional. Por exemplo, a teoria da motivação apresentada difere radicalmente da teoria de energia e impulso psíquico de Freud, e a teoria do desenvolvimento difere, em grau semelhante, de suas teorias das fases libidinais, de fixação e de regressão. Além disso, o conceito de comportamento de apego é visto como uma forma distinta e com status igual ao comportamento alimentar e sexual e como uma característica presente durante toda a vida. Onde se encontram as origens de todas essas diferenças?

Durante o período de formação do pensamento de Freud, ele estava profundamente interessado em biologia e preocupado em formular uma teoria psicológica, em termos condizentes com o pensamento biológico corrente. Isto o levou a explorar as idéias de Darwin e outros evolucionistas do período. Naquela época, na mudança do século, a teoria da variação e seleção natural de Darwin, como agentes da evolução, estava longe de ser a teoria

dominante que é hoje. Ao contrário, as teorias de Lamarck referentes à herança de características adquiridas e à influência que o “mais profundo sentimento de necessidade de um animal” — que se pensou ter nessa estrutura — eram mais populares. Assim, também, foi a lei biogenética de Haeckel que, alegando que a ontogenia recapitulava a filogenia, deixou de lado o fato de que as pressões de seleção operam em todas as fases do ciclo da vida e que novas espécies, freqüentemente, surgem de formas imaturas das formas anteriores (neotenia). Como sabemos, Freud foi profundamente influenciado tanto por Lamarck como por Haeckel e ele elogiava suas idéias, repetidamente, junto a seus alunos.* O resultado foi que muito da sua metapsicologia e toda a sua psicologia do desenvolvimento vieram a ser baseados em princípios já há muito tempo abandonados pelos biólogos.

Se, entretanto, a psicanálise vier a se tornar uma ciência natural, como Freud pretendia, baseada profundamente em princípios biológicos, existirão sérias razões para mudanças drásticas, pelo menos em algumas das suas suposições básicas. A estrutura que estou apresentando, baseada nos princípios neodarwinianos e no trabalho corrente de psicologia do desenvolvimento e processo de informação humana, é uma tentativa.

Embora a psicanálise seja, reconhecidamente, uma disciplina em desenvolvimento, creio não ser em parte alguma mais fraca do que em seus conceitos de desenvolvimento. A maioria dos mais influenciáveis deles, por exemplo, o de fase libidinal, se originaram diretamente de Haeckel. Assim, nas suas *Conferências Introdutórias* de 1916-17, Freud enfatiza que o desenvolvimento, tanto do ego quanto da libido, deve ser entendido como “recapitulações abreviadas do desenvolvimento que toda a humanidade passou desde os seus primórdios” (Freud, 1917, 354), enquanto o desenvolvimento da libido é também visto em termos de filogenia e das várias formas tomadas pelo aparelho genital em animais. No estudo de um caso clínico, publicado na mesma época, ele atribui as idéias de uma pessoa de “observar a relação sexual entre os pais, de ser seduzido na infância e de ser ameaçado de castração... a um legado hereditário, uma herança filogenética”; e ele também afirma que o complexo de Édipo está entre “os esquemas herdados filogeneticamente” (Freud, 1918, 97 e 119). Todas essas idéias estão repetidas no seu trabalho final, e.g. Freud 1939, 99.

Agora, pode ser que poucos analistas, hoje em dia, concordem com as formulações originais de Freud; e pode não haver dúvida sobre sua ampla

*Sobre a adesão de Freud às idéias de Lamarck, veja volume 3, cap. 10 da biografia escrita por Hones (Jones, 1957). Sobre a influência da lei biogenética de Haeckel, veja a longa nota de rodapé de James Strachey para sua tradução de *Moisés e o Monoteísmo* de Freud (SE 23, p. 102) e, especialmente, a recente pesquisa de Frank Sulloway acerca das origens da metapsicologia de Freud (Sulloway 1979).

influência, não só no que é ensinado, mas na suposição que prevalece de como nosso entendimento do desenvolvimento emocional e social é melhor favorecido. Assim, uma posição de superioridade continua a ser dada às reconstruções baseadas no que é observado e inferido durante sessões de tratamento, unida a uma relutância persistente, embora fraca, em dar séria atenção a um trabalho enormemente importante que continua agora no campo da psicologia do desenvolvimento. Já que, em muitas publicações anteriores, eu chamei atenção para a relevância desse trabalho, preciso somente dizer que acreditado que todos os conceitos de desenvolvimento da psicanálise terão que ser reexaminados e que a maioria deles terão que ser substituídos, na ocasião oportuna, por conceitos agora correntes, entre aqueles que estão estudando o desenvolvimento dos laços afetivos em bebês e crianças pequenas, por meio de observação direta. A restrição com a qual muitos médicos viram esse tipo de trabalho no passado, creio, seria desfeita se eles fossem familiares às observações e idéias de tais líderes atuais no campo, como, por exemplo, Mary Ainsworth (1977), John e Elizabeth Newson (1977) e Colwyn Trevarthen (1979).

Mesmo que muitos psicanalistas pareçam não conhecer o valor e a própria existência desses estudos, há, folgo em, dizer, um número crescente de terapeutas que dão atenção a eles, no seu tratamento com pacientes. Entretanto, voltemos ao campo clínico e consideremos a avaliação dada por um analista californiano referente ao tratamento de uma paciente com problemas que ele atribuiu, creio, a acontecimentos que se seguiram ao divórcio dos pais e ao longo período durante o seu quinto e sexto ano de vida, quando ela ficou numa instituição. Esse relatório * não só ilustra as espécies de problemas de angústia pessoal para os quais as experiências desse tipo levam, incluindo ambivalência intensa, mas também serve para propor questões de como as emissões de defesa e afeto são respondidas dentro da estrutura conceitual, que estou propondo.

Os problemas que levaram a Sra. G. à análise foram: sentia-se irritável, deprimida e cheia de ódio e maldade, como ela própria contou. Além disso, sentia-se fria com o marido, emocionalmente desapegada e desejando saber se seria capaz de amar alguém.

A Sra. G. tinha três anos quando seus pais se divorciaram. Seu pai deixou o lar e sua mãe, que começou a trabalhar fora durante muitas horas, tinha pouco tempo para ela. Um ano mais tarde, quando a Sra. G. tinha quatro anos, sua mãe colocou-a num orfanato, onde ela

* A avaliação dada aqui é derivada da contribuição de Thomaz Mintz para um simpósio organizado pela Associação Psicanalítica Americana, sobre os efeitos da perda objetual nos adultos, durante os cinco primeiros anos de vida (Mintz, 1976).

permaneceu por dezolito longos meses. Depois disso, embora ela tivesse voltado para perto de sua mãe, o relacionamento familiar continuou a ser perturbado e infeliz. Como resultado, a Sra. G. saiu de casa na adolescência e antes de completar vinte e um anos, já tinha casado e divorciado duas vezes. Seu atual marido era o terceiro.

Nas fases iniciais da análise, a Sra. G. foi extremamente relutante para lembrar de acontecimentos dolorosos de sua infância; e quando conseguia se lembrar, caía em prantos e soluços. Mesmo assim, o seu analista a encorajou a refletir mais sobre eles e fazer isso nos mínimos detalhes, já que ele acreditava que isso a ajudaria. Ao mesmo tempo, ele prestou, no mínimo, igual atenção ao relacionamento de sua paciente com ele, onde, como era de se esperar, todas as dificuldades interpessoais, que ela tinha tido em outras relações mais próximas, se repetiam.

Entre outras muitas coisas de sua infância, que foi dolorosa, a Sra. G. se lembrou de como tinha se sentido triste ao ser separada de seus animais de estimação, quando foi mandada para o orfanato. Às vezes, sonhava com seu tempo no orfanato, em que se sentia sobrecarregada de emoções negativas. Ela lembrava de sentir-se muito pequena entre tantas crianças, de não haver binquedos, do duro tratamento que recebeu e como ela, algumas vezes, tinha se comportado mal deliberadamente a fim de ser espancada (o que, no mínimo, significava que estavam lhe dando alguma atenção - J.B.)

Depois de quatro anos de análise, a situação financeira da Sra. G. levou-a a decidir parar o tratamento em seis meses. Inevitavelmente, os conflitos emocionais que ela tinha com o analista se tornaram mais agudos. Ela, agora, sonhava e fantasiava mais abertamente com ele. De início, ela notou que partir seria doloroso. As separações sempre a fizeram furiosa e, como agora conta... “a raiva me faz ficar triste porque significa o fim... eu tenho medo que você me deixe ou me ‘chute’, me mande embora”. O analista lembrou-lhe como tinha se sentido quando foi mandada para o orfanato. Lutando para se achar auto-suficiente, ela exclamou: “estou me cuidando sozinha, estou tomando conta de mim, eu mesma”.

Alguns meses mais tarde, ao se aproximar o término do tratamento, ela relacionou a maneira como se sentia em relação ao analista e como tinha se sentido, anteriormente, em relação à sua mãe: “Eu não quero me separar da minha mãe, eu não quero deixar que ela vá - ela não vai se livrar de mim”. Nesse estágio de sua análise, a sua necessidade intensa de amor e carinho tinha retornado junto com sua raiva daqueles que tinham negado isso a ela.

A mudança radical, que tinha ocorrido nessa mulher, foi confirmada por outros episódios. Por exemplo, durante os primeiros dias da análise, seu gato morreu, mas ela ficou indiferente a isso. Ela,

então, explicou: "Se eu deixasse isso me ferir, eu ficaria triste por tudo. Isso iria precipitar todo o resto". Mas agora, perto do fim da análise, quando um outro gato morreu, ela chorou.

Embora a terapia tenha restaurado o sentido de vida dessa paciente e tenha resultado em sua capacidade de estabelecer melhores relacionamentos, incluindo o relacionamento com sua mãe, um *follow up*, cinco anos mais tarde, mostrou, como já se esperava, que ela permaneceu vulnerável a situações que despertavam ansiedade e tristeza, como separação e perda.

Examinemos a mudança que tinha ocorrido nessa mulher, cuja condição poderia ser descrita, clinicamente, como esquizóide (Fairbairn, 1940) ou *false self* (Winnicott, 1960, 1974) ou como narcisista (Kohut, 1971). Antes da análise, ela tinha se sentido emocionalmente desapegada e queria saber se seria capaz de amar alguém; uma perda deixou-a sentindo-se indiferente. Agora, ela se tornou ciente do quão profundamente ela desejava amor e carinho e como ela ficava zangada quando não lhe davam; uma perda a levava às lágrimas. Assim, respostas carregadas de profundo afeto apareceram em situações onde, anteriormente, faltavam respostas.

Para explicar, da forma tradicional, uma mudança tão grande, tende-se a usar uma metáfora hidráulica: o afeto foi retido e agora descarregado. O bloqueio é considerado como uma defesa contra uma quantidade excessiva de excitação, que está em perigo de sobrecarregar o ego. Outras explicações invocam processos postulados como ocorrendo na infância, por exemplo, fixação numa fase de narcisismo ou uma ruptura no ego resultante da projeção de um instinto de morte.

Uma explicação da condição dessa mulher, que eu creio está muito mais perto do nosso atual conhecimento do desenvolvimento anterior de laços afetivos e de acordo com o que nós conhecemos sobre o processo de informação humana, funciona da seguinte maneira: como resultado da intensa dor causada a ela, durante os seus primeiros anos de vida, pela prolongada e, provavelmente, repetida frustração do seu comportamento de apego, o sistema comportamental que governa o seu comportamento de apego tinha se tornado desativado e tinha permanecido assim, apesar de ela ter desejado o oposto. Como resultado, os desejos, pensamentos e sentimentos, que são parte e porção do comportamento de apego, estavam ausentes de sua atenção. A desativação, em si, pode ser entendida como devido a uma exclusão seletiva do processo de qualquer informação que, quando processada, levaria a uma ativação do sistema.

A exclusão seletiva postulada, que o trabalho experimental recente mostra e que eu chamo de exclusão defensiva, está bem dentro das capacidades do nosso aparato cognitivo (Dixon, 1971; Erdelyi, 1974) e necessita de cons-

tante atividade cognitiva em nível inconsciente. O fato de os sistemas comportamentais permanecerem intactos e incapazes, em princípio, de serem ativados e, assim, poderem em algumas ocasiões mostrar uma ativação breve e incipiente, pode explicar todos os fenômenos que levaram Freud às suas idéias sobre uma dinâmica inconsciente e o conceito de repressão. De fato, a exclusão defensiva que eu postulo não é nada mais do que repressão sob um outro nome, um nome mais de acordo com a estrutura conceitual adotada aqui.

O processo de mudança terapêutica nessa paciente pode, então, ser entendido como devido a paciente, graças à base relativamente segura dada por seu analista, estar desenvolvendo coragem suficiente para permitir algumas das informações, até agora excluídas, para continuar o processo. Isso inclui tanto a informação originada da atual situação, como, por exemplo, a evidência da preocupação genuína do analista em ajudar seu paciente e os pensamentos conflitantes, sentimentos e comportamentos que isso desperta, como, também, a informação guardada na memória como, por exemplo, recordações de acontecimentos muito dolorosos da infância e os pensamentos, sentimentos e comportamentos despertados por eles. Geralmente, as informações dessas duas fontes são recuperadas como uma cadeia na qual a informação do presente, especialmente a transferência, altera com a informação do passado, com cada elo levando ao seguinte. Uma vez que a informação importante é aceita, é claro, o comportamento de apego é reativado paralelamente aos impulsos, desejos, pensamentos e sentimentos. Em termos tradicionais, o inconsciente se fez consciente e os impulsos e afetos reprimidos foram libertados.

Com frequência, como no caso dessa paciente, um analista tem a tarefa de chamar a atenção do paciente para recordações, que ele acredita serem importantes, e encorajá-lo a refletir sobre elas, ao invés de virar as costas a elas. Assim procedendo, um analista é guiado naturalmente, quaisquer que sejam as teorias do desenvolvimento da personalidade e psicopatologia em que ele possa acreditar. Esse é um ponto no qual os analistas de diferentes escolas divergem. Para alguns, os acontecimentos considerados importantes podem se referir a alimentar e desmamar e as respectivas fantasias durante os primeiros meses de vida; para outros, o treinamento higiênico ou testemunhar a cena *primeva*, durante o segundo ano de vida; para outros, as situações e desejos edípiacos, durante o terceiro e quarto anos. No caso da Sra. G., o analista extraiu o seu conhecimento de respostas de crianças pequenas a acontecimentos em torno de uma separação prolongada da mãe, durante os primeiros anos de vida.

É reconhecido que nem todas as crianças que estiveram em instituições por dezoito meses, durante os seus cinco ou seis anos de vida, se desenvolvem psicologicamente ao longo do mesmo caminho seguido pela Sra. G. No seu caso, outros fatores, provavelmente, contribuíram. Considerando quais

poderiam ter sido, estou influenciado por observações que a Sra. G. fez durante as fases finais da análise, por exemplo, seu medo de que seu analista a mandasse embora ou a pusesse para fora e a lembrança de sua determinação em pensar que a mãe não se livraria dela. Isso sugere que, como um método de disciplinar a filha, a mãe deva tê-la ameaçado repetidas vezes de mandá-la de volta à instituição, ameaças que nós sabemos, de outras evidências, que estão longe de serem raras e que não só têm um efeito aterrorizante numa criança pequena, como também é provável que gerem nela um intenso ódio. Quanto melhor for o conhecimento de um analista sobre as condições da infância que, provavelmente, levam ao desenvolvimento perturbado, melhor ele pode entender e ajudar seus pacientes.

Inevitavelmente, as lembranças espontâneas ou guiadas da infância de um paciente são de valor somente sugestivo, como prova relevante das teorias do desenvolvimento da personalidade. O que um paciente nos diz sobre a sua infância e, especialmente, o que um analista, logo depois, relata sobre o que o paciente teria dito, são provavelmente mais influenciados pelos preconceitos do analista do que por qualquer coisa que o paciente possa, de fato, ter feito ou dito; eis porque eu considero o estudo sistemático, pela observação direta do desenvolvimento das crianças dentro dos diversos moldes de cuidado familiar, como indispensável para o progresso. Eu também acredito que as observações feitas durante a terapia ainda têm considerável potencial de pesquisa, embora esse potencial não seja percebido, a menos que os estudos sejam conduzidos ao longo de muito mais linhas sistemáticas do que foi de costume até agora, e os dados obtidos, durante a terapia, sejam constantemente comparados com os dados derivados de outras fontes.

A força da pesquisa da situação terapêutica não está no que ela nos diz sobre o passado do paciente, mas no que ela nos diz sobre as perturbações do funcionamento da personalidade no presente, especialmente, eu chamo atenção, perturbações na capacidade de uma pessoa estabelecer apegos seguros e as condições nas quais estas perturbações melhoram. O caso da Sra. G. pode ser usado como introdução para uma proposta de pesquisa, já que existem muitas provas de perturbação da personalidade que ela apresentou no decorrer de sua análise, que temos motivos para acreditar serem bastante típicos.

Através de relatórios de casos clínicos, já na literatura, seria possível fazer um certo número de generalizações que poderiam, então, ser tratadas como prognósticos a serem testados num trabalho terapêutico futuro com pacientes mostrando aspectos clínicos semelhantes. Todos esses prognósticos, que seriam condicionados ao molde especial de terapia a ser seguida *,

* A técnica de análise adotada por Mintz parece ter muito em comum com a adotada no Reino Unido por Donald Winnicott; veja a avaliação de Guntrip (1975).

poderiam ser expressos em termos do que pode ser observado em primeira mão. Eles incluiriam frases sobre como se espera que um paciente se comporte diante de um analista, os tópicos sobre os quais se espera que o paciente fale ou em especial evite falar, o afeto que se espera que ele mostre ou não e em quais situações. Seriam de interesse especial as mudanças de comportamento, os assuntos e afetos que se espera que ocorram em relação a certos tipos de acontecimentos correntes, tanto aqueles que ocorrem no dia-a-dia do paciente como aqueles que ocorrem dentro da análise. Acontecimentos que ocorrem dentro da análise incluiriam como o analista se comporta, o que ele fala com referência especial às interrupções na análise, devido às férias, feriados, doenças e outras circunstâncias. Gravações das sessões, para evitar uma predisposição no relato, seriam, naturalmente, necessárias.

Seguindo os procedimentos propostos, seria possível, por um curto período de tempo, colher um comparável grupo de dados de duas fontes. Um grupo de dados seria colhido por meio de observação direta do desenvolvimento e molde de laços afetivos, durante a primeira e segunda infância em crianças, experimentando diferentes tipos de cuidado. O outro grupo seria colhido por observação direta de mudanças no molde de laços afetivos, durante o curso de um certo tipo de terapia. Considerando as estruturas conceituais usadas para fazer os dois grupos de observação e as perguntas que se referem a cada grupo sendo as mesmas, as descobertas poderiam ser comparadas e as hipóteses de desenvolvimento testadas.

Esta é apenas uma maneira pela qual a psicanálise, como um corpo de conhecimento sobre o desenvolvimento da personalidade e psicopatologia, podia agir, a fim de tornar-se a "ciência natural" que Freud tanto desejou que fosse.

Creio que a estrutura conceitual que esbocei serve para acomodar uma proporção substancial de dados que a psicanálise selecionou como sendo de seu domínio e já orienta programas de pesquisa produtivos (e.g. Parkes e Stevenson-Hinde, 1982). A estrutura tem a vantagem de ser compatível com a biologia evolucionista e a neurofisiologia, e promete maior economia de consistência interna do que as estruturas tradicionais. Não obstante, o que sua força e sua fraqueza provarão ser, não será conhecido sem que sejam testados, extensivamente, os seus poderes para resolver problemas ainda não estudados, que incluem, por exemplo, aqueles do desenvolvimento e desvios sexuais, e um exame mais intenso do que até hoje foi possível, de sua utilidade em resolver os problemas que já receberam atenção.

Finalmente, devemos considerar os pontos levantados por aqueles que sustentam que a psicanálise não é nem pode ser uma ciência natural. O argumento deles, sabemos, parte da crença de que o método científico é inseparável do positivismo lógico e do reducionismo. Embora mantido, no início desse século, de forma confiante e, freqüentemente, dogmática, esse modelo de ciência está agora descartado e seu lugar foi tomado pela filosofia

de epistemologia evolucionista (Popper, 1972, Lakatos, 1974). Esta sustenta que todo conhecimento é conjectural e que a ciência progride através de novas teorias que vêm tomar o lugar das antigas, quando se torna claro que uma nova teoria é capaz de fazer sentido num círculo maior de fenômenos do que os compreendidos e explicados pelas antigas teorias, e que também é capaz de prever novos fenômenos de forma mais acurada.* Esse mesmo método é seguro para ser aplicado em todas as ciências teóricas ou de generalizações, quer elas lidem com fenômenos físicos, biológicos ou sociais.

Além disso, posto que compreender os fenômenos, em qualquer nível de complexidade, demanda conceitos apropriados para cada um dos níveis, a noção de que os fenômenos complexos têm que ser explicados em termos de conceitos apropriados para um nível baixo de complexidade - quer dizer, reducionismo - é agora reconhecidamente enganadora. A forma como essas novas idéias se aplicam a nosso campo é habilmente discutida por Holt (1981), Blight (1981) e Radford (1983).

Embora o método científico tenha muito valor, como forma de obter conhecimento relativamente confiável de resolver diferenças de opiniões e de fazer previsões úteis, suas limitações são, no entanto, consideráveis. Uma delas é que a ciência lida com generalidades e tem pouco a dizer sobre eventos específicos e singulares. Essa é uma distinção vital, como o físico Weisskopf (1981) chamou atenção. Nas ciências físicas isso não importa, já que os físicos e os engenheiros não têm interesse no futuro de nenhum átomo ou molécula em especial. Uma vez que nos voltamos para as ciências biológicas, passa a ser importante, porque os biólogos estão, frequentemente, interessados em organismos individuais, onde cada um é diferente do outro. Em algumas das ciências humanas, entretanto, o exemplo individual é a essência do caso. Por exemplo, na História, quer lidemos com sociedades ou pessoas ou idéias, a preocupação é sempre com a sequência assustadoramente complexa da interação de eventos, altamente específica, que nenhuma quantidade de ciência pode nos capacitar a explicar adequadamente, que dirá, prever. Então, a distinção entre as ciências naturais e as ciências históricas não reside no fato de elas usarem métodos diferentes para obter conhecimento, mas no fato dos problemas que ambas lutam para compreender e os critérios que adotam serem muito diferentes. Uma se preocupa em formular leis gerais em termos de probabilidades, a outra em compreender eventos específicos e singulares, com a maior quantidade de detalhes possível. A distinção é central na discussão como um todo.

Sob o rótulo de "psicanálise", está claro, duas disciplinas complementares estão lutando para viver e se desenvolver. Já que estamos tentando

* O critério de falsificação aos quais Popper, primeiramente, deu bastante ênfase não é mais considerado proeminente; embora a constante comparação das previsões teóricas derivadas de um crescente número de dados observados permaneça central.

compreender os princípios gerais, que expliquem o desenvolvimento da personalidade e psicopatologia, é necessário, por exemplo, se quisermos saber que formas de cuidado com a criança tendem a produzir determinados tipos de formação de personalidade, adotar os critérios das ciências naturais. Fazemos o mesmo quando tentamos compreender os traços essenciais de uma terapia efetiva. Nesses campos, estamos lidando com probabilidades estatísticas. Já que estamos preocupados em compreender os problemas pessoais de um dado indivíduo e quais os eventos que podem ter contribuído para o seu desenvolvimento, necessário será, se queremos realmente ajudá-lo (embora longe de ser o suficiente), adotar os critérios das ciências históricas. Cada abordagem contribui para nossa compreensão; mas, como chamei atenção na conferência anterior, somente se tivermos clareza sobre o que pertence a cada uma, estaremos capacitados a fazer algum progresso.

Conferência 5 ✓

Violência na família

Na primavera de 1983, fui convidado para dar a trigésima primeira conferência anual Karen Horney, pela Associação para o Avanço da Psicanálise, que estava acontecendo em New York. A principal razão que me levou a selecionar o tema — violência na família — foi que algumas pesquisas, usando a perspectiva da teoria do apego, começavam a lançar alguma luz nesse problema trágico e intrigante, que até muito recentemente vinha sendo quase que completamente abandonado por quase todos do campo da saúde mental, não me incluindo, certamente.

Introdução

Parece-me que, como psicanalistas e psicoterapeutas, temos sido terrivelmente vagarosos para enfocar as muitas conseqüências do comportamento violento entre os membros da família e, especialmente, a violência dos pais. Esse tema na literatura analítica e em programas de treinamento tem atraído a atenção pela sua ausência. Existe, agora, uma abundância de provas de que a violência não só é mais comum do que até então supúnhamos, como também é uma das maiores responsáveis por um certo número de síndromes psiquiátricas confusas e dolorosas. Além disso, como violência gera violência, nas famílias isso tende a se perpetuar de uma geração a outra.

Por que a violência familiar, como um fator causal na psiquiatria, foi negligenciada pelos clínicos — embora, certamente, não o tenha sido pelos assistentes sociais — deveria ser um tópico de estudo que não cabe iniciar

aqui. Um fator responsável por essa negligência foi a concentração, nos círculos analíticos, em estudos a respeito das fantasias e a relutância em examinar o impacto dos eventos da vida real. Desde que Freud fez sua famosa e, ao meu ver, desastrosa mudança, em 1897, ao afirmar que as seduições infantis, que ele acreditava serem etiológicamente importantes, não eram nada além do que produto da imaginação de seus pacientes, tem sido extremamente desatualizado considerar psicopatológicas as experiências da vida real. Não é tarefa de uma analista, como diz a sabedoria convencional, considerar como os pais do paciente podem realmente tê-lo tratado; sem mencionar a possibilidade, até mesmo a probabilidade, de um certo paciente ter sido alvo de palavras e feitos violentos por parte de um ou de ambos os pais. Dar atenção a tais possibilidades — tem sido dito freqüentemente — é estar seduzido pelas estórias preconceituosas de nossos pacientes, é tomar partido, é punir injustamente pais perfeitamente corretos. E em qualquer caso — é declarado — fazer isso pode não ser de valia alguma para o paciente, mas seria, de fato, antiterapêutico. Quando comecei meu trabalho profissional, era considerado tabu discutir o comportamento adverso dos pais em relação a seus filhos. Foi exatamente por isso que decidi pesquisar os efeitos, nas crianças, dos eventos da vida real, especialmente, separação e perda.

Certamente, Karen Horney, em cuja estima nos encontramos hoje, não concordava com tais preconceitos. Ao contrário, ela era bastante explícita ao atribuir muitos dos problemas de seus pacientes às influências adversas que eles tiveram quando crianças. Como ela escreveu nas páginas de abertura de seu livro *Neurose e Desenvolvimento Humano*, essas influências adversas “se reduzem ao fato de que as pessoas no meio ambiente estão envolvidas em suas próprias neuroses para poderem amar seu filho ou mesmo concebê-lo como indivíduo especial que é...”. Ela faz uma lista das muitas formas pelas quais, infelizmente, os pais podem exercer uma influência negativa em seus filhos. Mas eu sei muito bem que esses pontos de vista nem sempre foram bem recebidos pelos seus colegas.

A situação hoje está mudando, embora ainda muito lentamente. Por exemplo, ninguém que não seja cego pode continuar duvidando de que muitas crianças são espancadas por seus pais, tanto verbal quanto fisicamente ou de ambas as formas e que muitas mulheres são espancadas pelos maridos ou namorados. Além disso, o nosso horror ao constatar que os pais podem se comportar dessa forma é, hoje em dia, diminuído pelo nosso crescente conhecimento do tipo de infância que esses próprios pais tiveram. Enquanto o horror acerca de seus atos é inevitável, uma maior compreensão de por que eles chegaram a se comportar dessa forma violenta clama por compaixão mais do que por culpa. Longe de desejarmos injustiçar os pais, nós desejamos ajudá-los. Longe de nos recusarmos a ver que, às vezes, os pais se engajam em comportamentos horríveis, nós procuramos certas formas de

socorrer nas emergências, tanto os jovens quanto os velhos, psicológica e fisicamente. Acima de tudo, procuramos formas de prevenir o desenvolvimento de modelos violentos em novas famílias. Temos a esperança de que a política de não querer ver já tenha tido seu dia.

Estrutura conceitual

Ao procurar compreender os exemplos mais extremos de violência na família, é necessário, primeiro, considerar o que conhecemos a respeito dos exemplos diários mais moderados de zanga entre os membros da família. As crianças pequenas — e freqüentemente as mais velhas também — são comumente ciumentas da atenção que a mãe dá ao bebê novo. Os amantes discutem, quando um dos dois pensa que o outro está olhando para outro lugar, e o mesmo é verdade após o casamento. Além disso, uma mulher pode se zangar com seu filho se ele faz alguma coisa, como sair correndo pela estrada, e também com seu marido, se ele arrisca a sua própria vida desnecessariamente. Dessa forma, consideramos que quando uma pessoa amada, especial, está em perigo, nós, além de ficarmos ansiosos, ficamos também com raiva. Como respostas ao risco de perda, ansiedade e raiva estão de mãos dadas; não é à toa que têm a mesma raiz etimológica.

Nas situações descritas, a raiva é freqüentemente funcional. Quando a criança ou um dos esposos se comporta perigosamente, um protesto raivoso é provável que o detenha ou desencoraje. Quando um dos parceiros está perdido, uma lembrança aguda do quanto o outro se preocupa pode fazer maravilhas. Quando uma criança se encontra relativamente negligenciada em favor do novo bebê, a reclamação de seus direitos pode trazer de volta o equilíbrio. Então, no lugar certo, na hora correta e no grau adequado, a raiva não só é apropriada como, também, indispensável. Ela serve para deter um comportamento perigoso, livrar alguém de um rival ou coagir um parceiro. Em qualquer das situações, o objetivo do comportamento de raiva é o mesmo — proteger a relação que é de grande valor para a pessoa que vivencia a raiva. Assim sendo, é necessário ser claro no porquê de certas relações específicas, freqüentemente chamadas de relações libidinais, serem consideradas tão importantes na vida real de cada um de nós.

Freud, em suas tentativas de compreender isso, esteve atento à física e à biologia de seu tempo. As relações libidinais, segundo ele, eram consequência das necessidades do indivíduo de alimento e sexo. Subseqüentemente, para explicar algumas das manifestações mais confusas de raiva, ele se afastou da biologia para propor o instinto de morte. Essas hipóteses, estruturadas em termos de acúmulo de descarga de energia psíquica, levaram a

*N.T. Na língua inglesa, evidentemente, cujos termos são: *anxiety* e *anger*.

uma metapsicologia tão distante da observação clínica e da experiência, que um grande número de médicos orientados analiticamente, implícita ou explicitamente, a abandonaram. Uma reação a essa metapsicologia foi o desenvolvimento de uma escola de pensamento que decidiu não só separar a psicanálise da biologia como, também, dispensar o método científico e, ao invés dele, acatar a hermenêutica. Uma outra reação oposta foi a de explorar os princípios considerados úteis na biologia moderna, princípios totalmente diferentes dos vigentes na época de Freud, para ver se eles se harmonizavam com nossas observações clínicas e se poderiam ser usados para a elaboração de uma nova metapsicologia ou estrutura conceitual, como seria chamada agora. É esse o percurso que eu e alguns outros estamos seguindo.

As relações específicas, que podem despertar raiva, caso haja alguma ameaça, são de três tipos: relação sexual com um parceiro — namorado(a) ou esposo(a), relação com os pais e relação com os filhos. Cada relação é vivida com grande emoção. Toda a vida emocional de uma pessoa — tudo que ela sente — é determinada, num grau elevado, pelo estado dessas relações duradouras. Enquanto tudo estiver ocorrendo tranqüilamente, a pessoa se mantém contente; quando é ameaçada, torna-se ansiosa e talvez com raiva; quando a pessoa põe suas relações em perigo por causa de suas próprias ações, sente-se culpada; quando essas relações se rompem, a pessoa se torna triste e quando elas são resgatadas, a pessoa volta a ser feliz.

Para nos ajudar a compreender porque o estado dessas relações teria um efeito tão profundo nos sentimentos de uma pessoa, dois ramos da biologia moderna — a etiologia e a teoria da evolução — são extremamente esclarecedores. Os três tipos de relação em questão são semelhantes aos de uma enorme variedade de outras espécies e têm íntima relação com as funções biológicas vitais da reprodução e, especialmente, da sobrevivência dos jovens. É, portanto, mais do que provável que a tendência poderosa do ser humano para estabelecer relações profundas e duradouras seja o resultado de uma forte predisposição genética, uma predisposição que foi selecionada durante o curso da evolução. Dentro desse quadro de referência, a forte propensão de uma criança a se apegar à mãe e ao pai, ou a quem quer que esteja cuidando dela, pode ser compreendida como tendo a função de reduzir o risco de que algo de mau lhe aconteça. A melhor política, em termos de segurança, é estarmos próximos ou em fácil comunicação com alguém que possa nos proteger. De forma semelhante, a preocupação dos pais com o cuidado de seus filhos tem a função de contribuir para a sobrevivência da criança. De acordo com essa visão, os prêmios e as penalidades selecionadas durante a evolução, que nos guiam em nossas atividades, são: a satisfação e o contentamento trazidos pelo sucesso na manutenção de relações duradouras e a frustração, ansiedade, e, às vezes, desespero se as relações fracassam.

Usando essa perspectiva evolucionista, acredito que possamos compreender como o comportamento de raiva entre membros de uma família pode

ser frequentemente funcional. Porque, como disse anteriormente, no lugar certo, na hora apropriada e no grau correto, a raiva pode servir para preservar essas relações duradouras, de vital importância. Mas, como é óbvio, a raiva pode ser exagerada. Minha tese é, simplesmente, que muito da violência disfuncional encontrada na família pode ser compreendida como versão exagerada e distorcida do comportamento que é potencialmente funcional, especialmente, de um lado, o comportamento de apego, e de outro, o de cuidados.

Existe, atualmente, uma literatura considerável sobre a natureza dos laços da criança à sua mãe, referida tradicionalmente como dependência e, agora, concebida como apego e busca de cuidados. Em termos gerais, o resultado do comportamento de apego é que um indivíduo, normalmente aquele menos capacitado a se tornar bem-sucedido, mantém proximidade e/ou comunicação com um outro indivíduo, que é tido como mais capacitado. Esse comportamento é especialmente ativado pela dor, fadiga ou qualquer coisa assustadora e, também, pela inacessibilidade que a figura de apego estabelece ou parece estabelecer. Embora concebido como sendo, em parte, pré-programado, existem agora provas abundantes de que o modelo especial, resultante da organização do comportamento de apego durante o desenvolvimento, é muito influenciado pela forma como as crianças recebem as respostas de suas figuras de apego, que são, na grande maioria dos casos, sua mãe e seu pai. Resumindo, parece claro que um cuidado sensível e amoroso resulta no desenvolvimento da confiança que a criança tem de que os outros a ajudarão, caso ela necessite, e no tornar-se visivelmente autoconfiante e corajosa em suas explorações do mundo, cooperativa com os outros e, também — ponto muito importante — complacente e prestativa com os outros em situações aflitivas. Inversamente, quando se responde lenta e relutantemente ao comportamento de apego de uma criança e se a considera como estorvo, ela tende a se tornar ansiosamente apegada, isto é, apreensiva, com receio de que seu protetor lhe falte ou não esteja disponível quando dela necessitar, mostrando-se relutante em sair do seu lado, obedecendo de má vontade, ansiosa e indiferente aos problemas alheios. Se seu protetor efetivamente a rejeitar, ela tende a desenvolver um modelo de comportamento no qual a evitação desse protetor ocorre paralelamente ao seu desejo de proximidade e cuidado e no qual o comportamento raivoso está apto a se tornar proeminente. Falarei mais sobre isso posteriormente.

Desejo enfatizar mais um aspecto do comportamento de apego: é uma característica da natureza humana do começo ao fim da vida — do berço ao túmulo. Reconhecidamente, é normalmente menos intenso e menos requisitante nos adolescentes e adultos, do que nos primeiros anos de vida. Ainda assim, um desejo urgente de amor e cuidado é bastante natural quando a pessoa está ansiosa ou aflita. É, entretanto, bastante desastroso que, por conta de uma teoria enganadora, os adjetivos pejorativos "infantil" e "regressivo"

sejam tão vastamente correntes nos círculos clínicos. Essas são palavras que eu nunca uso.

Enquanto o estudo sistemático do comportamento de apego e, especialmente, das condições que influenciam o seu desenvolvimento vem progredindo nos últimos vinte anos, o estudo sistemático do cuidado ou comportamento de cuidados e seu desenvolvimento está ainda no início. A abordagem que eu considero mais promissora é, novamente, a etológica. Ela admite que nos humanos assim como em outras espécies, o comportamento de cuidados, como o comportamento de apego é, em algum grau, pré-programado e está pronto para se desenvolver dentro de certas linhas, quando as condições o ativam. Isso quer dizer que, no curso comum dos eventos, o pai/mãe do bebê vivencia um forte desejo de se comportar de algumas formas consideradas típicas, por exemplo, embalar o bebê, confortá-lo quando ele chora, mantê-lo aquecido, protegido e alimentado. Um tal ponto de vista, é claro, não significa que os modelos apropriados de comportamento se manifestem por completo em cada detalhe. Certamente, não é assim nos humanos nem em nenhuma outra espécie mamífera. Todo detalhe é aprendido um pouco durante a interação com bebês e crianças e muito através da observação de como os outros pais se comportam, começando durante a própria infância do futuro pai e pela forma como seus pais o trataram e a seus irmãos.

Descobertas das pesquisas

Levando em conta o que se sabe, agora, sobre os indivíduos envolvidos em violência familiar e as circunstâncias em que isso ocorreu, eu começo considerando as mulheres que agridem fisicamente seus filhos e, em seguida, com os efeitos de tais agressões nessas crianças. Meu motivo para fazê-lo é que nessas duas áreas as descobertas das pesquisas parecem mais adequadas. Então, à luz dessas descobertas, podemos continuar a considerar o que se sabe sobre homens que espancam as esposas ou as crianças, uma área de problemas também muito importante mas, no momento, pouco pesquisada.

As descobertas dos variados estudos sobre mulheres, que comprovadamente batiam em seus filhos, mostram concordâncias consideráveis (veja revisão em Spinetta e Rigler, 1972). Embora, provavelmente, mais comum entre famílias de baixo *status* sócio-econômico, o abuso infantil também ocorre em famílias da classe média, onde existe a probabilidade de ser disfarçado atrás de uma fachada de ultra-respeitabilidade.

Na superfície, as pessoas que cometem abusos variam de frias, rígidas, obsessivas e críticas, para passivas, infelizes e desorganizadas. Ainda assim, elas têm, emocionalmente, muito em comum. Entre alguns aspectos relatados como sendo freqüentes entre mães que cometem abusos, nós descobrimos o seguinte: são predispostas a períodos de intensa ansiedade, pontuados

por violentas explosões de raiva, são consideradas impulsivas e "imaturas". Embora as suas "necessidades de dependência" sejam descritas como excepcionalmente fortes, são extremamente desconfiadas e, conseqüentemente, incapazes e não desejosas de manter relacionamentos mais próximos. Socialmente, elas são isoladas. Não tendo ninguém mais para se dirigir, muitas delas procuram cuidado e conforto em um de seus próprios filhos, tratando-os como se fossem mais velhos do que na realidade são (Morris e Gould, 1963).

Considerando as experiências da infância, muitos pesquisadores repararam que a maioria dessas mulheres tinham tido infâncias tristes e, como dizem dois pesquisadores, "foram privadas de maternagem básica" (Steele e Pollock, 1968). Uma considerável minoria foi também espancada quando criança.* Para qualquer pessoa que pense em termos de teoria de apego, a noção de pronto sugerida é a de que essas mulheres sofrem de um alto grau de apego ansioso e, conseqüentemente, as experiências de prolongadas e repetidas separações e/ou ameaças de abandono seriam um traço comum de suas infâncias. Num estudo relativamente pequeno, essas hipóteses foram testadas por Pauline Delozier (1982), trabalhando em Los Angeles. Sua amostragem consistia em dezoito mulheres da classe trabalhadora que, comprovadamente, tinham espancado seus filhos, e outras dezoito, da mesma classe sócio-econômica, de idades semelhantes (a maioria na faixa dos trinta), com número de filhos também semelhante, que não o haviam feito. Para todas foi feita um entrevista semi-estruturada e um questionário para ser completado, além de terem sido testadas com o teste Hansburg de Ansiedade de Separação (Hansburg, 1972). Nessa última etapa, a do teste, uma série de quadros representando cenas ou de crianças abandonando seus pais ou de pais abandonando seus filhos foi mostrada, e as mulheres foram convidadas a descrever o que fariam e sentiriam em tais situações.

Os resultados do Teste de Ansiedade de Separação mostrou, como era de se esperar, que, em geral, as mães que cometiam abusos eram extremamente sensíveis a qualquer tipo de situação de separação, até a mais corriqueira e banal, com respostas que demonstravam um alto grau de ansiedade e/ou raiva. Além disso, as respostas mostraram que, enquanto essas mulheres ansiavam por cuidados, tudo que elas esperavam era rejeição. Uma

* Num estudo de Baldwin (1977) das trinta e oito crianças que tinham sofrido abusos físicos, até um grau excepcionalmente alto, dois quintos dos pais tinham sofrido abusos físicos quando crianças e mais da metade, abuso mental severo e prolongado. Baldwin chama atenção para a forte tendência de muitos desses pais, quando entrevistados, a fazerem generalizações sobre suas infâncias, apresentando um quadro idealizado em total contraste com os episódios repugnantes descritos ao se formularem perguntas detalhadas. Nesse campo, médicos e entrevistadores inexperientes tendem a ser gravemente enganados.

grande incidência de respostas, indicando ansiedade relativa ao bem-estar dos pais, dava suporte a uma outra hipótese inicial. Para esses traços, as incidências no grupo de controle, embora não negligenciáveis, foram significativamente baixas. Por exemplo, enquanto doze das dezoito mães que haviam cometido abusos foram consideradas como tendo apresentado o mais alto grau de apego ansioso, somente duas do grupo de controle foram assim consideradas.

No que diz respeito às experiências infantis dessas mulheres, os resultados, como foi relatado nas entrevistas e no questionário, confirmavam algumas das hipóteses iniciais, mas não todas. Por exemplo, tendo visto alguns relatórios anteriores, DeLozier esperou encontrar uma incidência significativamente alta de separação dos pais na infância, das mães que cometiam abuso, mas isso não ocorreu. Em contraste, sua expectativa de que uma grande proporção dessas mulheres teria vivenciado repetidas ameaças de abandono por parte dos pais mostrou-se correta, o que confirma o ponto de vista de que as repetidas ameaças de abandono por parte dos pais são tão ou mais patogênicas do que as separações reais (Bowlby, 1973). De uma forma semelhante, embora a violência por parte de um dos pais não tenha sido aparentemente um ponto em comum, muitas das mães que cometeram abusos tinham sofrido repetidas ameaças de espancamento, mutilação ou até de morte.

Outro traço marcante da infância das mulheres que cometeram abuso, também condizente com a expectativa, é que somente uma minoria delas (sete) tinha sentido que podia contar com a ajuda da mãe em situações de necessidade. Entre as que não sentiam dessa forma, algumas descreveram outra pessoa, um parente ou vizinho, que teria sido de grande ajuda; mas quatro das dezoito não tinham tido absolutamente ninguém com quem contar. No grupo de controle, em contraste, todas, exceto três, haviam sentido que podiam contar com a mãe e, cada uma das três tinha, pelo menos, uma outra pessoa com quem contar.

Então, ao contrário de uma garota que cresce num lar simples e razoavelmente feliz, que pode confiar na mãe em uma emergência, a maioria dessas mulheres nunca pôde fazê-lo. Na realidade, e novamente como foi previsto, para muitas delas a relação filha-mãe tinha sido invertida, sendo esperado delas o cuidado com os pais.*

Não é difícil compreender por que mulheres com experiências infantis desse porte haviam crescido dessa forma. Ameaças de abandono tornam uma criança intensamente ansiosa a respeito de qualquer separação, embora isso pareça rotina para algumas pessoas e, também, intensamente raivosa com os pais por ameaçá-la dessa forma. Além disso, o fracasso em dar

* O estudo de DeLozier foi repetido por Mitchell (no prelo) com amostragens de mães mexicanas-americanas, com resultados bastante semelhantes.

respostas de alguma ajuda, quando a criança está angustiada, combinado com repetidas e impacientes rejeições, levam a criança a se tornar profundamente desconfiada de qualquer pessoa. Então, enquanto constantemente ansiosa pelo amor e cuidado que nunca teve, ela não confia que um dia possa vir a tê-los e suspeitará de qualquer oferecimento que venha a receber. Não é de se estranhar, portanto, que uma mulher com essa história de vida, ao se tornar mãe, esteja, em alguns momentos, ao invés de pronta para cuidar de seu filho, esperando que a criança possa dela cuidar. Não é estranho também que, quando seu bebê fracassa nessa função e começa a chorar, requisitando cuidado e atenção, ela se torne impaciente e com raiva dele.

Acredito que os violentos ataques da mãe em relação à criança, podem ser compreendidos a partir desse conhecimento. Embora eu nunca tenha tratado uma mulher que tenha atacado seu filho fisicamente, tratei de uma que esteve, perigosamente, perto de o fazer.

Comecei a ver essa mulher, que chamarei de Sra. Q., porque o médico da clínica infantil que ela freqüentava estava preocupado com seu filho de dezoito meses: ele se recusava a comer e estava perdendo peso. Quando eu os vi, foi de imediato evidente que a Sra. Q. estava intensamente ansiosa e deprimida e que vinha se sentindo assim desde o nascimento do menino. Ao conversar com ela, descobri que estava aterrorizada com a idéia de que seu filho morresse e o importunava para que comesse. Ela também me disse que, às vezes, tinha impulsos de jogá-lo pela janela. Somente depois ela me contou que, numa ocasião, ficou histérica, quebrou pratos e bateu no berço do bebê. Mostrou-se intensamente ansiosa enquanto falava comigo e esperava que eu me tornasse raivoso com ela. Por minha sugestão, começou a vir me ver, para psicoterapia, uma vez por semana.

O quadro que ela descreveu sobre sua infância, de forma relutante e em fragmentos, mas sempre consistente, era — o que só agora eu sei — típico. Relembrou amargas discussões entre seus pais, durante as quais eles se agrediam e se ameaçavam de morte; e, também, como sua mãe, repetidamente, pressionava a família com ameaças de abandono. Em duas ocasiões, a Sra. Q. retornou da escola e viu sua mãe com a cabeça dentro do forno e, em outras ocasiões, sua mãe fingia ter desertado, sumindo de casa metade do dia. Naturalmente, a Sra. Q. cresceu aterrorizada de que, se fizesse alguma coisa errada, sua mãe fosse embora. Além disso, as coisas pioraram ainda mais com a insistência de sua mãe para que ela não deixasse escapar uma palavra sobre esses terríveis eventos, com qualquer pessoa fora de casa. A Sra. Q., que era técnica qualificada antes do casamento, era conhecida como uma vizinha muito prestativa e que fazia o possível para ser uma boa esposa e mãe — no que, em grande parte, foi bem-sucedida. Ainda assim, era sujeita a esses rompantes destrutivos e violentos, que a amedrontavam e confundiam e que a envergonhavam intensamente.

Depois de algum tempo, eu quase não tinha dúvidas de que os rompantes de raiva deveriam ser compreendidos como expressão de intenso ódio que, gerado inicialmente e durante muitos anos pelas repetidas ameaças de sua mãe de abandonar a família, tinha se dirigido, desde muito cedo em sua vida, para longe de sua mãe, em direção a alvos menos perigosos. Aterrorizada, então, de vir a expressar sua raiva diretamente, ela redirecionou o ódio* em direção a alguma coisa ou a alguém que não pudesse retaliar. A Sra. Q. lembrou que em criança se retirou algumas vezes para o seu quarto e atacou suas bonecas. Agora, era a sua louça, o berço do bebê e, por pouco, não era também o bebê. Cada um desses rompantes, eu suspeitava, era detonado por sua mãe que, dominadora e invasora como sempre, ainda a visitava diariamente.

A explicação se adapta aos fatos que temos e tem o mérito, nem sempre apreciado nos círculos clínicos, de ser simples. Não é surpreendente que outros pesquisadores de nossa área também a tenham proposto (e.g. Feinstein, Paul e Pettison, 1964). Em outros casos, um marido agrediu violentamente sua esposa que, violentamente, em retomo, redirecionou o ataque contra seus filhos.

Ao nos dirigirmos aos efeitos do espancamento no desenvolvimento da personalidade das crianças, precisamos ter em mente que as agressões físicas não são os únicos episódios de hostilidade que elas vivenciam com os pais. Em muitos casos, na realidade, as agressões físicas são apenas parte do problema — os sinais evidentes e manifestos de raivosa rejeição verbal ou mesmo física. Na maioria dos casos, os efeitos psicológicos podem ser considerados como consequência da rejeição e negligência hostil prolongada. Entretanto, as experiências de cada criança podem variar muito. Algumas, por exemplo, podem receber um cuidado relativamente bom e só muito ocasionalmente sofrer um rompante violento por parte dos pais. Por essas razões, não é surpreendente que o desenvolvimento sócio-emocional das crianças também varie. Aqui eu descrevo algumas descobertas que parecem ser bastante típicas.

Aqueles que observaram tais crianças em seus lares, ou em outro lugar, descrevem-nas sob diversas formas: deprimidas, passivas e inibidas, "dependentes" e ansiosas, assim como agressivas e raivosas (Martin e Rodeheffer, 1980). Gaensbauer e Sands (1979), endossando esse quadro, enfatizam como esse comportamento pode ser perturbador para o protetor. As crianças não participam das brincadeiras e mostram pouca ou nenhuma atenção. A expressão de sentimento é frequentemente tão restrita, que é facilmente não perceptível ou, ainda, ambígua e contraditória. O choro pode ser prolongado

* Acho o termo dos etólogos "*redirecionamento*" preferível ao seu equivalente clínico "*deslocamento*", porque é menos ambíguo. A "*redireção*" de um comportamento hostil por parte de um animal dominante é bastante conhecida em outras espécies.

e não suscetível de ser confortado; a raiva é facilmente provocada de forma intensa e dificilmente aplacada. Uma vez estabelecidos, esses modelos tendem a persistir.

Um ponto muito discutido na literatura é o grau em que a prematuridade, a doença ou o temperamento difícil de uma criança podem ter contribuído para os problemas da mãe e tão definitivamente para explicar os maus-tratos a que a criança vem sendo exposta. Em alguns casos, esses fatores têm um papel importante, mas só quando a mãe reage desfavoravelmente ao bebê e, desse modo, estabelece um círculo vicioso.* Certamente, tal sequência tem muita probabilidade de ocorrer quando a mãe teve, ela própria, uma infância difícil, cresceu emocionalmente perturbada e tem pouco ou nenhum apoio emocional ou mesmo ajuda, depois do nascimento do seu bebê.

Uma criança que sofre abusos, em fase de engatinhar, mostra, em relação a seus pais, um quadro chocante de fria observação e de prontidão para o que possa vir a acontecer. Mas, alguns também mostram uma sensibilidade incomum às necessidades de seus pais (Malone, 1966). De fato, existem boas razões para pensarmos que algumas crianças aprendem cedo que é possível aplacar uma mãe perturbada e potencialmente violenta, com atenção constante a seus desejos.**

Numa creche, as crianças e os bebês espancados têm a reputação de encontrarem dificuldade para estabelecer relacionamentos, tanto com a figura de seu protetor como com outras crianças e, também, de serem muito agressivas. Nos últimos anos, essas observações vêm sendo confirmadas por pesquisas sistemáticas, que focalizam tanto os modelos particulares de comportamento apresentados, como os detalhes das situações nas quais cada um deles ocorre. As descobertas seguintes se originaram de um estudo conduzido em Berkley por Main e George (George e Main, 1979; Main e George, 1985).

O objetivo deles era comparar o comportamento de dois grupos de crianças de três anos, numa creche-dia. Um grupo de dez crianças que, sabia-se, tinham sido espancadas pelos pais. O outro grupo de dez crianças de igualava em todas as variáveis relevantes, porém nunca tinham sido espancadas; no entanto, estavam numa creche que cuidava de crianças cujas

* Existe, agora, boa evidência de que, sendo feita uma maternagem sensível as crianças difíceis de desenvolvem favoravelmente, apenas com algumas exceções (Sameroff e Chandler, 1975) e, em contrapartida, um bebê potencialmente fácil tende a se desenvolver desfavoravelmente se lhe for dado um cuidado insensível (Sroufe, 1983).

** Sinto-me em débito com Pat Crittenden que, numa comunicação pessoal, observou esse comportamento, aparentemente apacador, em crianças novas, que haviam sofrido abusos (algumas com menos de dois anos). Um comportamento semelhante foi observado em crianças pequenas, cujas mães eram seriamente deprimidas (Pound, 1982).

famílias estavam sob *stress*. Para a obtenção de dados, cada criança foi observada por quatro períodos de trinta minutos cada, em quatro dias diferentes, distribuídos por três semanas. Os observadores foram instruídos para registrar todos os comportamentos sociais relevantes, incluindo até pequenos movimentos, como virar a cabeça ou dar um passo para trás.

Ao analisar os dados, o comportamento social das crianças foi dividido em quatro categorias: de abordagem, de evitar, abordar-evitar e de agressão. Também foi dividido de acordo com a pessoa a quem esse comportamento se dirigia — à outra criança ou à atendente. Uma outra distinção foi feita entre o comportamento iniciado pela criança observada e o comportamento que ocorria em resposta a uma abordagem amigável de outra criança ou adulto. Os resultados são expressos em termos de um pequeno número de incidentes de um tipo especial de comportamento das crianças em cada grupo, ou ainda, do número de crianças, em cada grupo, que apresentou esse tipo de comportamento.

Em relação às ocasiões em que a criança iniciou um contato social com outra criança ou com a atendente, nenhuma diferença considerável foi observada entre as crianças dos dois grupos. Em contraste, diferenças marcantes foram observadas na forma de as crianças responderem a uma abordagem amigável feita por uma outra criança. As respostas características, das crianças que sofreram abuso, foram ações que, de pronto, evitassem a abordagem ou, até mesmo, os dois comportamentos (evitar e abordar), tanto em rápida sequência como em combinação dos dois. Aqui estão alguns exemplos: “ela engatinha em direção a ele, mas, de repente, ela se volta”. “Ela se arrasta em direção à atendente, mas com a cabeça voltada”. Então, quando a iniciativa partia da atendente, as crianças que sofreram abusos tinham três vezes mais tendência a tomar uma atitude de evitar do que as do grupo de controle; sete delas, comparadas com uma, mostraram uma curiosa alternância entre abordar e evitar. Quando a iniciativa partia das outras crianças, as diferenças eram ainda mais marcantes. Por exemplo, enquanto nenhuma das crianças do grupo de controle apresentou abordagem-evitação, todas as dez do grupo de crianças que tinham sofrido abusos o fizeram.

O comportamento agressivo era bastante comum em ambos os grupos de crianças, embora, como previsto, significativamente maior no grupo que havia sofrido abusos. As crianças espancadas não só agrediam as outras crianças duas vezes mais frequentemente do que as do grupo de controle, como cinco delas agrediram ou ameaçaram agredir um adulto, comportamento que não foi observado em nenhuma criança do grupo de controle. Além disso, as crianças que sofreram abusos manifestavam um tipo particular e desagradável de agressão, denominado “tormento” (Manning, Heron e Marshall, 1978). Isso consiste num comportamento malicioso, que parece ter a nítida intenção de fazer sua vítima demonstrar aflição. Quase sempre ele ocorre repentinamente, sem nenhuma causa evidente, contrastando com a

hostilidade que ocorre como reação a uma provocação. Tais ataques aparecem inesperada e imprevisivelmente, são amedrontadores e convidam à retaliação. Alguns estudos clínicos, cuja referência será feita posteriormente, nos relatam como sendo dirigidos especialmente a um adulto a quem a criança está se tornando apegada.

Tendo em vista o comportamento descrito até aqui, não nos surpreende descobrir que as crianças que sofreram abusos sejam singularmente pouco simpáticas aos companheiros de idade em situação de angústia. Os estudos de Zahn-Waxler e Radke-Yarrow mostraram que os bebês e as crianças em fase pré-escolar, que têm pais afetivos e cuidadosos, expressam comumente preocupação quando uma outra criança está aflita e fazem movimentos frequentes para confortá-la (Zahn-Waxler, Radke-Yarrow e King, 1979). Esse tipo de comportamento foi visto, também, pelo menos uma vez em cinco das crianças do grupo de controle do estudo de Main e George; mas, em nenhuma ocasião, as crianças que tinham sofrido abusos mostraram o mais leve sinal desse comportamento. Ao contrário e diferentemente das crianças do grupo de controle, elas reagiam com alguma combinação de medo, angústia ou raiva; três se comportaram com hostilidade em relação a uma criança que chorava. Por exemplo, um menino pequeno, de dois anos e oito meses, esbofeteou uma garotinha que estava chorando, exclamando repetidamente: "Pára com isso, pára com isso". Então, ele continuou dando leves tapinhas nas suas costas e começou a ranger os dentes para ela; antes que alguém pudesse intervir, as suas batidinhas nas costas haviam se transformado em pancadas.

Estou certo de que minhas razões para dar tanta atenção a essas observações de crianças pequenas são evidentes. Elas mostram com clareza indiscutível como cedo se estabelecem alguns modelos característicos de comportamento social — alguns auspiciosos para o futuro e outros agourentos. Eles não deixam dúvida sobre quais os tipos de experiência familiar que influenciam o desenvolvimento em uma ou outra direção. Novamente e sempre, vemos detalhes no comportamento de uma criança que engatinha ou no que ela diz, como sendo réplicas perfeitas de como ela própria é tratada. Na verdade, a tendência a tratar os outros da mesma forma como fomos tratados é profunda na natureza humana; em nenhum outro momento ela é mais evidente do que nos primeiros anos. Que todos os pais, por favor, reparem!!

Para se ter certeza absoluta de como essas crianças se desenvolvem, é preciso que se faça um estudo longitudinal apropriado. Existem provas de que, se as condições de cuidado melhoram, algumas se recuperam suficientemente e passam por normais (Lynch e Roberts, 1982); outras não. Algumas sofreram sérios prejuízos cerebrais e foram diagnosticadas como mentalmente deficientes (e.g. Martin e Rodeheffer, 1980). Para muitas outras, as condições adversas de cuidado continuam. Além disso, uma vez que a criança tenha desenvolvido os tipos desagadáveis de comportamento descritos, não é

fácil para um adulto, seja ele um dos pais, padastro ou profissional, dar o contínuo afeto de que ela necessita; tratar tais crianças com psicoterapia é extremamente oneroso. Os ataques repentinos e sem motivos, que em crianças mais velhas podem facilmente ser prejudiciais, são particularmente difíceis de serem contidos.

Algumas dessas crianças, emocionalmente perturbadas, nós sabemos, chegam a clínicas psiquiátricas, onde a origem de sua condição, suspeito eu, é freqüentemente desconhecida. Entre os que trataram esses pacientes, alguns deles psicóticos, e que descreveram a fonte de seus problemas, estão Stroh (1974), Bloch (1978) e Hopkins (1984). Cada um deles reparou o extremo grau de ambivalência a ser esperado: num momento a criança está abraçando o terapeuta, no momento seguinte o está chutando. Durante a adolescência e no início da vida adulta, alguns, na maioria os homens, são diagnosticados como psicopatas agressivos e/ou delinquentes violentos (e.g. Farrington, 1978). Outros, talvez especialmente as mulheres, parecem sofrer de múltipla personalidade (Bliss, 1980). Quando os psiquiatras estiverem atentos aos efeitos profundos e de vasto alcance dos abusos e da rejeição da infância, e perceberem o quanto as informações relevantes são suprimidas ou falsificadas pelos pais e negligenciadas pelos médicos, muito mais casos terão a possibilidade de serem identificados. Uma proporção significativa de crianças, que sofreu abuso e rejeição, cresce e perpetua o ciclo de violência familiar, continuando a responder às situações sociais com os mesmos modelos de comportamento desenvolvido durante a infância.

Um tipo de resposta tida como característica de muitos pais, que cometem abusos, e que os tinham sofrido na sua infância é relatado, por exemplo, por Frodi e Lamb (1980). Num estudo de laboratório, onde foram mostrados videotelopes de crianças chorando, descobriu-se que as mães que cometem abusos respondem com menos simpatia e mais aborrecimento e raiva a uma criança chorando do que o grupo de mães que não cometem abusos. Além disso, as mesmas respostas adversas foram observadas nas mães que cometem abusos, quando foram apresentados videotelopes de crianças sorrindo, o que sugere que elas não apreciam nenhum tipo de interação com a criança.

Vamos, agora, nos voltar para o comportamento do homem que maltrata a namorada ou a esposa. Dois colegas meus, assistentes sociais na Tavistock, Janet Mattinson e Ian Sinclair (1979) descrevem um homem, Sr. S., que inexplicável e imprevisivelmente estava pronto a atacar sua esposa. Quando ele solicitou a entrevista, sua esposa tinha acabado de abandoná-lo, assim que nasceu o seu primeiro filho. Embora inicialmente hesitante, o Sr. S. logo começou a relatar ao assistente social o quanto temia sua própria violência. Ele amava sua esposa e sentia que seu comportamento era injustificável e semelhante à loucura. A seguir, falando de sua infância, relatou que tinha sido um menino de uma grande família da classe trabalhadora, onde tinha recebido pouco mais do que um tratamento cruel e pouco simpático.

Disse que seus pais estavam constantemente envolvidos em violentas discussões. Ao ser investigado, em entrevistas posteriores, como ele se sentia em criança lutando pelo amor que nunca teve, se surpreendeu com a sugestão de que, provavelmente, era uma mistura de raiva e desespero. Isso fez sentido para ele, conforme disse: isso o aliviou do medo de que sua violência fosse inexplicável. Os motivos que fizeram sua esposa abandoná-lo, observou-se, ocorreram logo depois do nascimento do bebê. Como sabemos por outros estudos, e.g. Marsden e Owens (1975), o intenso ciúme da atenção que a esposa dá ao bebê é o detonador comum da violência do marido; assim, os rompantes do Sr. S. tinham todas as possibilidades de terem sido detonados pela chegada do bebê.

Ataques de violência aparentemente inexplicáveis e repentinos, semelhantes ao do Sr. S., são característicos de uma proporção significativa de homens, que espancam suas esposas; por exemplo, ocorreu em cinco dos dezenove casos investigados por Marsden e Owens (1975). A hipótese de que a maioria desses homens foram crianças maltratadas e espancadas é mantida por diversas descobertas. Num estudo (Gayford, 1975), a informação dada pelas esposas era de que cinquenta e um dos cem homens violentos haviam sido espancados quando crianças. Além disso, trinta e três dos cem homens já haviam sido julgados por atos violentos. Como já era sabido, os estudos mostram que os homens mais violentos vêm de lares onde sofreram um tratamento cruel e brutal (Farrington, 1978).

Finalmente, descobrimos que muitas esposas espancadas vinham de lares perturbados e rejeitadores, onde uma minoria significativa foi espancada quando criança (Gayford, 1975). Essas experiências levaram-nas a abandonar os lares na adolescência, a se unirem quase que ao primeiro homem que encontraram, frequentemente com uma história de vida semelhante, e a engravidarem rapidamente. Para uma menina despreparada e com apego ansioso, ter que cuidar de uma criança gera uma infinidade de problemas; além disso, a sua atenção para com o bebê provoca um intenso ciúme em seu parceiro. Esses são alguns dos processos pelos quais um ciclo de violência se perpetua entre gerações.

Vamos, agora, voltar ao estudo de Mattinson e Sinclair (1979), que descreve modelos de interação, que eles descobriram serem comuns em certas famílias.

As entrevistas com o Sr. S. eram parte de um estudo feito para investigar mais sobre o que ocorre no tipo de família intensamente perturbada, que cria problemas intermináveis para o serviço médico e social e que é, como se sabe, extraordinariamente difícil de ajudar. Nessas famílias, parecia que a violência ou as ameaças de violência ocorriam quase que diariamente. Algumas vezes, o casal se separava para vir a se unir novamente alguns dias ou semanas depois. Algumas vezes, após palavras duras da esposa, o marido saía sozinho para retomar algum tempo depois. Ou a esposa, fisicamente

agredida pelo marido, saía com os filhos, mas voltava alguns dias depois para, exatamente, a mesma situação. O que era surpreendente para os pesquisadores era o tempo que tais uniões (casamentos) duravam. Eles, entretanto, colocavam uma questão: "o que mantém esses parceiros unidos"?

Descobriram que, enquanto a violência do marido e as ameaças raivosas da esposa pareciam dominar o quadro, cada parceiro estava profunda e ansiosamente apegado ao outro e tinha desenvolvido uma estratégia para controlar o outro e mantê-lo longe da possibilidade de abandoná-lo. Várias técnicas eram usadas, principalmente coercitivas, e outras que uma pessoa de fora acharia não só extremas como também contraproducentes. Por exemplo, as ameaças de abandono ou de cometer suicídio eram comuns e gestos suicidas não eram raros. Essas atitudes funcionavam positivamente, a curto prazo, assegurando a atenção do parceiro, embora provocassem sempre culpa e raiva. A maioria das tentativas de suicídio eram reações a alguns eventos específicos, particularmente abandonos verdadeiros ou ameaças de abandono.

Uma técnica coercitiva usada especialmente por homens era "aprisionar" a esposa trancando-a dentro de casa, colocando cadeado em suas roupas ou, então, retendo todo seu dinheiro e fazendo as compras para evitar que ela visse qualquer outra pessoa. O apego intensamente ambivalente de um homem que adotou essa técnica era tal que ele não só a trancou por dentro como também por fora. Ele a colocou para fora de casa, dizendo que não queria que retornasse, mas, assim que ela chegou à rua, ele correu atrás dela e a empurrou para dentro de seu apartamento.

Uma terceira técnica coercitiva era o espancamento. Como um homem disse, em sua família, pedir alguma coisa era sempre feito "de punhos cerrados". Nenhuma esposa gostava desse tratamento, mas algumas tinham certa satisfação com isso, por exemplo, uma mulher ao explicar que seu marido a havia ameaçado de ir "buscá-la" caso ela saísse de casa. Ela insistia que ele precisava dela também. Descobriu-se que na maioria desses casamentos cada parte estava pronta a insistir sobre o quanto se necessitavam mutuamente, enquanto aparentava não necessitar do parceiro. Por "necessitar", é claro, eles queriam dizer o que eu chamo de desejo por uma figura de apego. O que eles mais temiam era a solidão.

Medidas preventivas

Isso encerra minha descrição dos problemas encontrados em famílias violentas e a perspectiva teórica que eu acredito ser útil para abordá-los. Que atitudes, então, são necessárias?

Muito trabalho devotado e habilidoso foi feito ao se dar ajuda a famílias, onde o abuso já tinha ocorrido, e muitas idéias foram levantadas a respeito

de como lidar com a situação (Helfer e Kempe, 1976; Lynch e Roberts, 1982). Já que todos os estudos mostram as enormes dificuldades e o imenso tempo consumido com esse trabalho, perguntamos sobre as perspectivas de prevenção. Esta é a esperança. A seguir, decrevo um tipo de serviço, pioneiro no Reino Unido, e que vem sendo corajosamente ampliado pelo governo. Sem dúvida, serviços semelhantes devem estar ocorrendo em várias partes dos Estados Unidos, mas, naturalmente, pouco sei a esse respeito.

O modelo de serviço, que é tão promissor, pelo menos para algumas famílias, é conhecido como "Home-Start" (que teve início em Leicester) (Harrison, 1981)*. É um esquema de visita independente e organizada às casas, oferecendo suporte, amizade e assistência prática às famílias jovens que estão em dificuldades. É um esquema formado por voluntárias que trabalham em conexão com os serviços estaduais, recebendo também suporte e supervisão de um profissional. Todas as visitas são a convite da família e seguem os termos por ela estabelecidos. Não existem contratos nem limites de tempo.

Cada voluntária é uma mãe que se incumbem de fazer visitas regulares a uma ou, no máximo, duas famílias, com o objetivo de estabelecer uma relação onde tempo e compreensão podem ser divididos. Todos os esforços são feitos para encorajar pais e reassegurá-los de que as dificuldades em cuidar de crianças não são raras e, também, que a vida familiar pode ser agradável. Novas voluntárias na faixa de trinta/quarenta e cinco anos assistem a um curso preparatório, um dia na semana durante dez semanas, e recebem um treinamento contínuo, depois.

Existem muitas vantagens no fato de as visitantes serem voluntárias. Primeiro, uma voluntária tem tempo: na prática, descobriu-se, no esquema pioneiro, que a média de tempo de cada voluntária com sua família, em sua própria casa, era de seis horas por semana. Segundo, ela se encontra com a mãe em nível de igualdade e sente-se livre para contribuir com as atividades domésticas da forma que achar apropriada. Terceiro, ela pode comparar as observações e conversar sobre as experiências com seus próprios filhos. Quarto, e muito importante, ela pode se mostrar disponível para ser contactada durante a noite ou no fim de semana.

As famílias visitadas são, é claro, aquelas onde as dificuldades estão presentes ou parecem ser iminentes. Desde que esse serviço não tem como objetivo específico o atendimento às famílias que cometem abusos, uma família que esteja participando não necessita se sentir rotulada de forma nenhuma. Contudo, o serviço lida com um bom número de famílias que têm

* Uma outra iniciativa, servindo a uma área severamente deficitária nos subúrbios de Londres, é conhecida como "Newpin" e é também bastante promissora (Pound e Mills, 1985).

um ou mais filhos registrados como crianças com riscos de sofrerem abusos. Nos primeiros oito anos desse esquema pioneiro, nada menos do que um quarto das famílias visitadas era dessa categoria.

As visitas frequentes começam quando a mãe ainda está grávida. A maioria das visitadas são jovens, impulsivas e terrivelmente isoladas, sem nunca terem vivenciado afeto, cuidado ou segurança. Em tais casos, o papel principal da voluntária é fazer uma maternagem com a mãe, por exemplo, encorajá-la a “maternar”* seus próprios filhos. Ela também conversará e brincará com as crianças, dando novamente à mãe exemplos que ela nunca teve. Talvez mais tarde, quando a confiança tenha crescido, a voluntária possa dar assistência ajudando a mãe a adquirir as qualificações domésticas básicas, que ela nunca aprendeu. A chave para a relação é que a voluntária é, ela mesma, uma mãe que conhece todos os problemas por dentro.

Existem muitos casos que são reconhecidos como impróprios para serem incluídos num serviço desse tipo.** Para as que podem ser incluídas num serviço desse tipo, o grau de sucesso é muito encorajador, como mostra a avaliação dos quatro primeiros anos de trabalho desse serviço pioneiro, levado avante por um pesquisador independente, cuja monografia (Van der Eyken, 1982) nos dá uma noção total do projeto. Pegando, ao acaso, uma entre cinco das duzentas e oitenta e oito famílias visitadas, ele perguntou aos interessados como avaliavam os resultados no final das visitas voluntárias, usando uma escala de três pontos: nenhuma mudança, alguma mudança e mudança considerável. Os resultados mostraram que as voluntárias eram as mais pessimistas, achando que apenas metade das famílias tinha sofrido mudanças consideráveis e uma em dez havia fracassado. Os assistentes sociais tinham mais esperança, avaliando que mais da metade tinha mostrado uma considerável mudança e o restante, alguma mudança. As mais entusiasmadas do trabalho eram as enfermeiras da saúde pública e as próprias famílias. Das cinquenta e oito famílias, que se auto-avaliaram, quarenta e sete (85%) afirmaram que uma mudança considerável havia ocorrido, seis relataram alguma mudança e somente duas acreditaram não ter havido nenhuma.

Em um campo, que é profundamente problemático, assim como notadamente difícil, essas descobertas são sinônimo de esperança.

* N.T. “Maternar” com o sentido de fazer a maternagem, cuidar com dedicação, disponibilidade e ternura.

** Harrison (1981) faz uma lista dos seguintes: quando um dos pais é um doente mental crônico, quando sofre de doença degenerativa, quando é um criminoso reincidente ou tem intenções de que os filhos sejam cuidados por outros. Também são excluídas as famílias cujas crianças correm o risco de sofrerem abusos por parte do companheiro da mãe.

Conferência 6 ✓

Saber o que você não deve saber e sentir o que você não deve sentir

No início de 1979, fui convidado a contribuir para um número especial do *Canadian Journal of Psychiatry* em honra ao emérito Professor Eric Wittkower, que havia sido o catedrático de psiquiatria da Universidade McGill, em Montreal, de 1962 a 1964, que estava, celebrando, então, seu aniversário de oitenta anos. Fiquei muito feliz em fazê-lo. O trabalho que se seguiu, com o título acima mencionado, formou também a base de outras conferências que dei, em diversas ocasiões, nos anos subsequentes. Numa ocasião, em Roma, eu me encontrei com dois terapeutas cognitivos, Giovanni Liotti e Vittorio Guidano, e fiquei muito surpreso e contente em descobrir o quanto tínhamos em comum. Uma das consequências de nossos encontros foi um convite para participar de um volume sobre *Cognição e Psicoterapia*, que estava sendo editado por Michael Mahoney e Arthur Freeman. Isso me deu a oportunidade de ampliar o original, que era um trabalho pequeno e me levou a essa versão que agora apresento.

A prova de que as experiências adversas com os pais durante a infância, como as que já foram descritas na conferência anterior, têm um papel importante na perturbação cognitiva é, agora, substancial. Por exemplo, pelo menos alguns casos nos quais as percepções e os papéis estão distorcidos, alguns casos de amnésia, maiores ou menores, incluindo casos de múltipla personalidade, podem ser apresentados, com suficiente confiabilidade, como sendo resultante de tais experiências. A pesquisa sistemática sobre essas seqüências causais ainda são raras e este é, claramente, um campo que pede,

com urgência, maiores esforços no sentido da realização de pesquisas. Por que, então, tem sido tão pesadamente negligenciado?

Uma influência adversa, já referida na conferência anterior, é a intensa tradição na escola de pensamento psicanalítico, de dar atenção à fantasia e negligenciar as experiências da vida real, que uma pessoa pode ter tido durante a sua infância. Uma outra, é a indubitável dificuldade de realização de pesquisa sistemática nesse campo. Por exemplo, aqueles que só se ocupam de pacientes adultos estão, normalmente, malsituados para investigar eventos que ocorreram muitos anos antes. Aqueles cujas infâncias ocorreram junto a famílias razoavelmente estáveis e que, como quase todos os psiquiatras e psicoterapeutas, ignoram a literatura referente à família e ao desenvolvimento da criança, não têm normas que vão ao encontro das histórias de seus pacientes. Acima de tudo, os clínicos se deparam com o silêncio dos pacientes sobre si próprios e suas famílias e, dessa forma, nem o treinamento nem a experiência os qualificam a aprofundar. Portanto, não é de espantar que muitos casos de perturbação psiquiátrica, branda ou grave, que encontram suas origens em eventos adversos da infância, tenham sido pouco considerados ou, até, completamente ignorados - não só por psiquiatras, como também, por psicoterapeutas. Mesmo o fato de algumas crianças serem física ou sexualmente atacadas por seus próprios pais, repetidamente e por longos períodos, está ausente das discussões de fatores causais na psiquiatria.

Hoje, o quadro está mudando. Primeiro, o conhecimento da interação pais-crianças, de uma forma geral, incluindo uma variedade de relações e eventos patogênicos, vem aumentando, tanto em quantidade como em qualidade, à medida que pesquisas sistemáticas são realizadas. Segundo, as consequências psicológicas nas crianças expostas a essas relações e eventos estão sendo melhor compreendidas e documentadas. Como resultado, existem, agora, várias ocasiões em que o médico tem uma razoável certeza ao traçar suas conclusões etiológicas. Especialmente, quando: (a) seu paciente apresenta problemas e sintomas que se assemelham às consequências conhecidas de certo tipo de experiência e (b) quando, no relato de sua história ou, talvez, mais tarde, durante a terapia, o paciente lhe conta experiências desse tipo. Ao chegar a uma conclusão, o raciocínio do psiquiatra não difere do de um médico que, tendo diagnosticado um paciente como sofrendo de estenose mitral, continua, sem hesitar, a atribuir essa condição a um ataque de febre reumática sofrida pelo paciente há muitos anos atrás.

Ao considerar os antecedentes da infância nas perturbações cognitivas, um bom ponto de partida é a amnésia.

Freud, em um de seus trabalhos clássicos sobre técnica analítica (1914) fez uma importante generalização cuja verdade, provavelmente, todos os psicoterapeutas endossam:

Esquecer as impressões, cenas ou experiências, quase sempre significa exterminá-las. Quando o paciente fala sobre coisas "esquecidas", freqüentemente deixa de concluir: "na verdade, eu sempre soube disso, só que nunca pensei sobre isso"(1914, 148).

Tais observações pedem, pelo menos, três tipos de explicação. Primeiro: existem traços especiais que caracterizam as impressões, cenas e experiências que tendem a ficar excluídas? Segundo: como podemos, da melhor forma, conceber os processos pelos quais as memórias se tornam excluídas ou, aparentemente, esquecidas? Terceiro: quais são as condições causais, internas ou externas da personalidade, que ativam o processo de exclusão?

As cenas e experiências que tendem a se tornar excluídas, embora, com freqüência, continuem a ser extremamente influentes em afetar o pensamento, o sentimento e o comportamento, situam-se em, pelo menos, três categorias distintas: (a) aquelas que os pais não desejam que seus filhos saibam; (b) aquelas em que os pais trataram seus filhos de forma a que esses achassem insuportável até mesmo pensar sobre elas; (c) aquelas que as crianças fizeram ou talvez pensaram coisas sobre as quais se sentem insuportavelmente culpadas ou envergonhadas.

Já que muita atenção foi dada, por muito tempo, à terceira categoria, discutirei, aqui, somente as duas primeiras. Começemos pela primeira.

Não é raro as crianças observarem cenas que os pais prefeririam que elas não tivessem observado; elas formam impressões que os pais prefeririam que elas não formassem; e existem experiências que os pais prefeririam acreditar que elas não tivessem. Existem provas de que muitas dessas crianças, cientes do que os pais sentem, prosseguem em conformidade com os desejos deles, de forma a excluir o futuro processamento de tais informações; assim, elas, conscientemente, deixam de dar atenção ao fato de, um dia, terem vivenciado tais cenas, formado tais impressões ou tido tais experiências. Acredito que aqui esteja uma fonte de distúrbios cognitivos tão comuns quanto negligenciados.

Assim, a evidência de que os pais, às vezes, pressionam seus filhos a interromperem um processamento consciente de informações relativas a eventos que os pais desejariam que eles nunca tivessem observado, vem de várias fontes. Talvez, a mais flagrante seja relativa aos esforços feitos por um dos pais no sentido de impedir que seu filho tome conhecimento do suicídio do outro (pai ou mãe).

Cain e Fast (1972) relataram descobertas feitas a partir do estudo de um conjunto de quatorze crianças, com idade variando entre quatro e quatorze, que tinham perdido um dos pais por suicídio e haviam-se tornado psiquiatricamente perturbadas, algumas de forma severa. Revendo tais dados, os autores se surpreenderam com o enorme papel desempenhado pela exposição

a situações patogênicas de dois tipos, especialmente situações nas quais uma intensa culpa tende a se engendrar (isso não é discutido aqui) e situações nas quais a comunicação entre pais e filhos é gravemente distorcida, na sintomatologia das crianças.

Aproximadamente, um quarto das crianças estudadas haviam testemunhado alguma aspecto da morte de um dos pais e, em seguida, ficaram sujeitas a pressões feitas pelo outro, o que sobreviveu, no sentido de acreditarem que estavam equivocadas quanto ao que tinham ouvido ou visto, que a morte não era devido ao suicídio e, sim, a alguma doença ou acidente. "A um menino, que viu seu pai suicidar-se com um tiro, foi dito, à noite, por sua mãe, que ele havia morrido de um ataque cardíaco; para uma menina, que descobriu o corpo de seu pai pendurado no armário, foi dito que sua morte havia sido causada por um acidente de carro; para dois meninos, que encontraram a mãe com os pulsos cortados, foi dito que ela se havia afogado enquanto nadava"(Cain e Fast, 1972, 102). Quando uma criança descrevia o que havia visto, o pai ou a mãe sobrevivente procurava não lhe dar crédito, ridicularizando ou insistindo em que a criança estava confusa por causa do que havia visto na TV ou por causa de algum pesadelo que tivesse tido. Tal confusão era, às vezes, formada, também, pelas inúmeras e diferentes histórias que a criança ouvia sobre a morte, contadas por diferentes pessoas ou pelo pai/mãe sobrevivente.

Muitos dos problemas psicológicos das crianças parecem ser diretamente determinados pelo fato de terem sido expostas a situações desse tipo. Tais problemas incluem desconfiança crônica de outras pessoas, inibição da curiosidade, desconfiança quanto aos seus próprios sentidos e uma tendência a achar tudo irreal.

Rosen (1955) descreve um paciente adulto, homem, de vinte e sete anos, que desenvolveu sintomas agudos depois que sua noiva rompeu com ele, por achá-lo melancólico e imprevisível. O paciente começou a sentir que o mundo à sua volta e seu próprio ser estavam-se fragmentando e que tudo era irreal. Ficou deprimido e tornou-se um suicida em potencial, vivenciando uma variedade de sensações corporais peculiares, que incluíam o sentimento de que estava sufocando. Segundo ele seus pensamentos eram como "algodão em rama". Durante o segundo ano de terapia, o analista, sob o impacto de uma série de associações que o paciente havia trazido e tendo em mente sua história de vida, arriscou uma reconstrução, ou seja, a de que sua mãe, talvez, tivesse tentado o suicídio durante a sua infância e que - o paciente - tivesse testemunhado. Mal a sugestão foi pronunciada, o paciente "explodiu" em soluços. A sessão provou ter sido um momento decisivo. Em seguida, o paciente descreveu como havia se sentido quando o analista fez esta sugestão; que não era tanto pelo que ele estava restituindo à memória, mas por ele ter dado a ele a permissão de falar sobre alguma coisa que sempre soube, de alguma forma.

A autenticidade da memória foi comprovada pelo pai do paciente que admitiu, quando pressionado, que a mãe do paciente tinha cometido várias tentativas de suicídio, durante sua infância. A tentativa, que o paciente testemunhou, ocorreu durante seu terceiro ano de vida. Sua babá ouviu ruídos no banheiro e chegou a tempo de impedir que sua mãe se enforcasse. O que não estava claro era o quanto a criança havia visto. Porém, mais tarde, sempre que ele mencionava o fato, tanto o pai quanto a babá duvidavam de sua memória, visto que não confirmavam suas impressões, alegando que ele estava imaginando aquilo ou que, simplesmente, tinha tido um pesadelo. Seu pai, agora, diz ter sentido que seria prejudicial para o menino lembrar-se de tal incidente; admitiu, também, que sua atitude foi ditada, em parte, pelo desejo de que o incidente permanecesse em segredo para amigos e vizinhos. Aproximadamente um ano depois a babá foi despedida, pois a mãe concluiu que sua presença era uma dolorosa lembrança do incidente.

Durante um sessão anterior a essa reconstrução vital, o paciente havia-se lembrado da demissão de sua querida babá como sendo um evento que, de alguma forma, era sentido como culpa sua. Em meio às várias associações relativas a tal fato, incluíam-se referências de ter sido, quando criança, testemunha de algo que modificou toda a sua vida, embora não soubesse o quê. Ele também tinha a impressão de que sua babá fora testemunha a seu favor. Então, embora a memória tenha sido bloqueada do processo consciente, continuou a influenciar tanto o que pensava quanto o que sentia.

Em outro momento (Bowlby, 1973), chamei a atenção para a importante incidência de tentativas de suicídio praticadas por um dos pais e, talvez com incidência ainda maior, das ameaças de suicídio; pontuei, também, a pouca atenção que vem sendo dada, tanto às tentativas quanto às ameaças de suicídio, na literatura psiquiátrica e psicoterapêutica. Talvez existam muitos casos semelhantes ao de Rosen, de que não tenhamos, ainda, nos dado conta.

Entre outras várias situações, que os pais desejariam que seus filhos não tomassem conhecimento e que vão pressioná-lo a supor que nunca souberam, estão aquelas referentes às suas atividades sexuais. Um exemplo disso me foi trazido por um terapeuta que estava tentando ajudar uma menina extremamente perturbada e que dificilmente falava. Entretanto, sua capacidade para falar era evidente em certas ocasiões dramáticas. Ela costumava sentar um ursinho numa cadeira, em um canto, e, então, avançava para ele apontando o dedo indicador e o repreendia com um tom de voz extremamente severo: "Você é levado - um ursinho levado - você não viu, você não viu, eu estou dizendo!". Ela repetia isso com crescente veemência. Não é difícil adivinhar quais as cenas que o ursinho estava sendo instruído "para não ver": a mãe era uma jovem prostituta.

Certamente, a razão da pressão exercida pelos pais sobre os filhos é a de assegurar que eles desenvolvam e mantenham um quadro completamente

favorável deles. Nos exemplos dados até agora, a forma de pressão exercida é grosseira. Talvez, mais frequentes e de igual prejuízo sejam as formas em que a pressão é mais sutil.

Durante as duas últimas décadas, foi dada atenção renovada ao incesto, tanto pelo reconhecimento da sua alta incidência, quanto pelos seus efeitos patogênicos nas crianças. As formas mais comuns estão entre pai e filha ou padrasto e enteada. Entre vários problemas e sintomas em crianças e adolescentes, que acreditamos serem devido a essas experiências, os mais comuns incluem um afastamento de todas as relações íntimas, perturbações de sono e intenções suicidas (Mieselman, 1978; Adams-Tucker, 1982). Uma avaliação das condições que tendem a causar perturbação cognitiva nos é dada por um colega, Brendan MacCarthy, que nunca foi publicado. Ele suspeita que a tendência mais provável é a de ocorrerem perturbações em pré-púberes. Eu me aproximo de suas conclusões no que segue.

Quando uma ligação sexual se desenvolve entre o pai e sua filha adolescente, relata MacCarthy, a ligação é, normalmente, reconhecida pelo pai durante o dia através de olhares secretos, toques secretos e indiretas. No caso de uma filha ainda mais jovem, entretanto, o pai tende a não dar demonstrações de tal reconhecimento. Ao invés disso, ele se comporta, durante o dia, como se os episódios noturnos nunca tivessem ocorrido e esse total insucesso em reconhecê-los, é, normalmente, mantido até muito tempo depois de a filha ter alcançado a adolescência.

MacCarthy descreve o caso de uma mulher casada, Sra. A., de quem ele tratou a depressão e a dependência a tranquilizantes e álcool. Ela mencionou os dez anos de "intromissão" sexual que havia sofrido por parte de seu pai adotivo, somente depois de quatro meses de terapia. Isso começou quando ela estava na faixa dos cinco ou seis anos, logo após a morte de sua mãe adotiva e prosseguiu até os dezesseis anos quando, então, fugiu. Entre seus muitos problemas estavam a frigidez, o fato de sentir o intercursos sexual como nauseante e um sentido de negritude interna (escuridão), "de uma mancha negra". Seus problemas se tornaram exacerbados, quando sua própria filha estava com quatro anos. Sempre que a menina ficava mais afetiva com o pai e se sentava perto dele, a Sra. A. sentia-se agitada, protetora e ciumenta; nessas ocasiões, ela não conseguia deixá-los a sós. Durante a terapia, mantinha-se subserviente, aterrorizada e vigiava intensamente os movimentos do analista.

No tocante ao relacionamento incestuoso, a Sra. A. descreveu como seu pai adotivo nunca, em nenhum momento do dia, aludia às visitas noturnas ao seu quarto, que sempre permanecia na escuridão. Ao contrário, ele falava, incessantemente, sobre o perigo de se permitir que os garotos fossem "muito longe" e sobre a importância da castidade antes do casamento. Quando, aos dezesseis anos, saiu de casa, ele não só insistiu que ela não dissesse a ninguém como, também, sarcasticamente, afirmou: "se você o fizer, ninguém

vai acreditar em você". Isso realmente poderia acontecer, pois seu pai adotivo era diretor de uma escola e prefeito do local.

Comentando sobre este e outros casos semelhantes, MacCarthy enfatiza a divisão cognitiva entre o pai respeitado e, talvez, amado durante o dia e o pai tão diferente dos estranhos eventos da noite anterior. Avisada para não deixar escapar nenhuma palavra a ninguém, incluindo sua mãe, a criança olha para o pai a fim de obter alguma confirmação daqueles eventos e fica, naturalmente, confusa quando não há resposta. Será que realmente aconteceu ou eu sonhei? Será que tenho dois pais? Não é de espantar que, anos depois, nenhum homem seja confiável e que a posição profissional de um terapeuta-homem seja vista como mera fachada que esconde um intuito predatório. Não é, também, de espantar que a proibição de comentar com alguém permaneça operativa e que a expectativa de, em qualquer situação, ninguém vai acreditar nela, garanta o silêncio. Com que frequência, podemos imaginar, os terapeutas mal-informados desencorajam o paciente a contar a verdade e confirmam a expectativa de que ninguém acreditará em sua história?

Nos exemplos até aqui descritos, a informação de que o pai ou mãe pressionam a criança a esconder é referente a eventos no mundo externo. Em outras situações, a informação a ser escondida se refere a eventos do mundo privado dos sentimentos da criança. Em nenhum outro lugar isso ocorre mais comumente do que em situações de separação e/ou perda.

Quando um dos pais morre, o que sobrevive ou outro parente podem não só dar às crianças informações inadequadas ou enganadoras como, também, entender que não seria apropriado afligir a criança. Isso pode ser explicitado: Miller (1979) descreve que quando a mãe de um menino de seis anos morreu, sua tia lhe disse: "Não chore, agora vá para o seu quarto e brinque direitinho". Em outros momentos, a indicação está somente implícita. Não raro, as viúvas ou viúvos temendo expressar suas próprias angústias, encorajam seus filhos a guardar tudo que sentem sobre suas perdas. Palgi (1973) descreve como um menino pequeno, cuja mãe o repreendeu por não chorar na morte do pai, reagiu: "Como posso chorar se nunca vi suas lágrimas?".

De fato, existem muitas situações em que é dito à criança que não chore. Por exemplo, a uma criança de cinco anos, cuja avó estava partindo, foi dito que não chorasse para que a despedida não ficasse mais difícil para a avó. Uma criança que é deixada pelos pais num hospital ou numa creche fica ciente de que não deve chorar, se não os pais não a visitarão. A criança cujos pais estão frequentemente longe e que a deixam com um grande número de meninas que "tomam conta"* dela, não se sente encorajada a

* N.T. No original - *au pair girls* - que vem a descrever um trabalho semelhante ao de uma *baby sitter*, alguém que toma conta por algumas horas.

reconhecer o quão sozinha e, talvez, irritada se sinta pela constante ausência deles. Quando pais se separam é, freqüentemente, dito à criança que não deve sentir saudade daquele com quem não mora, não deve ansiar pelo seu retorno. A dor e o choro não só são condenados como, também, considerados inadequados em tais situações; além disso, é dito que os jovens e os adultos farão troça acerca da angústia da criança e a tratarão como “bebê-chorão”. Existe alguma dúvida de que, em tais circunstâncias, o sentimento deve ficar guardado?

Todas essas situações são bastante evidentes, mas têm sido, creio eu, seriamente negligenciadas, assim como as causas da informação e do sentimento têm-se tornado excluídas da consciência. Existem, entretanto, outras situações, mais sutis e escondidas, porém, não menos comuns, que têm o mesmo efeito. Uma delas é quando uma mãe, que teve uma infância privada de amor, procura em seu filho o amor que ela própria não teve. Ao fazê-lo, ela está invertendo a relação normal mãe-filho, requerendo que a criança atue como um dos pais, enquanto ela própria age como uma criança. Para alguém que não está ciente do que está acontecendo, pode parecer que a criança está sendo “supergratificada”, mas num exame mais profundo, veremos que a mãe está colocando uma carga muito pesada nos ombros dela. O que é especialmente relevante aqui é que, freqüentemente, é esperado que a criança seja grata a tal cuidado e não perceba as demandas feitas a ela. Um dos resultados disso é que, em conformidade com os desejos de sua mãe, ela constrói um quadro unilateral dessa mãe como sendo generosa e completamente amável, excluindo do processamento consciente muitas das informações que também chegam até ela, de que essa mãe também é freqüentemente egoísta, requisita demais e é ingrata. Um outro resultado é que, também em conformidade com os desejos de sua mãe, a criança admite à consciência apenas os sentimentos de amor e gratidão em relação à sua mãe, abandonando qualquer sentimento de raiva que possa sentir em relação a ela, pelo fato de sua mãe esperar ser cuidada por ela e de impedi-la de ter seus próprios amigos e de viver sua própria vida.

Uma situação semelhante é aquela em que um dos pais, tendo tido uma infância traumática, fica apreensivo ao se lembrar de suas tristezas passadas e de, então, ficar deprimido. Como resultado, seus filhos são sempre requisitados a parecerem felizes e a evitarem qualquer expressão de dor, solidão ou raiva. Como um paciente me disse, depois de algum tempo de terapia: “Eu agora vejo que era terrivelmente sozinho quando criança, mas nunca me permitiram saber disso”.

A maioria das crianças é indulgente em relação aos pais, preferindo vê-los sob um ângulo favorável e se mantendo ansiosas em negligenciar muitas de suas deficiências. Mas, ainda assim, elas não se sujeitam a ver os pais somente da forma que eles querem ou a sentir somente da forma requisitada por eles. Para assegurar isso, uma pressão tem que ser exercida. A pressão

pode ter várias formas, mas o efeito de todas elas depende do insistente desejo da criança de ser amada e cuidada. Alice Miller (1979), que deu muita atenção a esses problemas, relata as palavras de uma paciente adulta, filha mais velha de uma mulher profissional e insegura:

Eu era jóia na coroa de minha mãe. Ela costumava dizer: "Pode confiar em Maja, ela vai enfrentar". E eu enfrentava. Eu criei seus filhos mais novos, para que ela pudesse levar sua carreira adiante. Ela se tornou mais e mais famosa, mas eu nunca a vi feliz. Quantas vezes eu sentia sua falta durante a noite. As crianças pequenas choravam e eu as confortava, mas eu mesma nunca chorava. Quem teria querido uma criança chorona? Eu só ganharia o amor de minha mãe se fosse competente, compreensiva e controlada, se nunca questionasse suas atitudes nem demonstrasse a falta que sentia dela; isso limitaria a liberdade de que ela tanto necessitava; isso a faria ficar contra mim.

Em outras famílias, as pressões são menos sutis. Uma das formas, a de ameaçar a criança como forma de controlá-la, é uma arma extremamente poderosa, sobretudo com crianças pequenas. Com tais ameaças, o que uma criança faria, senão estar de acordo com os desejos dos pais no sentido de excluir de um processamento futuro tudo que sabe e os pais gostariam que ela esquecesse? Eu já apresentei razões para se acreditar que ameaças desse tipo são responsáveis pela ansiedade aguda e crônica (Bowlby, 1973) e, também, pela resposta à privação com depressão crônica, onde a crença dominante é a de que a criança foi deliberadamente abandonada, como punição, pela pessoa que morreu (Bowlby, 1980).

A hipótese apresentada, segundo a qual várias formas de perturbação cognitiva observadas em crianças e, também, na vida adulta, foram delimitadas por influências que inicialmente atuaram durante os anos pré-adolescentes, é compatível com indicações de que, durante esse anos, a mente das crianças é, de modo especial, sensível a influências externas. Prova disso, já enfatizada, é a extensão em que as crianças pequenas são vulneráveis às ameaças dos pais de rejeitá-las ou mesmo abandoná-las. Depois de a criança ter chegado à adolescência, sua vulnerabilidade para tais ameaças diminui.

A extensão em que a mente dos pré-adolescentes está propensa à influência dos pais é bem ilustrada pelo experimento de Gill (1970). A amostragem compreendeu crianças de dez anos, escolhidas num colégio primário de Londres e seus pais. Das quarenta famílias, não imigrantes, convidadas a participar, vinte e cinco concordaram. Cada família foi visitada em sua própria casa e uma série de dez quadros foi apresentada numa tela, cada quadro por dois minutos.

Dos quadros usados, cinco eram de livros de gravuras ou filmes e os outros de temas de testes de percepção. Alguns eram emocionalmente

benignos; por exemplo, uma mãe observando uma menina que segura um bebê. Alguns mostravam cenas agressivas e/ou amedrontadoras. Três representavam tema sexual: uma mulher obviamente grávida deitada numa cama; um casal abraçado na grama e uma mulher agarrando os ombros de um homem que parece pular, onde aparece ao fundo o quadro de uma mulher seminua.

A série de dez quadros foi apresentada três vezes sucessivas. Na primeira apresentação, foi pedido ao pai, à mãe e à criança que escrevessem, independentemente, o que estavam vendo no quadro. Na segunda, foi solicitado aos membros da família que discutissem cada quadro, enquanto durassem os dois minutos da apresentação. Na terceira, foi pedido que, novamente, cada membro da família, separadamente, escrevesse o que, desta vez, estava vendo.

Quando foram examinadas as respostas das crianças às três gravuras que representavam temas sexuais, descobriu-se que enquanto metade das crianças (doze) descreveram os temas sexuais de forma direta e sem rodeios, a outra metade não conseguiu fazê-lo. Por exemplo, com relação ao quadro da mulher obviamente grávida, veio a cândida resposta de uma criança: "Ela está descansando. Posso ver que ela está esperando bebê. Acho que ela está dormindo". As descrições do mesmo quadro, por outras crianças, omitiam qualquer referência à gravidez: "Alguém está dormindo na cama" e "Tem um homem na cama. Ele está dormindo".

Um segundo passo foi analisar como os pais discutiam o quadro na presença das crianças, durante a segunda apresentação. Isso foi feito por um psicólogo, que não se preocupava com as respostas das crianças. Ficou de novo evidente que enquanto alguns pais eram francos quanto ao que os quadros representavam, outros não faziam nenhuma referência a eles ou expressavam náusea. Por exemplo, no que diz respeito ao quadro da grávida, a mãe de uma criança observou, de forma franca, nas três ocasiões, que a mulher estava esperando bebê e descansando à tarde. Por outro lado, os pais de uma outra criança utilizaram o tempo (dois minutos), para discutir o quadro sem fazer nenhuma referência ao fato. Ao invés disso, eles se concentraram em detalhes emocionalmente neutros, como o estilo do penteado da mulher, o tecido de sua roupa e a qualidade da mobília. Não surpreendeu que tivesse havido uma alta correlação entre a forma com que as crianças respondiam aos quadros e a forma com que os pais discutiam sobre os mesmos.

Na terceira apresentação, as descrições apresentadas por todas as crianças melhoraram em exatidão, mas as descrições daquelas doze crianças que haviam respondido francamente na primeira apresentação melhoraram mais em relação às descrições apresentadas pelas outras treze que não tiveram sucesso em relatar o conteúdo dos quadros na primeira apresentação.

Poder-se-ia levantar uma pequena dúvida de que, durante a discussão dos quadros, alguns dos pais, consciente ou inconscientemente, estivessem

evitando fazer referências ao conteúdo deles. Uma inferência, também razoável, era de que o fracasso das crianças em descrever os temas sexuais, na primeira apresentação, tivesse sido influenciado, de alguma forma, pelo "clima" que vivenciavam em suas próprias casas. O que esse experimento não pôde mostrar foi, certamente, se essas crianças, na realidade, não perceberam a cena representada ou se a perceberam e fracassaram em relatá-la. Já que os pré-adolescentes tendem a ser lentos e, freqüentemente, incertos em suas percepções, meu palpite é de que pelo menos algumas das crianças que tomaram parte no experimento realmente fracassaram em registrar a natureza do que estava acontecendo nos quadros. Outras poderiam saber, intuitivamente, que tal cena era daquelas que se esperava que elas nada soubessem a respeito e, por isso, evitaram reconhecê-la.

À primeira vista, a noção de que uma informação de certo significado pode ser guardada ou, seletivamente excluída da percepção, pode parecer paradoxal. Pergunta-se: como pode uma pessoa, seletivamente, excluir de processamento um estímulo especial, a menos que ela, primeiro, perceba o estímulo que deseja excluir? Esse obstáculo desaparece, entretanto, uma vez que a percepção seja concebida como um processo de múltiplos estágios, como é hoje em dia. Na verdade, o trabalho experimental acerca do processamento de informações no ser humano, levado adiante na última década, nos capacita a ter uma idéia melhor sobre a natureza dos processos de exclusão, que ora discutimos, do que era possível na época em que Freud e outros da tradição psicodinâmica estavam formulando teorias de defesa que exerceram, deste então, tanta influência. No que se segue, faço um breve resumo dessa nova abordagem.

Estudos sobre percepção humana (Erdelyi, 1974; Norman, 1976) mostraram que, antes que uma pessoa esteja ciente de ver alguma coisa ou de ouvir alguma coisa, o fluxo sensorio percebido através dos olhos ou dos ouvidos já passou por muitos estágios de seleção, interpretação e avaliação e que, durante esse curso, uma grande proporção de fluxos originais já foi excluída. A razão para tal extensa exclusão é a de que os canais responsáveis pelos processos mais avançados são de capacidade limitada e, portanto, têm que ser protegidos de uma sobrecarga. Para se assegurar de que o que é mais relevante se vai processar e que somente o menos relevante será excluído, a seleção de fluxo fica sob controle central ou, podemos dizer, sob o controle do ego. Embora esse processamento ocorra numa velocidade extraordinária e quase todo ele fora da consciência, muito fluxo foi levado para um estágio bem avançado do processamento, antes de ser excluído. Os resultados dos experimentos sobre dicotomia auditiva nos oferecem exemplos admiráveis.

Nesse tipo de experimento, duas mensagens diferentes são transmitidas simultaneamente para uma pessoa; uma delas sendo transmitida para um dos dos ouvidos e a outra mensagem para o outro ouvido. É dito, então, à

pessoa que cuide somente de uma das mensagens, digamos, daquela que é recebida pelo ouvido direito. Para assegurar que a pessoa está dando atenção contínua à mensagem, é pedido que ela "sombreie" a mensagem, repetindo, palavra por palavra, à medida que vai ouvindo. Considera-se bastante fácil manter as duas mensagens distintas e ao fim da sessão, o sujeito está, normalmente, com total desconhecimento do conteúdo da mensagem que não foi ouvida. Ainda assim existem exceções significativas. Por exemplo, caso o próprio nome ou outra palavra pessoalmente significativa ocorra na mensagem não cuidada, a pessoa poderá perceber e lembrar. Isso nos mostra que, embora conscientemente não cuidada, essa mensagem está sendo sujeita a processamento contínuo e bastante avançado, durante o qual seu significado está sendo monitorado e seu conteúdo avaliado como relativamente relevante, e tudo isso sem que a pessoa se dê conta do que está ocorrendo.

No curso normal da vida de uma pessoa, os critérios aplicados ao fluxo sensorio, que determinam qual informação deve ser aceita e qual deve ser excluída, são prontamente inteligíveis como refletindo o que, no momento, é de maior interesse da pessoa. Assim, quando a pessoa está com fome, o fluxo sensorio referente à comida ganha prioridade, enquanto outros, que em muitos momentos seriam de interesse, ficam excluídos. Caso houvesse ameaça de perigo, as prioridades rapidamente mudariam, de forma que o fluxo referente à comida fosse temporariamente excluído. Tal mudança nos critérios, que determinam qual o fluxo que será aceito e qual será excluído, é efetuada através da avaliação realizada por sistemas centrais da personalidade.

Ao sumarmos as descobertas produzidas por uma ciência irmã, os pontos principais que desejamos enfatizar são: primeiro, durante o curso da vida, uma pessoa está ocupada em excluir ou afastar uma grande quantidade de informações que chegam a ela; segundo, a pessoa só faz isso depois de a relevância das informações ter sido avaliada; e, terceiro, normalmente, esse processo de exclusão seletiva ocorre de forma a que a pessoa não esteja ciente, em momento algum, do que está ocorrendo.

Sem dúvida, até agora, a maioria desses experimentos se relacionam com o processamento do fluxo sensorio corrente, quer dizer, com a percepção e não com a utilização de informações já estocadas na memória. Ainda assim, parece que os mesmos princípios gerais se aplicam. Em cada caso, os critérios são estabelecidos por um ou vários sistemas centrais de avaliação e são tais critérios que governam qual informação vai passar por um processo consciente mais adiante e qual vai ser excluída. Então, graças ao trabalho de psicólogos cognitivos, não existe mais nenhuma dificuldade em se imaginar e descrever, em termos operacionais, um aparato mental capaz de bloquear informações de certo tipo específico e em fazê-lo sem que a pessoa esteja ciente do que está acontecendo.

Vamos considerar, em seguida, a segunda categoria de cenas e experiências que tendem a se tornar bloqueadas e esquecidas e, ao mesmo

tempo, continuam a ser mais ou menos influentes no sentido de afetar os pensamentos, sentimentos e comportamentos de uma pessoa. Essas cenas e experiências são aquelas em que os pais tratam as crianças de tal forma que estas acham insuportável pensar ou mesmo se lembrar delas. Novamente, aqui, não só existe amnésia parcial ou completa para a sequência de eventos como, também, exclusão da consciência dos pensamentos, sentimentos e impulsos para a ação, que são respostas naturais a tais eventos. Isso resulta em distúrbios maiores da personalidade que, em suas formas mais comuns e menos severas, tendem a ser diagnosticadas como casos de narcisismo ou *false-self* e, em suas formas mais severas, podem ser rotuladas como fuga, psicose ou caso de múltipla personalidade. As experiências que dão origem a tais distúrbios foram provavelmente contínuas e/ou repetidas por muitos anos na infância, talvez começando durante os primeiros dois ou três anos mas, normalmente, continuando durante o quarto, quinto, sexto e sétimo anos e, sem dúvida, por mais tempo ainda. As experiências incluem repetidas rejeições dos pais, combinadas com o desprezo pelos desejos de amor, cuidado e conforto da criança e, nas formas mais severas, violência física, espancamentos repetidos, algumas vezes sistemáticos, e exploração sexual por parte do pai ou companheiro da mãe. Não raro, uma criança nessa categoria é sujeita à combinação de tais experiências.

Nós começamos pelo resultado menos severo do que parece ser um espectro de síndromes relacionadas.

Um exemplo de paciente rotulado como apresentando *false-self* já foi dado numa conferência anterior (v. Conferência 3). Refere-se a um jovem graduado bastante deprimido e com tendências suicidas que, durante a análise, lembrou-se do quanto sua mãe o havia constantemente rejeitado, ignorando seu choro, sendo que às vezes ela se trancava em seu quarto por dias seguidos e, muitas vezes, abandonava a casa. Felizmente, ele estava nas mãos de uma terapeuta que compreendia seus problemas, dava total importância às experiências infantis que ele descrevia e reconhecia tanto seus clamores de amor e cuidado quando seus sentimentos violentos em relação à mãe, que surgiram durante o tratamento e que, inicialmente, eram dirigidos a ela (terapeuta). Um paciente com problemas bastante semelhantes, cujas experiências incluíram um período de dezoito meses numa instituição impessoal, que começou quando ele tinha quatro anos, foi relatado na Conferência 4. Embora esses dois pacientes tenham feito progressos recompensadores, durante o tratamento, ambos permaneceram mais sensíveis do que outros a infortúnios posteriores.

Um certo número de pacientes, tanto crianças quanto adultos, cujas perturbações pareciam ter sua origem em experiências semelhantes, embora muito piores, e que resultara num *splitting* de personalidade em grau ainda maior, foi descrito por terapeutas na última década. Um exemplo é Geraldine, de onze anos, que foi encontrada vagando em estado de torpor e que

tinha perdido a memória quanto à doença terminal de sua mãe e os eventos dos três anos subsequentes. No final de um longo período de terapia, pormenorizadamente descrita por McCann (em Furman, 1974), Geraldine resumiu as experiências que precederam sua amnésia: “Com mamãe, eu morria de medo de sair da linha. Eu via com meus próprios olhos a forma como ela atacava, com palavras e ações meu pai e minha irmã e, além de tudo, eu era só uma criancinha, com muito pouco poder... Como eu poderia me zangar com mamãe? Ela, realmente, era a única segurança que eu tinha... Eu bloqueei todos os meus sentimentos — as coisas que aconteceram foram maiores do que eu poderia suportar — eu tinha que “tocar prá frente”. Se eu realmente deixasse as coisas me machucarem, eu não estaria aqui. Estaria morta ou num hospício”*.

O estado psicológico complexo de Geraldine e, também, suas experiências infantis parecem ter uma grande semelhança com os estados de pacientes que sofrem de múltipla personalidade e com as experiências infantis que são responsáveis por eles.

Num artigo de Bliss (1980), baseado num exame clínico e numa terapia que ocorreu através de hipnose, foi descrito o caso de quatorze pacientes, todas mulheres, e que foram diagnosticadas como tendo personalidade múltipla. A hipótese de Bliss é de que personalidades subordinadas, que tomam posse da paciente, de tempos em tempos, são criações cognitivas da personalidade principal quando, enquanto criança entre quatro e sete anos, ela esteve sujeita durante extensos períodos a eventos intensamente angustiantes. De acordo com Bliss, cada personalidade é inicialmente criada para servir a um propósito ou a um papel distintos. Para opinarmos a partir dos exemplos que ele nos dá, devemos considerar que os papéis são de três tipos principais. O mais simples e benigno é agir como companheiro e protetor, quando a personalidade em desenvolvimento está se sentindo só e isolada, quando, por exemplo, os pais são persistentemente hostis ou ausentes e não existe ninguém para quem se voltar. Um segundo papel é o de ser insensível, para situações insuportavelmente angustiantes, como no caso de uma criança de quatro ou cinco anos que dividia o quarto com a mãe, a qual, morrendo de câncer, passava horas gritando de dor. O terceiro papel é mais complexo, isso é, assumir a responsabilidade de pensar, sentir e agir de determinadas formas que o paciente não pode suportar como sendo suas. Os exemplos dados por Bliss incluem o sentimento violento de ódio pela mãe, que tentou matá-lo, quando criança; ódio resultante da real intenção de matá-la; sentir ou agir sexualmente, depois de ter sido violentada em criança; sentir-se amedrontada e chorosa, depois que o fato de ter chorado resultou em castigos ou ameaças dos pais.

* Um resumo completo do relatório de McCann aparece em *Perda* (Bowlby, 1980, 338-44).

Já que as descobertas advindas de procedimentos hipnóticos são controvertidas, é importante observar que um grupo de pesquisa clínica da Universidade da Califórnia, em Irvine, usando procedimentos convencionais e estudando certo número de casos (Reagor, em comunicação pessoal) chegou a conclusões bastante semelhantes às de Bliss*. Os procedimentos terapêuticos propostos também têm muito em comum e mantêm, além de tudo, os conceitos de terapia esboçados, rapidamente, na última conferência.

Ultimamente, um certo número de psiquiatras e psicoterapeutas infantis (e.g. Stroch, 1974; Rosenfeld, 1975; Bloch, 1978; Hopkins, 1984), descreveu crianças cujos pensamentos e comportamentos nos fazem parecer próxima ou francamente psicóticos, que apresentam idéias paranóides acentuadas e cujas condições sugeridas pelas provas podem ser atribuídas a tratamento persistentemente abusivo por parte de um dos pais. Tais crianças são, de modo freqüente, charmosas e ternas em um momento e extremamente hostis em outros, sendo que a mudança ocorre de maneira repentina e por nenhuma razão aparente. A maior demonstração de violência, no entanto, tende a ser dirigida para pessoas a quem parecem e são, na verdade, mais apegadas. Não raro essas crianças são atormentadas por intenso medo de que algum monstro as ataque e passam o tempo tentando escapar do ataque esperado. Em pelo menos alguns casos existem provas irrefutáveis de que o que se teme é um ataque por parte de um dos pais, porém, como tal expectativa é insuportavelmente assustadora, o ataque é atribuído a um monstro imaginário.

Como exemplo, vamos considerar o caso de Sylvia, de seis anos, relatado por Hopkins (1984), cujo sintoma principal era o terror de que as cadeiras e outras peças da mobília, que ela chamava de Daleks, fossem voar pela sala e se chocar contra ela. "Seu terror era intenso e quando ficava imitando patos e vacas, como se estivessem prestes a receber uma pancada de um Delek, ou outro monstro qualquer, eu achava que ela estava se alucinando". Primeiro, Sylvia expressou o medo de que sua terapeuta também batesse nela, como sua mãe fazia. Ela não só constantemente atacava sua terapeuta como, freqüentemente, ameaçava matá-la.

O pai de Sylvia havia morrido num acidente de automóvel, dois anos antes. Durante vários meses, mediante entrevistas duas vezes por semana com um assistente social, a mãe foi extremamente reservada, falando muito pouco das relações familiares. Com o tempo, entretanto, depois de aproximadamente dois anos, o disfarce foi retirado. Ela admitiu sua maciça rejeição por Sylvia desde o nascimento e os sentimentos assassinos que tanto ela

* Ver também Bliss (1986). Provas adicionais de que a perturbação de personalidade múltipla se desenvolve durante a infância, como uma defesa contra um imenso trauma, geralmente um abuso considerado severo, é relatado por Kluft (1985).

quanto o pai tinham pela menina. Confessou que o tratamento dispensado à Sylvia havia sido "completamente brutal". O pai tinha um temperamento muito violento e não tinham sido raras as vezes em que quebrara a mobília e atirara os pedaços pela sala. Ele, freqüentemente, batia em Sylvia e a havia atirado pela sala.

Então, a identidade dos Daleks não oferecia dúvida. Por trás da "fantasia" de um ataque "Dalek" estava uma expectativa séria e baseada na realidade de um ataque da mãe ou do pai. Como Bloch colocou (1978), uma premissa básica da abordagem terapêutica, que ela e outros advogam para tais casos, é de que aquilo que é tão facilmente denominado como fantasia seja reconhecido como reflexo de uma realidade cruel e que uma tarefa terapêutica inicial é a de identificar as experiências da vida real, que estão por trás de certa camuflagem.

Não são só as experiências infantis das crianças pré-psicóticas, que acreditamos serem as mesmas de pacientes adultos com personalidade múltipla, mas o estado mental descrito pelos respectivos terapeutas têm traços extremamente semelhantes também. Parece altamente provável que as duas condições sejam relacionadas. Além disso, deveria ser observado que essas descobertas dão suporte às hipóteses adiantadas por Niederland (1959 a,b, discutido por Bowlby, 1973) de que as alucinações paranóicas do Juiz Schreber, em que Freud baseou sua teoria da paranóia, eram versões distorcidas de um extraordinário regime pedagógico que o pai do paciente lhe impôs desde poucos meses de vida.

Nesse trabalho, como em quase todos, dei atenção à psicopatologia e a algumas condições que dão início a ela. Minha razão para fazê-lo é a crença de que somente com uma melhor compreensão da etiologia e da psicopatologia será possível desenvolver técnicas terapêuticas e, mais especialmente, medidas preventivas que serão efetivas e econômicas na força de trabalho humana prática.

Minha abordagem terapêutica está longe de ser original. A hipótese básica pode ser esclarecida de forma bastante simples. Quando os modos correntes de perceber e construir situações e os sentimentos e ações que daí resultam são determinados por eventos e experiências emocionalmente significativos, que foram bloqueados do processo consciente, a personalidade estará propensa à cognição, afetos e comportamentos mal-adaptados à situação corrente. Quando o anseio de amor e cuidado é bloqueado, ele continuará inacessível. Quando existe raiva, ela continuará a ser dirigida para alvos inapropriados. De forma semelhante, a ansiedade continuará a ser detonada por situações inapropriadas e esperar-se-á um comportamento hostil de fontes impróprias. A tarefa terapêutica está em ajudar o paciente a descobrir quais podem ter sido esses eventos e experiências, de forma que os pensamentos, sentimentos e comportamentos, que as situações desencadearam e que continuam a ser tão problemáticos, possam, novamente, ser

ligados a essas situações. Assim, os verdadeiros alvos de seus anseios, de sua raiva e a verdadeira fonte de sua ansiedade e medo ficarão claras. Tais descobertas não só mostrarão que suas formas de cognição, sentimento e comportamento são muito mais inteligíveis do que pareciam antes, dadas as circunstâncias em que se originaram, como também, uma vez que o paciente tenha compreendido como e porque responde da forma que o faz, ele estará na posição de reavaliar suas respostas e, se o desejar, reestruturá-las de forma radical. Já que essa reavaliação e reestruturação só podem ser alcançadas pelo próprio paciente, a ênfase de tal formulação na tarefa do terapeuta é a de ajudar o paciente, primeiro, a descobrir por si mesmo quais foram, provavelmente, as experiências e cenas relevantes, e, segundo, despendendo algum tempo ponderando sobre como continuaram a influenciá-lo. Somente então ele estará na posição de encarregar-se da reorganização de seus modos de construir o mundo, pensar sobre ele e atuar no que for solicitado.

Os conceitos de processo terapêutico, esboçado aqui, são semelhantes àqueles descritos muito mais pormenorizadamente por outros. Como exemplos, temos publicações recentes de Peterfreund (1983) e de Guidano e Liotti (1983). Embora os autores dessas publicações tenham começado seus trabalhos terapêuticos com posições radicalmente diferentes, a saber, versões tradicionais de psicanálise e de terapia do comportamento, respectivamente, os princípios que, agora, guiam seus trabalhos, mostram uma convergência surpreendente. De maneira semelhante, formas correntes de terapia de privação, que têm seu foco em eventos angustiantes, num passado comparativamente recente, são conhecidas como tendo base nos mesmos princípios, mesmo quando desenvolvidas dentro de tradições igualmente diferentes (Raphael, 1977; Melges e DeMaso, 1980). Embora táticas divergentes possam aparecer, o pensamento estratégico está em curso convergente.

Conferência 7 ✓

O papel do apego no desenvolvimento da personalidade

As provas relativas ao papel do apego no desenvolvimento da personalidade vêm se acumulando, com rapidez, durante os anos 80. As descobertas iniciais foram refeitas com amostragens de diversas origens, métodos de observação foram aprimorados, novos métodos foram introduzidos e o papel da simples comunicação entre um dos pais e seu filho, visando o desenvolvimento da saúde emocional, foi enfatizado. Já que acredito que este trabalho novo tenha inúmeras conseqüências quanto às implicações clínicas, meu objetivo nesta conferência é o de apresentar uma revisão dessas descobertas, de forma que ela seja compatível com os que trabalham como psicoterapeutas no campo da saúde mental.

Alguns traços distintos da teoria do apego

Devemos lembrar que a teoria do apego foi formulada para explicar certos modelos de comportamento característicos não só de crianças e jovens como também de adolescentes e adultos que foram inicialmente conceitualizados em termos de dependência e superdependência. Em suas formulações originais, as observações de como as crianças respondem, quando colocadas em lugar estranho com pessoas estranhas e os efeitos que tais experiências têm nas relações subsequentes da criança com seus pais, foram de especial influência. Em todo o trabalho subsequente, a teoria continuou sendo muito próxima de observações detalhadas e de dados de entrevistas sobre a forma segundo a qual os indivíduos respondem a situações especiais. Historicamente,

a teoria se desenvolveu a partir da tradição psicanalítica das relações objetais, mas ela se baseou, também, em conceitos da teoria de evolução, etologia, teoria do controle e psicologia cognitiva. Um dos resultados foi a formulação da metapsicologia psicanalítica, de forma compatível com a biologia e a psicologia modernas e em conformidades com os critérios amplamente aceitos da ciência natural (ver Conferência 4).

A teoria do apego enfatiza:

(a) o *status* primário e a função biológica dos laços emocionais íntimos entre indivíduos, cuja formação e manutenção são postulados como sendo controlados por um sistema cibernético, situado no sistema nervoso central, que utiliza modelos funcionais do *self* e da figura de apego, um em relação ao outro.*

(b) a poderosa influência, no desenvolvimento de uma criança, da maneira como é tratada por seus pais, especialmente pela figura materna, e

(c) que o conhecimento atual do desenvolvimento de uma criança requer uma teoria do desenvolvimento que possa tomar o lugar de teorias que invocam fases específicas do desenvolvimento, nas quais — sustenta-se — uma pessoa pode tornar-se fixada e/ou pode retornar.

A primazia dos laços emocionais íntimos

A teoria do apego considera a propensão para estabelecer laços emocionais íntimos com indivíduos especiais como sendo um componente básico da natureza humana, já presente no neonato em forma germinal e que continua na vida adulta e na velhice. Durante a primeira infância, os laços são estabelecidos com os pais (ou pais substitutos), que são procurados para proteção, conforto e suporte. Durante a adolescência saudável e a vida adulta esses laços persistem, sendo, no entanto, complementados por novos laços, comumente de natureza heterossexual. Embora alimento e sexo tenham, às vezes, papéis importantes nas relações de apego, a relação de apego existe por si só e tem função primordial de sobrevivência — proteção. Inicialmente, o único meio de comunicação entre a criança e sua mãe é através da

* Em publicações anteriores usei, algumas vezes, o termo “modelo representacional” como sinônimo de “modelo funcional”, porque o conceito de representação era mais familiar na literatura clínica. Em uma psicologia dinâmica, entretanto, modelo funcional é o termo mais apropriado, e é esse, também, o termo que vem sendo agora mais usado entre os psicólogos cognitivos (e.g. Johnson-Laird, 1983). Dentro da estrutura da teoria de apego é, em muitos momentos, equivalente, ou mesmo toma o lugar do conceito psicanaliticamente tradicional de objeto interno.

expressão emocional e do comportamento que a acompanha. Embora suplementada pela fala, a comunicação mediada pela emoção persiste como um traço principal das relações íntimas pelo resto da vida.

Entretanto, na estrutura da teoria do apego, os laços emocionais íntimos não são vistos nem como subordinados nem como derivados de alimento e de sexo. Tampouco o desejo urgente de conforto e suporte, em situações adversas, é visto como sendo infantil, como sugere a teoria da dependência. Ao invés disso, a capacidade de estabelecer laços emocionais íntimos com outros indivíduos, às vezes no papel da figura que busca ser cuidada, é considerada como o traço principal do efetivo funcionamento da personalidade e saúde mental.

Via de regra, buscar cuidado é traço de um indivíduo mais fraco e menos experiente em relação a outro considerado mais forte e/ou mais sábio. Uma criança ou uma pessoa mais velha, no papel de quem busca cuidado, mantém, em relação ao protetor, um grau de proximidade ou de rápido acesso de acordo com as circunstâncias; até então, este é o conceito de comportamento de apego.

O cuidar, o papel mais importante dos pais e complementar ao comportamento de apego, é considerado sob a mesma luz em que foi considerada a busca de cuidado, quer dizer, como um componente da natureza humana (ver Conferência 1).

Explorar o meio ambiente, incluindo as brincadeiras e as várias atividades com crianças da mesma idade, é visto como um terceiro componente básico e como antítese do comportamento de apego. Quando um indivíduo (de qualquer idade) está se sentindo seguro, ele tende a explorar para longe de sua figura de apego. Quando alarmado, cansado ou sentindo-se mal, sente urgência da proximidade. Vemos, então, o modelo típico de interação entre uma criança e um dos pais, conhecido como exploração a partir de uma base segura, descrito, primeiramente, por Ainsworth (1967). Uma criança saudável sente-se suficientemente segura para explorar, quando sabe que seus pais estão acessíveis e serão receptivos quando requisitados. Inicialmente, essas explorações são limitadas tanto em tempo quanto em espaço. Por volta da metade do terceiro ano, entretanto, uma criança segura começa a tornar-se suficientemente confiante para aumentar tanto o tempo quanto a distância — primeiro para metade de um dia e, mais tarde, para dias inteiros. À medida que entra na adolescência, suas excursões se estendem para semanas e meses, porém, um lar considerado base segura continua sendo indispensável para um funcionamento ótimo, assim como para a saúde mental. Devemos observar que o conceito de base segura é um traço central na teoria da psicoterapia proposta.

Durante os primeiros meses de vida, uma criança mostra muitas das respostas que, mais tarde, transformar-se-ão em comportamento de apego, embora o modelo organizado não se desenvolva até a segunda metade do

primeiro ano. Do nascimento em diante, a criança mostra uma capacidade crescente para se engajar na interação social e sentir prazer em fazê-lo (Stern, 1985.) Dessa forma, não existe fase autista ou narcísica. Em poucos dias, ela está apta a distinguir sua figura materna das outras figuras por meio do odor e da voz como, também, pela forma como ela a pega ao colo. Discriminações visuais não são consideradas antes dos três meses. Inicialmente, o choro é a única forma disponível de a criança sinalizar suas necessidades de cuidado e o contentamento a única forma de sinalizar sua satisfação. Durante o segundo mês, entretanto, o sorriso social atua poderosamente no sentido de encorajar a mãe em sua tarefa e o repertório de comunicação emocional da criança se amplia com rapidez (Izard, 1982; Emde, 1983).

Como o desenvolvimento do comportamento de apego é um sistema organizado, que tem como objetivo a manutenção da proximidade ou do acesso a uma figura materna discriminada, requer da criança o desenvolvimento de sua capacidade cognitiva para que mantenha sua mãe na memória quando esta não está presente; essa capacidade se desenvolve durante a segunda metade do primeiro ano de vida. Dessa forma, dos nove meses em diante, a grande maioria das crianças respondem com protesto e choro ao fato de serem deixadas com uma pessoa estranha e, também, ficando de mau-humor e rejeitando o estranho por tempo mais ou menos prolongado. Essas observações demonstraram que, durante esses meses, a criança está se tornando capaz de representações e que o modelo funcional, que ela tem de sua mãe, está se tornando disponível com o propósito de comparação durante sua ausência e reconhecimento depois do seu retorno. Complementando o modelo que a criança tem de sua mãe, ela desenvolve um modelo funcional de si mesma em interação com a mãe, da mesma forma que com o pai.

Um dos aspectos mais relevantes da teoria do apego é a hipótese de que o comportamento de apego é organizado por meio de um sistema de controle inscrito no sistema nervoso central, de forma análoga aos sistemas de controle fisiológicos, que mantêm medidas fisiológicas tais como pressão sanguínea e temperatura do corpo. Dessa forma, a teoria propõe que, de forma análoga à homeostase fisiológica, o sistema de controle do comportamento de apego mantém a relação da pessoa com sua figura de apego dentro de certos limites de distância e acessibilidade, usando, para fazê-lo, métodos extremamente sofisticados de comunicação. Assim, o efeito dessa operação pode ser considerado como um exemplo do que pode ser chamado, de forma útil, de homeostase ambiental (Bowlby, 1969, 1982). Ao postular um sistema de controle desse tipo (sistemas análogos controlam outras formas de comportamento), a teoria do apego contém em si uma teoria da motivação, que pode tomar o lugar de teorias tradicionais, que invocam energia ou impulso. Em meio às muitas vantagens da teoria do controle, está o fato de que é dada tanta atenção às condições que finalizam

uma sequência comportamental quanto às que a iniciam, assim como oferece uma estrutura fértil para pesquisas empíricas.

A presença de um sistema de controle do comportamento de apego e sua ligação com os modelos funcionais do *self* e da(s) figura(s) de apego, que são elaborados na mente durante a infância, é considerada como traços centrais do funcionamento da personalidade durante toda a vida.

Modelos de apego e condições que determinam o seu desenvolvimento

A segunda área, a que a teoria do apego dedica atenção especial, é quanto ao papel dos pais da criança em determinar como ela se desenvolverá. Existem, hoje em dia, evidências impressionantes e crescentes de que o modelo de apego, que um indivíduo desenvolve durante os anos de imaturidade — primeira infância, infância e adolescência — é profundamente influenciado pela maneira como seus pais (ou outras figuras parentais substitutas) o tratam. Essas evidências derivam de um grande número de estudos e pesquisas sistemáticas, sendo os mais impressionantes os estudos prospectivos do desenvolvimento sócio-emocional durante os cinco primeiros anos, feitos por psicólogos do desenvolvimento, que são também clinicamente sofisticados. Tais estudos, que tiveram Mary Ainsworth como pioneira (Ainsworth, Blehar, Waters e Wall, 1978; Ainsworth, 1985) e que foram notavelmente expandidos por Main (Main, Kaplan e Cassidy, 1985), Sroufe (1983, 1985) nos Estados Unidos e por Grossmann (Grossmann, Grossmann e Schan, 1986) na Alemanha, vêm agora se multiplicando rapidamente. As descobertas são bastante consistentes e claras, no que se refere ao significado clínico.

Três modelos principais de apego, primeiramente descritos por Ainsworth e seus colegas em 1971, são agora identificados juntamente com as condições familiares que os promoveram. O primeiro desses modelos é o do apego seguro, onde o indivíduo está confiante de que seus pais (ou figuras paternas) estarão disponíveis oferecendo resposta e ajuda, caso ele se depare com alguma situação adversa ou amedrontadora. Essa segurança faz com que ele se sinta corajoso para explorar o mundo. Esse modelo é promovido por um dos pais, especialmente a mãe, nos primeiros anos, quando esta está imediatamente disponível, sensível aos sinais da criança e com respostas amáveis, sempre que ela procura proteção e/ou conforto.

Um segundo modelo é o do apego resistente e ansioso, no qual o indivíduo se mostra incerto quanto à disponibilidade, à possibilidade de receber resposta ou mesmo ajuda por parte de seus pais, caso necessite. Por causa dessa incerteza, ele tende, constantemente, à ansiedade de separação, a ficar “grudado” e a ficar ansioso quanto à exploração do mundo. Esse modelo, onde fica evidente o conflito, é promovido por pais que se mostram disponíveis

e prestativos em algumas ocasiões e não em outras, é promovido por separações e, como mostram as descobertas clínicas, por ameaças de abandono usadas como meio de controle.

Um terceiro modelo é o do apego ansioso com evitação, onde o indivíduo não tem nenhuma confiança de que quando procurar cuidado terá resposta e ajuda, mas, ao contrário, espera ser rejeitado. Quando em grau alto, o indivíduo procura viver sua vida sem o amor e a ajuda de outros, tenta tornar-se emocionalmente auto-suficiente e, mais tarde, talvez, seja diagnosticado como narcisista ou *false-self* do tipo descrito por Winnicott (1960). Esse modelo, onde o conflito está mais escondido, é resultado de constante rejeição por parte da mãe, sempre que o indivíduo a procurava a fim de obter conforto e proteção. Os casos mais extremos são resultado de rejeições repetidas.

Embora, na maioria dos casos, o modelo observado condiga com um outro dos três modelos distintos, existem algumas exceções. Durante os procedimentos iniciais, usados nesses estudos (Situação Estranha de Ainsworth), onde a criança e a mãe são observadas em interação durante uma série de episódios curtos, algumas crianças pareceram estar desorientadas e/ou desorganizadas. Uma criança parecia estar tonta; outra parecia ter congelado, de tão imóvel; uma terceira engajou-se em alguma estereotipia; uma quarta criança começou um movimento e o interrompeu incontáveis vezes. Depois de muito estudo, Main e seus colegas concluíram que tais formas peculiares de comportamento ocorrem em crianças que estão exibindo uma versão desorganizada de um dos três modelos típicos, sendo que com mais frequência o modelo resistente é ansioso (Main e Weston, 1981; Main e Solomon, no prelo). Alguns exemplos são vistos em crianças que foram submetidas a abuso físico e/ou foram completamente negligenciadas pelos pais (Crittenden, 1985). Outros tipos ocorrem nas díades onde a mãe sofre de uma forma severa de uma doença afetiva bipolar e trata seu filho de forma errada e imprevisível (Radke Yarrow *et al.*, 1985). Outras formas são apresentadas por crianças cujas mães estão preocupadas com o luto referente à perda de uma figura parental, cuja morte ocorreu durante sua infância e por mães que sofreram abusos físicos ou sexuais enquanto crianças (Main e Hesse, no prelo). Os casos que apresentam estes modelos anormais são, sem dúvida, de grande importância clínica e recebem, hoje em dia, muita atenção.

O conhecimento das origens desses modelos anormais confirma, de forma bastante clara, a influência que a maneira como os pais tratam a criança exerce no seu modelo de apego. Outras provas, que confirmam esta hipótese, são provenientes de observações detalhadas da forma como diversas mães tratam seus filhos durante sessões de laboratório, que ocorrem quando a criança tem dois anos e meio (Matas, Arend e Sroufe, 1978). Neste estudo é dada à criança uma tarefa pequena, porém difícil, cuja solução requer alguma assistência e a mãe se encontra livre para interagir com ela. Nesta

situação, percebeu-se que a forma como a mãe trata a criança está intimamente correlacionada com o modelo de apego que a criança apresentou em relação a ela, dezoito meses antes. Então, a mãe de uma criança considerada, anteriormente, como seguramente apegada é vista como atenta e sensível à atuação dessa criança, assim oferece respostas tanto aos sucessos quanto às dificuldades da criança, de forma encorajadora e amiga. De forma oposta, a mãe de uma criança anteriormente considerada como insegura é vista como menos atenta e/ou menos sensível. Em alguns casos, as respostas dessa mãe são fora do tempo ou inúteis; em outros, ela toma pouco conhecimento do que a criança está fazendo ou de como ela está se sentindo; em outros casos ainda, ela pode efetivamente desencorajar ou rejeitar seus pedidos de ajuda e conforto. Cabe observar que o modelo de interação adotado pela mãe de uma criança segura oferece um excelente exemplo para o modelo de intervenção terapêutica adotado e defendido aqui.

Ao sublinhar a grande influência que a mãe de uma criança tem em seu desenvolvimento, faz-se necessário considerar o que levou a mãe a adotar o estilo de maternagem que adota. É, também, de grande influência a quantidade de suporte emocional, ou a falta dele, que a mãe recebe. A forma de maternagem que a mãe recebeu quando criança também é de grande influência. Uma vez que esses fatores sejam reconhecidos, como há muito tempo vêm sendo por muitos clínicos analiticamente orientados, a idéia de culpar os pais desaparece dando lugar à abordagem terapêutica. Já que os problemas emocionais dos pais, oriundos de seu passado, e os seus efeitos sobre as crianças tornaram-se um campo de pesquisa sistemática, uma breve descrição do trabalho atual é feita no final da Conferência 8.

Persistência dos modelos

Se nos voltarmos para os modelos de apego, já observados em crianças de um ano de idade, veremos que os estudos prospectivos demonstram que cada modelo, uma vez desenvolvido, tende a persistir. Uma das razões para isto é que a forma como os pais tratam a criança tende a continuar, mesmo que as conseqüências não sejam previsíveis. Uma outra razão é que cada modelo tende a ser autoperpetuante. Então, uma criança segura é mais feliz, mais cooperativa no cuidado e menos exigente do que uma criança ansiosa. Uma criança ansiosa e ambivalente tende a ser "resmungona" e agarrada, enquanto uma criança ansiosa e evitante mantém-se a distância e tende a implicar com outras crianças. Nestes dois últimos casos, o comportamento da criança tende a favorecer uma resposta desfavorável por parte dos pais, dando início, assim, ao desenvolvimento de um círculo vicioso.

Embora por essas razões os modelos formados estejam aptos a persistirem, não é necessariamente assim. As evidências mostram que durante

os dois ou três primeiros anos, o modelo de apego é uma propriedade da relação, por exemplo, criança-mãe ou criança-pai, e se um dos pais passa a tratar a criança de forma diferente, o modelo também se modifica. As provas de que a estabilidade do modelo, quando ocorre, não podem ser atribuídas ao temperamento inato da criança, como foi algumas vezes considerado, estão, entre outras, revisadas por Sroufe (1985). No entanto, à medida que a criança cresce, o modelo se torna cada vez mais uma propriedade da própria criança, o que significa que ela tenderá a impô-lo, ou algum derivado dele, às novas relações que estabelecer, como com uma professora, uma mãe substituta ou um terapeuta.

Os resultados deste processo de internalização são evidentes num estudo prospectivo que mostra que o modelo de apego característico do par mãe-filho, avaliado quando a criança estava com doze meses é altamente facilitador para a previsão de como esta criança se comportará num grupo de creche (com a mãe ausente) três anos e meio mais tarde. Desta forma, as crianças que apresentaram um modelo seguro com a mãe aos doze meses, tendem a ser descritas pelas pessoas da creche como cooperativas, populares entre as outras crianças, fortes e capazes. Aquelas que apresentaram um modelo ansioso e evitante tendem a ser descritas como emocionalmente afastadas, hostis ou anti-sociais e, paradoxalmente, buscando excessivamente atenção. Aquelas que apresentaram um modelo ansioso e resistente tendem a ser descritas, também, como buscando excessivamente atenção e ora tensas, impulsivas e facilmente frustradas, ora passivas e incapazes (Sroufe, 1983). Tendo em vista estas descobertas, é pouco surpreendente que em dois outros estudos prospectivos, sendo um deles um estudo pioneiro na Califórnia (Main e Cassidy, no prelo) e o outro, semelhante, na Alemanha (Wärtnier, 1986), o modelo de apego avaliado aos doze meses tenha sido considerado altamente previsível, assim como os modelos de interação com a mãe, cinco anos mais tarde.

Embora o repertório de comportamento de uma criança de seis anos em relação a um dos pais seja muito maior do que o de uma criança de um ano, os modelos de apego iniciais são prontamente discerníveis, numa idade mais avançada, por um observador treinado.

Assim, as crianças que são classificadas como seguramente apegadas aos seis anos são aquelas que tratam seus pais de uma forma relaxada e amigável, estabelecem intimidade com eles de forma fácil e sutil e mantêm um fluxo livre de conversação. As crianças, classificadas como ansiosas e resistentes, mostram uma mistura de insegurança que inclui tristeza e medo, e intimidade alternada com hostilidade, às vezes sutil e às vezes extrovertida. Em alguns destes casos, o comportamento da criança parece, ao observador, autoconsciente ou mesmo artificial. Embora elas sempre estejam antecipando uma resposta negativa por parte dos pais, tentam "aparecer" como "boazinhas" ou especialmente charmosas (Main e Cassidy, no prelo; Main, comunicação pessoal).

As crianças de seis anos classificadas como ansiosas e evitantes tendem a manter os pais a distância. As saudações, se ocorrem, são formais e rápidas; os tópicos de conversação permanecem impessoais. A criança mantém-se ocupada com brinquedos ou alguma outra atividade e ignora, ou se mostra desatenta, às iniciativas dos pais.

As crianças, que aos doze meses, parecem ser desorganizadas e/ou desorientadas são aquelas que, cinco anos mais tarde, serão consideradas como mostrando, com evidência, sua tendência para controlar ou dominar os pais. Uma das formas de fazê-lo é tratar os pais de forma humilhante ou rejeitadora; uma outra é sendo solícito e protetor. Estes são exemplos claros daquilo que os clínicos rotularam como inversão ou reverso dos papéis da criança e dos pais. As conversas entre eles são fragmentadas, as frases que são iniciadas permanecem inacabadas e os tópicos abordados se transformam abruptamente.

Considerando a persistência do modelo de interação de uma criança de seis anos com seus pais e com outras figuras parentais, surge uma questão crucial: em que medida os modelos estão, nesta idade, enraizados na personalidade da criança e em que medida eles são um reflexo da forma como os pais ainda a tratam? A resposta que a experiência clínica aponta é que, por volta desta idade, as duas influências estão atuando de forma que as intervenções mais efetivas são aquelas que levam as duas em considerações, e.g. por meio de terapia de família ou por meio de ajuda aos pais e a criança paralelamente.

Ainda assim, sabe-se muito pouco sobre a influência no desenvolvimento da personalidade das interações com a mãe comparada com as interações com o pai. Seria pouco surpreendente se as diferentes facetas da personalidade, manifestadas em diferentes situações, fossem influenciadas diferentemente. Além disso, as respectivas influências em homens tenderão a ser distintas das respectivas influências em mulheres. Certamente é uma área complexa, que requer muita pesquisa. Enquanto isso, parece que pelo menos durante os primeiros anos de vida de um indivíduo, o modelo do *self* em interação com a mãe é o que exerce a maior influência. Isto não causaria muita surpresa, já que em todas as culturas conhecidas, a grande maioria dos bebês e crianças interage muito mais com a mãe do que com o pai.

Deve-se reconhecer que, até agora, os estudos prospectivos acerca da relativa persistência dos modelos de apego e dos traços de personalidade característicos de cada um ainda não foram realizados depois do sexto ano. Mesmo assim, dois estudos transversais de jovens adultos mostram que os traços de personalidade característicos de cada modelo durante os primeiros anos também são encontrados em jovens adultos (Kobak e Sceery, 1987; Cassidy e Kobak, no prelo; Hazan e Shaver, 1987); e é mais do que provável que eles tenham estado continuamente presentes, exceto nos casos em que a

relação familiar tenha mudado substancialmente nesse intervalo. Todas as nossas experiências clínicas dão forte suporte a esse ponto de vista.

Uma teoria de internalização

Com a intenção de explicar a tendência dos modelos de apego de se tomarem, de forma intensa, uma propriedade da criança, a teoria do apego invoca o conceito de modelos funcionais do *self* e dos pais, já descritos. Os modelos funcionais, que a criança constrói de sua mãe e da forma como ela se comunica e se comporta em relação à criança, junto a um modelo comparável do pai e aos modelos complementares de si mesma em interação com cada um deles, são construídos pela criança durante os primeiros anos de sua vida e, postula-se, tornam-se rapidamente estabelecidos como estruturas cognitivas influentes (Main, Kaplan e Cassidy, 1985). As formas que assumem, sugerem as evidências já amplamente revistas, baseiam-se na experiência da vida real da criança, no que concerne à sua interação com os pais. Subseqüentemente, o modelo que ela constrói de si mesma também reflete a imagem que os pais têm dela, imagem que é comunicada não só pela forma como a tratam, mas, também, pelo que cada um diz sobre ela. Esses modelos, então, governam o que ela sente em relação a cada um dos pais, em relação a ela mesma, a forma como ela espera que cada um a trate e a forma como planeja seu próprio comportamento em relação a eles. Esses modelos também governam os medos, assim como os desejos expressos em suas fantasias.

Uma vez construídos, sugerem as evidências, os modelos dos pais e do *self* em interação tendem a persistir e, acredita-se, passam a operar em nível inconsciente. À medida que a criança seguramente apegada cresce e seus pais a tratam diferentemente, ocorre uma atualização gradual dos modelos. Isto quer dizer que apesar do período de tempo transcorrido, seus modelos funcionais continuam a ser representações relativamente boas de si mesma e de seus pais em interação. No caso da criança ansiosamente apegada, em contraste, essa atualização gradual de modelos é, em algum grau, obstruída pela exclusão defensiva de experiências e informações discrepantes. Isto quer dizer que o modelo de interação, por ter se tornado habitual, generalizado e bastante inconsciente, persiste num estado mais ou menos imutável, mesmo quando o indivíduo, na vida madura, lida com pessoas que o tratam de forma completamente diferente daquela adotada por seus pais, quando ele era criança.

Uma pista para a compreensão dessas diferenças de grau em que os modelos são atualizados deve ser encontrada nas profundas diferenças quanto à liberdade de comunicação entre mãe e filho, que caracterizam pares dos dois tipos. Esta é uma variável para a qual Bretherton (1987) chamou especial atenção.

Observaremos que no estudo longitudinal de Main, descrito acima como modelo de comunicação entre uma criança de seis anos e sua mãe, o modelo observado no par que cinco anos antes tinha apresentado um modelo de apego seguro é bastante diferente daquele observado num par que, anteriormente, havia apresentado um modelo inseguro. Enquanto um par seguro se engaja numa conversa que flui livremente, e é entrelaçada de expressões de sentimento e aborda uma variedade de tópicos, incluindo os pessoais, os pares inseguros não o fazem. Em alguns pares, as conversas são fragmentadas e os tópicos mudam abruptamente. Em outros, especialmente nos pares evitantes, a conversa é limitada, os tópicos mantêm-se impessoais e todas as referências a sentimentos são omitidas. Essas diferenças marcantes, no grau em que a conversa é livre ou restrita, são postuladas como sendo de grande relevância para a compreensão das razões que levam uma criança a se desenvolver de forma saudável e outra de forma perturbada. Além disso, não passará despercebido que essa mesma variável — o grau em que a comunicação entre dois indivíduos é restrita ou relativamente livre — é há muito reconhecida como de central importância na prática da psicoterapia analítica.

Para que a relação entre dois indivíduos prossiga harmoniosamente, cada um deve estar ciente dos pontos de vista, objetivos, sentimento e intenções do outro e cada um deve ajustar seu próprio comportamento de forma que alguma aliança de objetivos seja alcançada. Isto requer que cada um possua modelos de si e do outro razoavelmente aprimorados e que sejam regularmente atualizados pela comunicação livre entre eles. É aqui que as mães de crianças seguramente apegadas são eficazes, enquanto que as das crianças inseguras são deficientes.

Uma vez focalizado em que grau a comunicação entre o par pai/mãe-filho flui livremente ou não, torna-se rapidamente visível, desde os primeiros dias de vida, que o grau de liberdade de comunicação nos pares destinados a desenvolver um modelo de apego seguro é muito maior do que naqueles em que isto não ocorre (Ainsworth, Bell e Stayton, 1971; Blehar, Lieberman e Ainsworth, 1977). Uma das características da mãe, cujo filho se desenvolverá seguramente, é estar continuamente controlando o estado de seu filho e, sempre que ele sinalizar um pedido de atenção, registrar e atuar de acordo. De forma oposta, a mãe de uma criança, que mais tarde será descrita como ansiosamente apegada, tende a controlar o estado de seu filho de forma esporádica e, quando percebe os sinais, responde tardiamente e/ou de forma inadequada. Quando a criança chega a seu primeiro aniversário, essas diferenças quanto à liberdade de comunicação já se tornaram evidentes, como nos demonstra o procedimento da Situação Estranha de Ainsworth (Grossman, Grossman e Schwan, 1986). Mesmo no episódio introdutório, quando a criança e a mãe estão juntas e sozinhas, os pares seguros, como foi observado, se engajam numa comunicação direta, através dos olhares, da expressão

facial, da vocalização e mostram ou oferecem brinquedos com mais frequência do que os pares considerados inseguros. À medida que o *stress* da criança aumenta, aumentam também as diferenças entre os pares. Desta forma, no episódio de reunião, depois da segunda separação, quinze dos dezesseis pares seguros se comunicaram de forma direta, em contraste com uma minoria dos pares inseguros. Além disso, houve uma outra diferença igualmente relevante. Enquanto cada criança, classificada como segura, era vista em comunicação direta com a mãe quando estava contente assim como em situações de aflição, as crianças classificadas como evitantes só estabeleciam comunicação quando estavam contentes.

Então, com aproximadamente doze meses, existem crianças que já não expressam para suas mães suas mais profundas emoções ou o igualmente intenso desejo de conforto e segurança que as acompanha. Não é difícil ver que isso representa um sério colapso da comunicação entre a criança e a mãe. Não somente isso, posto que o modelo do eu que a criança tem é profundamente influenciado pela forma como a mãe a vê e trata, o que quer que a mãe deixe de reconhecer na criança também esta deixará de reconhecer em si. Desta forma, postula-se, a maior parte da personalidade em desenvolvimento de uma criança pode tornar-se separada, quer dizer, sem comunicação com aquelas outras partes da sua personalidade, que a mãe reconhece e oferece respostas e que, em alguns casos, incluem traços de personalidade, que a mãe está, erradamente, atribuindo à criança.

O resultado dessa análise é que a obstrução da comunicação entre as diferentes partes ou sistemas dentro de uma personalidade, que já desde o início Freud apontou como problema crucial a ser resolvido, é vista agora como o reflexo de respostas e comunicações diferenciadas da mãe para com seu filho. Quando a mãe oferece respostas favoráveis a somente algumas das comunicações emocionais de seu filho e dá as costas ou efetivamente desencoraja outras partes, fica estabelecido um modelo em que a criança se identifica com as respostas favoráveis e descarta as outras.

Seguindo essas linhas é que a teoria do apego explica o desenvolvimento diferenciado de personalidades resistentes e mentalmente saudáveis, assim como de personalidades que tendem à ansiedade e depressão, ao desenvolvimento de um *false-self* ou outra forma de vulnerabilidade para a doença mental. Talvez não seja uma coincidência o fato de alguns daqueles que lidam com problemas de desenvolvimento da personalidade e psicopatologia de um ponto de vista cognitivo, mas que também dão peso ao poder da emoção, e.g. Epstein (1980, 19860) e Liotti (1986, 1987), terem formulado teorias que são essencialmente compatíveis com esta.

Variações na forma em que a mãe relembra suas experiências infantis

A conclusão a que chegamos até aqui, acerca do papel da livre comunicação emocional e cognitiva na determinação da saúde mental, é fortemente apoiada por uma descoberta recente e muito importante a partir do estudo longitudinal de Main. Como resultado da entrevista com as mães das crianças que fizeram parte do estudo, Main encontrou uma forte correlação entre a forma como a mãe descreve seu relacionamento com seus pais durante sua própria infância e o modelo de apego que seu filho agora estabelece com ela (Main, Kaplan e Cassidy, 1985; ver também Morris, 1981 e Ricks, 1985). Enquanto a mãe de uma criança segura é capaz de falar livremente e com emoção sobre sua própria infância, a mãe de uma criança insegura não o faz.

Nesta parte do estudo, um entrevistador pede à mãe que faça uma descrição de suas primeiras relações, de eventos de apego e de que forma, no seu ponto de vista, essas relações e eventos afetaram sua personalidade. Ao considerar os resultados, muita atenção é dada à forma como a mãe conta sua história e lida com as questões que investigam essa história, assim como o material histórico que ela descreve. Em nível mais simples, descobriu-se que a mãe de uma criança segura tende a relatar uma infância relativamente feliz e a se mostrar capaz de falar sobre isso prontamente e em detalhes, colocando no lugar certo os eventos infelizes que porventura aconteceram, assim como os felizes. De forma oposta, a mãe de uma criança insegura tende a responder ao inquérito de uma entre duas diferentes maneiras: uma delas, apresentada pelas mães de crianças ansiosas e resistentes, é descrevendo um relacionamento difícil e infeliz com sua própria mãe, o que claramente ainda a perturba e a mantém mentalmente presa e caso sua mãe ainda esteja viva, fica evidente que ela está presa a ela, também, na realidade. A outra maneira, apresentada pelas mães de crianças consideradas ansiosas e evitantes, é a de dar a nítida impressão de que tiveram uma infância feliz, mas não só se mostram incapazes de apresentar detalhes que sustentem esta descrição, como referem-se a episódios que apontam para a direção oposta. Com frequência, tais mães insistem que não conseguem lembrar de quase nada de suas infâncias e muito menos da forma como eram tratadas. Assim, a forte impressão do clínico, de que a mãe que teve uma infância feliz, tende a ter um filho que apresenta um apego seguro a ela e que uma infância infeliz, mais ou menos acobertada pela incapacidade de lembrar, cria dificuldades, é amplamente sustentada.

No entanto, uma segunda descoberta, não menos interessante e de grande relevância, surgiu de um estudo das exceções às regras gerais. Essas são as mães que disseram ter tido uma infância muito infeliz, mas que, no entanto, têm filhos que demonstram apegos seguros a elas. Uma característica dessas mães,

que as distingue de mães de crianças inseguras, é que, apesar de descreverem muita rejeição e infelicidade, no período da infância, levando-as a chorar ao descrevê-lo, são capazes de contar suas histórias de forma coerente e fluente, onde os aspectos positivos de suas experiências tomam o lugar correto e parecem integrados com os que foram negativos. Na capacidade de equilíbrio, elas se assemelharam às mães de crianças seguras. Isto deu aos entrevistadores e aos que tiveram acesso às informações, a impressão de que essas mães excepcionais tinham pensado muito sobre suas experiências infelizes do início da vida, assim como sobre a forma como essas experiências as afetaram a longo prazo e, também, sobre o porquê de seus pais as terem tratado da forma que o fizeram. De fato, elas pareciam ter aceito suas próprias experiências.

De forma oposta, as mães de crianças cujo modelo de apego em relação a elas era inseguro e que também descreviam uma infância infeliz, o faziam sem fluência ou coerência: as contradições eram abundantes e passavam como que despercebidas por elas. Além disso, a mãe que falou de incapacidade para relembrar sua infância e o fez repetida e intensamente, foi aquela cujo filho era inseguro em sua relação com ela.*

À luz dessas descobertas, Main e seu grupo concluíram que o livre acesso e uma organização coerente de informação relevante ao apego têm um papel determinante no desenvolvimento de uma personalidade segura, na vida adulta. Para aqueles que tiveram infâncias felizes, nenhum obstáculo poderá interferir no livre acesso aos aspectos emocionais e cognitivos de tais informações. Para aqueles que sofreram muita infelicidade ou cujos pais os proibiram de tomar conhecimento ou mesmo lembrar de alguns eventos adversos, o acesso é doloroso e difícil e, sem ajuda, poderá mesmo ser impossível. No entanto, embora seja difícil, quando uma mulher consegue preservar ou recuperar o acesso a memórias tão infelizes e reprocessá-las, de tal forma que possa, então, elaborá-las, ela estará não menos apta a responder ao comportamento de apego de seu filho, de forma que ele desenvolva um apego seguro a ela, do que uma mulher cuja infância foi feliz. Esta é uma descoberta que oferece grande encorajamento aos muitos terapeutas, que há tempos tentam ajudar mães exatamente desta forma. Referências adicionais, sobre a técnica para auxiliar mães perturbadas, são feitas no final da Conferência 8.

Caminhos para o desenvolvimento da personalidade

Existe mais um aspecto, no qual a teoria do apego difere das teorias psicanalíticas tradicionais, especialmente, a relação aos modelos de

* Em um exame mais profundo dos dados, descobriu-se que todas essas relações também se aplicam aos pais (Main, comunicação pessoal).

desenvolvimento nos quais o indivíduo é visto como passando por uma série de estágios, em cada um dos quais ele pode tornar-se fixado ou retornar e a sua substituição por um modelo no qual o indivíduo é visto como uma progressão ao longo de um ou outro grupo de caminhos potenciais de desenvolvimento. Alguns desses caminhos são compatíveis com o desenvolvimento saudável; outros, desviam-se em uma ou outra direção, em formas incompatíveis com a saúde.

Todas as variantes do modelo tradicional, que invocam fases de desenvolvimento, são baseadas na afirmativa de que em algumas fases do desenvolvimento normal, uma criança mostra traços psicológicos que, em indivíduos mais velhos, serão considerados como sinais de patologia. Então, um adulto, cronicamente ansioso e agarrado, pode ser considerado como tendo se fixado ou regredido à uma fase postulada como sendo de oralidade ou de simbiose; enquanto que um indivíduo profundamente introvertido pode ser considerado como tendo regredido à fase postulada como autismo ou narcisismo. Estudos sistemáticos e sensíveis de crianças, como os relatados por Stern (1985), fizeram com que o modelo defendido aqui se tornasse indiscutível. As observações mostram que as crianças respondem socialmente desde o nascimento. Bebês, com desenvolvimento saudável, não apresentam um agarramento ansioso, a menos que estejam amedrontados ou perturbados; nos outros momentos, eles exploram com confiança.

O modelo dos caminhos de desenvolvimento considera um bebê como tendo, desde o nascimento, um grupo de caminhos potencialmente abertos para ele; aquele ao longo do qual ele irá caminhar será determinado, a todo momento, pela interação entre como ele é agora e o meio ambiente em que ele se encontra. Cada criança é considerada como tendo seu próprio grupo de caminhos potenciais para o desenvolvimento da personalidade que, exceto para as crianças nascidas com certos tipos de danos neurológicos, incluem muitos que são compatíveis com a saúde mental e outros que são incompatíveis. O caminho especial, que a criança vai percorrer, é determinado pelo meio ambiente que ela encontra, especialmente pela forma como os pais (ou pais substitutos) a tratam e como ela responde a eles. As crianças, cujos pais são sensíveis e oferecem respostas, estão capacitadas a se desenvolverem ao longo de um caminho saudável. Aquelas, cujos pais são insensíveis, não oferecem respostas, são negligentes ou as rejeitam, tendem a se desenvolver ao longo de um caminho anormal que, em certo grau, é incompatível com a saúde mental e que as tornam vulneráveis a um colapso, caso se deparem com situações adversas. Assim mesmo, desde que o curso do desenvolvimento subsequente não esteja estabelecido, as mudanças na forma como a criança é tratada podem alterar o seu caminho para uma direção mais favorável ou menos favorável. Embora a capacidade para mudanças no desenvolvimento diminua com a idade, estas mudanças continuam durante todo o ciclo vital, de forma que mudanças para pior ou para melhor são sempre possíveis.

Este potencial contínuo para mudanças significa que a pessoa pode tornar-se vulnerável a qualquer momento da vida a alguma possível adversidade e que também é, a qualquer momento da vida, permeável a influências favoráveis. É este potencial persistente para mudanças que nos dá oportunidade para uma terapia eficaz.

Conferência 8 ✓

Apego, comunicação e o processo terapêutico

Na segunda parte de minha conferência, em Maudsley, em 1976, "Formação e Rompimento dos Laços Afetivos" (1977), descrevi algumas das minhas idéias sobre as implicações terapêuticas da teoria do apego. Muito do que foi aprendido desde então fortaleceu minha confiança nesta abordagem. O presente texto, portanto, pode ser considerado como uma ampliação do anterior. Neste, dou uma atenção mais detalhada à maneira como as experiências iniciais dos pacientes afetam a relação transferencial e discuto mais profundamente o objetivo do terapeuta como sendo o de capacitar seu paciente a reconstruir os modelos funcionais de si mesmo e de sua(s) figura(s) de apego, de forma que ele se submeta menos à magia das tristezas esquecidas e fique mais capacitado a reconhecer companheiros, no presente, pelo que eles são.

*aquilo que não foi compreendido
inevitavelmente reaparece; como um fantasma
que não pode descansar até que o mistério
tenha sido resolvido e o encanto quebrado.*

Sigmund Freud, 1909

*Aqueles que não podem se lembrar do passado
estão condenados a repeti-lo.*

George Santayana, 1905

Cinco tarefas terapêuticas

A teoria do desenvolvimento da personalidade e psicopatologia esboçada anteriormente pode ser usada como uma estrutura para guiar cada uma das três formas principais de psicoterapia analítica, usadas hoje em dia — terapia individual, terapia de família e terapia de grupo. Eu, aqui, lido somente com a primeira.

Um terapeuta que usa a teoria do apego vê seu papel como sendo o de oferecer as condições nas quais seu paciente pode explorar seus modelos representacionais de si mesmo e de suas figuras de apego, com o objetivo de reavaliá-los e reestruturá-los à luz da nova compreensão que ele agora tem e da nova experiência vivida na relação terapêutica. Ao ajudar seu paciente neste sentido, o papel do terapeuta pode ser descrito em cinco tópicos principais.

O primeiro é oferecer ao paciente uma base segura, a partir da qual ele possa explorar os diversos aspectos infelizes e dolorosos de sua vida passada e presente, muitos dos quais ele considera difíceis ou talvez impossíveis de serem pensados ou reconsiderados, sem um companheiro confiável, que ofereça suporte, coragem, simpatia e, quando necessário, orientação.

O segundo é assistir o paciente em suas explorações, encorajando-o a considerar: as formas nas quais ele se engaja nas relações com figuras significativas de sua vida; quais as expectativas acerca de seus sentimentos e comportamentos dos outros; quais as tendências inconscientes que ele pode estar trazendo, quando seleciona a pessoa com a qual ele espera estabelecer uma relação íntima e quando cria situações que podem acabar mal para ele.

Uma relação especial, que o terapeuta encoraja seu paciente a examinar, constitui o terceiro tópico — a relação estabelecida entre os dois. Nesta relação o paciente vai trazer todas aquelas percepções, construções e expectativas de como uma figura de apego tende a sentir e a se comportar em relação a ele, que os seus modelos funcionais dos pais e de si determinam.

O quarto tópico é encorajar o paciente a considerar como as suas percepções, expectativas, sentimentos e ações atuais podem ser o produto tanto de eventos e situações que ele vivenciou durante sua infância e adolescência, especialmente aqueles com seus pais, quanto um produto daquilo que ele pode ter, repetidamente, ouvido deles. Esse processo é, freqüentemente, doloroso e difícil e requer do terapeuta que permita que seu paciente considere como possibilidades as idéias e os sentimentos em relação a seus pais que ele, até então, considerava inimagináveis e impensáveis. Ao fazê-lo, o paciente pode achar-se movido por fortes emoções e urgências de ação, algumas dirigidas a seus pais e outras ao terapeuta, algumas das quais ele considera assustadoras e/ou estranhas e inaceitáveis.

A quinta tarefa do terapeuta é capacitar seu paciente a reconhecer que suas imagens (modelos) de si e dos outros, derivadas de experiências dolorosas

do passado ou de mensagens enganadoras emitidas por seus pais, que na literatura são erradamente rotuladas de "fantasias", podem ou não ser apropriadas para seu presente e seu futuro ou, na verdade, podem nunca ter sido justificadas. Uma vez que ele tenha compreendido a natureza das imagens (modelos) que o governam e descoberto suas origens, pode começar a compreender o que o levou a ver o mundo e a ele mesmo da forma como o faz e sentir, pensar e agir dessa forma. Ele está, então, na posição de refletir sobre a precisão e adequação daquelas imagens (modelos) e sobre as idéias e ações a que elas levam, sob a luz de suas experiências atuais, com pessoas emocionalmente significativas, incluindo o terapeuta, assim como seus pais e ele mesmo, em relação a cada um deles. Uma vez que o processo tenha se iniciado, ele começa a ver as velhas imagens (modelos) da forma como são, como produtos razoáveis de suas experiências passadas ou daquilo que foi repetidamente dito a ele, e, então, sentir-se-á livre para imaginar alternativas melhor adaptadas à sua vida atual. Dessa forma, o terapeuta espera capacitar seu paciente a parar de sentir-se um escravo de estereótipos velhos e inconscientes e a sentir, pensar e agir de formas novas.

Os leitores poderão perceber que os princípios apresentados aqui têm muito em comum com os princípios descritos por outros psicoterapeutas, analiticamente treinados, que consideram os conflitos que surgem das relações interpessoais como a chave para a compreensão dos problemas de seus pacientes, que focalizam a transferência e que também dão algum peso, embora com variações de grau, às experiências iniciais do paciente com seus pais. Entre os famosos nomes que poderiam ser citados neste contexto estão os de Fairbairn, Winnicott e Guntrip, na Grã-Bretanha, e Sullivan-Fromm-Reichmann, Gill e Kohut, nos Estados Unidos. Entre os trabalhos recentemente publicados, que contêm muitas das idéias prescritas aqui, estão os de Peterfreund (1983), Casement (1985), Pine (1985) e Strupp e Binder (1984) e, também, os de Malan (1973) e Horowitz et al. (1984) no campo da psicoterapia breve. Particularmente, desejo chamar atenção sobre as idéias de Horowitz e seus colegas que, em sua descrição do tratamento de pacientes sofrendo de uma síndrome de stress aguda, empregam uma estrutura conceitual bastante semelhante à que é apresentada aqui. Embora a técnica utilizada por eles tenha como objetivo ajudar os pacientes a se recuperarem dos efeitos de acontecimentos recentes bastante estressantes, creio que os princípios de seus trabalhos sejam igualmente aplicáveis a ajudar os pacientes a se recuperarem dos efeitos de uma perturbação crônica, resultante de eventos estressantes dos anos passados, incluindo aqueles que ocorreram nos primeiros anos de vida.

Embora nesta exposição seja conveniente listar as cinco tarefas do terapeuta, de uma forma lógica, elas são tão inter-relacionadas que, na prática, uma sessão produtiva tende a envolver, primeiro, uma tarefa, depois outra. Entretanto, se o terapeuta não puder capacitar seu paciente a sentir

alguma quantidade de segurança, a terapia não pode nem começar. Então, começamos com o papel do terapeuta em oferecer uma base segura para seu paciente. Este papel é muito semelhante ao *holding*, descrito por Winnicott e ao *containing*, descrito por Bion.

Ao oferecer a seu paciente uma base segura, a partir da qual ele pode explorar e expressar seus pensamentos e sentimentos, o papel do terapeuta é análogo ao da mãe, que dá a seu filho uma base segura, a partir da qual ele pode explorar o mundo. O terapeuta luta para ser confiável, atento e oferecer, com simpatia, respostas às explorações de seus pacientes e, tanto quanto possível, ver e sentir o mundo pelos olhos deles, especialmente, irradiar empatia. Ao mesmo tempo, ele está ciente de que, por causa das experiências adversas do passado do paciente, ele pode não acreditar na confiabilidade do terapeuta, que se comporta de forma amável e que compreende os seus dilemas. Por outro lado, as respostas atenciosas e de empatia que, inesperadamente, o paciente recebe, levam-no a supor que o terapeuta irá supri-lo com todo cuidado e afeto que ele sempre quis ter e nunca teve. Em um caso, entretanto, o terapeuta é visto sob uma luz excessivamente crítica e hostil; no outro, como pronto para oferecer mais do que, de todas as formas, seria possível. À medida que ambos os tipos de mal-entendido e construção equivocada, e as emoções e comportamentos que nascem daí, são os traços centrais dos problemas dos pacientes, um terapeuta necessita ter um conhecimento bastante vasto das muitas formas que essas construções equivocadas podem assumir e, também, dos vários tipos de experiências iniciais que as podem ter provocado. Sem este conhecimento, um terapeuta estará pouco preparado para ver e sentir o mundo da maneira como seu paciente o faz.

Mesmo assim, a forma de o paciente construir sua relação com o terapeuta não é somente determinada pela história do paciente; ela também é determinada pela forma como o terapeuta o trata. Então, o terapeuta tem que estar sempre ciente da natureza de suas próprias contribuições para a relação que, entre outras influências, tende a refletir, de uma forma ou de outra, o que ele mesmo vivenciou em sua própria infância. Este aspecto da terapia, a contratransferência, é um assunto vasto em si e tema de farta literatura. Posto que não é possível lidar mais profundamente com isto aqui, gostaria de enfatizar não somente a importância da contratransferência, mas também que o foco da terapia deve ser sempre a interação do paciente com o terapeuta no aqui e agora, e que a única razão para encorajar o paciente, por vezes, a explorar seu passado é através da luz que é lançada em sua atual forma de sentir e lidar com a vida.

Tendo com firmeza essa condição em mente, consideremos algumas das formas mais comuns que uma construção errônea de um paciente pode assumir e como elas tendem a ter se originado. Este é o aspecto da terapia no qual o trabalho do terapeuta, que adota a teoria do apego, tende a diferir mais daquele que adota algumas das teorias tradicionais do desenvolvimento

da personalidade e psicopatologia. Então, por exemplo, um terapeuta que vê as percepções distorcidas e os mal-entendidos de seu paciente como um produto razoável daquilo que o paciente realmente vivenciou no passado ou daquilo que foi repetidas vezes dito a ele, difere muito daquele que vê as mesmas percepções distorcidas e mal-entendidos como rebentos irracionais de fantasias autônomas e inconscientes.

Eu me baseio, no que se segue, em muitas fontes de informações: estudos de epidemiologistas, estudos de psicólogos do desenvolvimento, já mencionados, observações feitas durante o curso de uma terapia familiar e nada menos do que tudo aquilo que aprendi de meus pacientes, daqueles que eu mesmo tratei e daqueles cuja terapia supervisionei.

As influências das primeiras experiências na relação transferencial

Freqüentemente, ocorre que o paciente fica bastante apreensivo, temendo que seu terapeuta o rejeite, critique ou humilhe. Já que sabemos muito bem que muitas crianças são tratadas dessa forma por um de seus pais, ou ambos, podemos ter uma razoável certeza de que foi essa a experiência de nossos pacientes. Caso seja provável que o paciente esteja ciente do que está sentindo e de como ele espera que o terapeuta o trate, o terapeuta deverá sinalizar que também ele está ciente disso. Quão mais cedo o terapeuta puder associar as expectativas do paciente às suas experiências com seus pais, no presente e no passado, vai depender do desejo do paciente de considerar aquela possibilidade ou, ao contrário, insistir que o tratamento de seus pais em relação a ele foi acima de crítica. Se a última situação prevalecer, teremos o problema principal de tentar compreender porque o paciente estaria insistindo em reter esse quadro favorável, quando as evidências disponíveis nos apontam para o fato deste quadro ser errôneo.

Acontece em algumas famílias que um dos pais insiste no fato de se considerar maravilhoso, que sempre fez todo o possível pela criança e que, se alguma desavença ocorre, a culpa é exclusivamente da criança. Essa atitude dos pais, freqüentemente, encobre um comportamento que, nos moldes tradicionais, está longe de ser perfeito. Ainda assim, se os pais insistem que deram constante afeto à criança e que ela possivelmente nasceu ruim e ingrata, a criança tem poucas opções além de aceitar esse quadro, apesar de estar ciente, em algum lugar em sua mente, de que este quadro é injusto.

Surge ainda uma outra complicação quando o paciente, em criança, foi submetido a fortíssimas instruções por parte de um dos pais, quanto a não contar a ninguém alguns acontecimentos que ocorreram na família. Tais acontecimentos são, freqüentemente, brigas nas quais os pais estão cientes de que seu comportamento estaria aberto a críticas; por exemplo, brigas

entre os pais, brigas entre um dos pais e a criança, durante as quais coisas horríveis foram ditas ou feitas. Quanto mais o terapeuta insistir, que o paciente conte tudo, maior é o dilema que se cria para ele. Essas ordens de silêncio em família não são incomuns e foram muito negligenciadas enquanto fontes daquilo que, tradicionalmente, foi chamado de resistência. É muito útil para o terapeuta perguntar ao paciente se ele foi alvo de tal tipo de pressão e se aconteceu, ajudá-lo a resolver esse dilema.

Até agora levamos em consideração os casos em que os pacientes, em algum grau, estavam cientes de suas expectativas quanto a serem rejeitados, que o paciente dê a impressão de que está totalmente inconsciente desses sentimentos, apesar de sua atitude para com o terapeuta exalar desconfiança e evitação. As evidências nos mostram que esses estados ocorrem especialmente naqueles que, tendo desenvolvido um modelo de apego ansioso e de evitação durante os primeiros anos, lutaram muito, desde então, para serem emocionalmente autocontrolados e protegidos contra contatos íntimos com outras pessoas. Estes pacientes, que são freqüentemente descritos como sendo narcisistas ou como tendo *false-self*, evitam a terapia o mais que podem e, caso aceitem fazer, mantêm o terapeuta a distância. Alguns, se for permitido, falam incessantemente sobre toda e qualquer coisa, exceto de relações emocionalmente intensas, passadas ou presentes. Outros dirão que não têm nada para falar. Um jovem, cujos movimentos indicavam uma total desconfiança de mim, passou o tempo exibindo suas explorações delinquentes, sendo algumas delas, creio eu, fictícias, e esbanjando escárnio, como ele dizia, sobre minha vida monótona e estreita. Tratar pessoas tão profundamente desconfiadas foi comparado, muitos anos atrás, por Adrian Stephen (1934) a tentar fazer amizade com um pônei assustado e tímido; as duas situações requerem uma paciência prolongada, amiga e calma. Somente quando o terapeuta estiver ciente das constantes rejeições, que seu paciente possivelmente foi sujeito enquanto criança ao procurar conforto ou ajuda e do seu terror de ser sujeito a qualquer coisa semelhante por parte do terapeuta, poderá ver a situação entre eles como o paciente vê.

Uma outra causa, e bastante diferente, da cautela do paciente em relação a qualquer contato mais próximo com o terapeuta é o temor de que o terapeuta o coloque numa situação onde a relação objetive mais os interesses do terapeuta do que os dele. A origem mais comum de tais temores é uma infância na qual um dos pais, quase sempre a mãe, procurou fazer da criança sua própria figura de apego e de cuidado, quer dizer, invertendo a relação. Com muita freqüência, isto é feito inconscientemente, usando técnicas que para um observador desinformado podem parecer uma superindulgência, mas que realmente "subornam" uma criança a se manter no papel de protetora.

Não é incomum que um paciente, durante a terapia, oscile entre tratar o terapeuta como se ele fosse um de seus pais e comportar-se em relação a

ele de forma como seus pais o trataram. Por exemplo, um paciente que foi sujeito a ameaças hostis, enquanto criança, pode usar ameaças hostis com seu terapeuta. Experiências de escárnio, de um dos pais, podem ser revividas como escárnio do terapeuta. A abordagem sexual, por parte de um dos pais, pode reaparecer como abordagem sexualizada do terapeuta. Tal comportamento pode ser compreendido da seguinte forma: durante a infância, uma pessoa aprende duas formas principais de comportamento e, em sua mente, constrói dois tipos principais de modelos. Uma das formas de comportamento, sem dúvida, é aquela em que a criança, ela mesma, interage com cada um dos pais. Os modelos funcionais correspondentes são aqueles dela mesma, enquanto criança, em interação com cada um de seus pais. A outra forma de comportamento é a dos pais interagindo com a criança. Os modelos correspondentes, que ela constrói, são os de cada um dos pais em interação com ela. Portanto, sempre que o terapeuta se encontrar confuso ou ressentido, pela forma com que está sendo tratado pelo paciente, deverá ser sábio o suficiente para investigar quando e por quem o paciente pode ter aprendido aquela forma de tratar outras pessoas. Quase sempre foi com um de seus pais.*

Com alguns pacientes, a relação terapêutica ocorre de forma que a ansiedade, a desconfiança, a crítica e, algumas vezes, a raiva e o escárnio são predominantes e óbvios, e o terapeuta é visto em cores escuras. Sentimentos de gratidão, pelos esforços do terapeuta ou respeito por sua competência, estão notadamente ausentes. A tarefa, então, é ajudar o paciente a compreender que muito de seu ressentimento presente provém de maus-tratos passados nas mãos de outros e que, embora o resultado possa ser a compreensão de sua raiva, continuar lutando batalhas antigas é improdutivo. Aceitar que um passado infeliz não pode ser modificado é, freqüentemente, muito amargo.

Com outros pacientes, a situação é inversa; a gratidão é demonstrada, a admiração e o afeto são prontamente expressos na relação transferencial e o terapeuta é visto numa aura de perfeição. A insatisfação e a crítica estão notadamente ausentes e a raiva em relação às falhas do terapeuta, especialmente as ausências, são inimagináveis. Tal idealização do terapeuta decorre, em parte, creio eu, de esperanças irreais e de expectativas quanto ao que o terapeuta pode e deseja oferecer e, em parte, de uma infância onde a crítica a um dos pais é proibida e a obediência reforçada por alguma técnica de indução de culpa ou, talvez, por sanções, tais como ameaças de deixar de amar ou mesmo de abandonar a criança. Com este tipo de experiência infantil, o paciente assume, inconscientemente, que o terapeuta esperará

* Na teoria tradicional essa mudança de papel pelo paciente tende a ser denominada um caso de identificação com o agressor.

dele o mesmo grau de obediência que seus pais haviam esperado e reforçará isto por técnicas ou por ameaças semelhantes àsquelas usadas por eles.

Infelizmente, existe, em alguns lugares, uma tendência para confundir a teoria apresentada aqui, que considera a forma como certos pais tratam seus filhos como sendo a maior causa de doenças mentais, com uma atitude que simplesmente acusa os pais. Ninguém, que trabalhe no campo da psiquiatria infantil e terapia de família, pode cometer este erro. Ao contrário, como foi dito há muito tempo, foi plenamente reconhecido que o comportamento mal-orientado dos pais é, freqüentemente, o produto de suas próprias dificuldades e infâncias infelizes. Como resultado, muito tempo foi dedicado em ajudar os pais a escapar das influências adversas de suas próprias infâncias.

Além disso, durante o tratamento de uma pessoa (de qualquer idade), que sofreu nas mãos de seus pais, o terapeuta, aceitando o relato de seu paciente, evita julgamentos morais. Ao contrário, sempre que surgir uma oportunidade, ele deverá encorajar seu paciente a considerar como e porque um de seus pais, o que está em discussão, sempre se comportou daquela forma. Ao levantar essas questões, é sempre útil para o terapeuta questionar o paciente sobre o que ele sabe das experiências infantis que o pai/mãe em questão pode ter tido. Não é incomum que isso o leve a obter alguma compreensão sobre como as coisas de desenvolveram e, ao compreender, se mobilizar no sentido de perdoar e se reconciliar. Em sessões de família, isso pode ser especialmente válido, se um dos pais puder ser encorajado a fazer um relato de sua infância. Isso possibilitará a todos os presentes - o pai, a mãe, o companheiro, os filhos e o terapeuta — a terem algum *insight* sobre como e porque a vida familiar se desenvolveu daquela forma e como cada membro pode ajudar a melhorá-la. Como já foi mencionado, essa tendência forte de os problemas de apego serem transmitidos através das gerações pela influência, no comportamento dos pais, dos problemas de relacionamento advindos da infância desses pais, vem, finalmente, recebendo a atenção que merece nas pesquisas.

Algumas situações e eventos patogênicos da infância

Creio que um terapeuta pode não estar muito bem informado sobre as relações obscuras e distorcidas que podem ocorrer em algumas famílias, assim como as coisas terríveis que podem acontecer em outras, porque somente estando assim tão bem informado, ele poderá ter uma idéia razoavelmente clara daquilo que, provavelmente, está por trás das defesas do paciente ou das origens de sua ansiedade, raiva e culpa. Uma vez que esteja adequadamente informado, ele estará bem posicionado, não só para apreciar a verdade daquilo que o paciente está descrevendo como tendo acontecido a

ele como, também, introduzir, como hipótese, alguns dos tipos de situações que o paciente pode ter sido exposto, mas que pode não estar habilitado ou desejoso de a elas se referir. Ao enumerar as situações que se seguem, não estou fazendo mais do que indicar algumas que são comuns, mas que, até recentemente, foram negligenciadas na literatura psicoterapêutica.*

Ameaças de não amar uma criança como forma de controle

É comum para uma mãe dizer a seu filho que ela não mais o amará se ele se comportar dessa ou daquela forma. Isso significa que a mãe está ameaçando de não mais oferecer afeto ou conforto em momentos que a criança está preocupada, amedrontada ou ansiosa e não oferecer ajuda ou encorajamento em outros momentos. Se tais ameaças forem usadas sistematicamente por um dos pais, ou ambos, a criança, inevitavelmente, crescerá intensamente ansiosa em agradar e com tendência à culpa.

Ameaças de abandonar uma criança

As ameaças de abandonar a criança são muito mais assustadoras do que as ameaças de não mais amá-la. Isto fica muito aumentado se um dos pais "cumpre" a ameaça, talvez desaparecendo por algumas horas ou fazendo a mala da criança e andando com ela pela rua, supostamente indo para uma casa para "meninos maus". Já que as ameaças de abandono frequentemente tomam uma forma altamente idiossincrática, o paciente pode negar que tenha sido sujeito a elas. Em tais casos, a verdade pode surgir junto com a emoção que a acompanha, quando a forma especial na qual a ameaça foi feita for lembrada. Um exemplo é o da mãe que inventou uma história de que um caminhão amarelo iria aparecer e levar o filho embora. Um outro, é o do pai cuja história era de que sua filha seria enviada para uma escola numa montanha distante, circundada por tubarões (Marrone, 1984). Assim, no primeiro caso, tudo o que a mãe precisava falar era: "Bem, o caminhão amarelo vai chegar..." e, no segundo, o pai dizer: "Bem, você irá para a escola da montanha", para que a criança, instantaneamente, desistisse do que quer que estivesse fazendo. Num terceiro caso, a palavra era "margarina"; a mãe havia associado a ameaça de mandar seu filho embora para uma casa de crianças, com a insistência de que lá ela teria que comer

* Já que em publicações anteriores dei suficiente atenção aos efeitos nocivos da privação e de separações prolongadas no desenvolvimento da personalidade, tais temas serão aqui omitidos.

margarina. Para tais pacientes, uma afirmativa geral do tipo "ameaça de abandono" não surtia efeito. Somente quando a palavra chave era desenterada, o medo original surgia e a fonte da ansiedade de separação era, então, localizada.

Ameaças de cometer suicídio

Às vezes, um pai/mãe, em desespero, ameaça cometer o suicídio, se uma situação angustiante continuar. Isto pode ocorrer durante uma discussão entre os pais, que a criança ouve, ou pode ser dirigido diretamente à criança. Em qualquer dos casos, a ameaça é aterrorizante. Uma lição a ser aprendida de tais casos é que, sempre que o paciente se refere a seus pais como tendo brigado, o terapeuta deve sempre questionar: "O que eles diziam um ao outro?". Não é raro que o paciente fique paralisado com essa pergunta. Num rasgo de mau-humor, os pais que brigam podem dizer coisas horrorosas um ao outro. Isto é suficientemente ruim. Pior ainda é quando, depois de se acalmarem, eles negam terem dito tais coisas.

Negativas e não confirmações

Exemplos de negativas por parte de um dos pais, acerca do que disseram ou fizeram e esforços persistentes para não confirmar o que a criança viu ou ouviu, então detalhados na Conferência 6, assim como estão enfatizados os efeitos adversos de tais pressões no desenvolvimento da personalidade. Durante a terapia, esses efeitos surgem como grande incerteza do paciente se o episódio familiar ocorreu ou não e culpa de ter trazido este assunto à tona, mesmo que de forma vaga. Aqui, como sempre, o papel chave do terapeuta é o de permitir ao paciente a exploração das várias possibilidades, tanto as favoráveis a seus pais quanto as desfavoráveis, e encorajá-lo a avaliar as evidências disponíveis, enquanto o terapeuta deve permanecer com a mente totalmente aberta em relação a onde a verdade pode estar.

Até agora, nesta exposição, não considere o assunto crítico de até que ponto nós podemos e devemos crer na validade dos relatórios de nossos pacientes. Certamente, as memórias são falíveis e existem ocasiões em que um terapeuta experiente vai, diretamente, questionar a verdade daquilo que o paciente está dizendo. Então, quais são os critérios pelos quais devemos julgar?

Em primeiro lugar, generalizações amplas sobre como foram os pais e o tipo de cuidados recebidos não devem receber crédito, a menos e até que recebam suporte de exemplos detalhados de como cada um tratou o paciente, enquanto criança, em situações especiais. Por exemplo, o relato favorável

de uma mãe maravilhosa pode muito bem deixar de receber suporte, quando os detalhes estiverem disponíveis. Relatos válidos de paternagem afetiva não só oferecem muitos detalhes favoráveis como, também, tendem a estar interligados com críticas ocasionais, de forma que o pai e a mãe podem ser melhor vistos. De forma similar, relatos disparatados de pais, em termos uniformemente adversos, necessitam de um exame mais detalhado. Relatos não válidos, de qualquer dos tipos, tendem a ser devastadores e extremados demais para serem verdadeiros. Os detalhes, normalmente, ou faltam, se forem dados, ou variam muito em relação ao quadro apresentado. Em contraste, sempre que muitos detalhes consistentes são dados e o quadro que surge está em conformidade com aquilo que sabemos de outras fontes, com outras famílias e, também, com antecedentes conhecidos dos tipos de problemas que afligem os pacientes, é um absurdo duvidar de sua validade final, mesmo que alguns pontos permaneçam em aberto.

A origem desses extremos é freqüentemente pressão externa. Por exemplo, um pai que insiste que seu filho tome o seu partido contra o outro cônjuge, que está sendo representado como o mau. Ou mesmo, um pai que tem muitas falhas e insiste que está acima de qualquer crítica.

Uma ocasião em que o terapeuta está certo em duvidar da história de seu paciente é quando existe uma razão para suspeitar que o paciente é um mentiroso patológico. Tais casos são comparativamente raros e, por essa razão, passam quase que despercebidos. Mais cedo ou mais tarde, entretanto, com a crescente quantidade de improbabilidades e inconsistências, assim como pela forma de o paciente contar a história, engendra-se, primeiro, a dúvida e, depois, a certeza de que o paciente não merece crédito.

Fora estas exceções, acredito que os relatos dos pacientes são suficientemente confiáveis e que o terapeuta deve aceitá-los como sendo razoáveis aproximações da verdade;* além disso, é antiterapêutico não fazê-lo. Questionar constantemente a validade da história dos pacientes, mesmo que só por sugestão, e insistir no papel distorcido da fantasia e da imaginação, é o reverso da empatia. Isso dá ao paciente a idéia de que o terapeuta não o compreende e pode mesmo acabar por convencê-lo de que o terapeuta está se comportando exatamente da forma como os pais haviam previsto. Alguns pais, tendo insistido que seu filho não contasse alguma coisa da qual eles estavam envergonhados, podem ter dito que, de qualquer forma, caso ele o fizesse, ninguém acreditaria.

Entre os vários eventos e situações adversas, até agora não mencionados nesta conferência, e que o terapeuta deve ter em mente como sendo prováveis de terem ocorrido na vida do paciente, estão os seguintes:

* Para propósitos de pesquisa, no entanto, os critérios para aceitação de informações retrospectivas como válidas têm que ser os mais rígidos.

uma criança pode não ter sido desejada por um de seus pais ou pelos dois;

uma criança pode ser do sexo oposto ao que os pais haviam desejado;

uma criança pode ter se tornado a válvula de escape da família, algumas vezes como resultado de uma tragédia familiar que, com maior ou menor plausibilidade, foi atribuída a ela;

um pai pode ter usado técnicas de indução de culpa para controlar a criança, por exemplo, reclamações freqüentes de que o comportamento da criança fazia a mãe adoecer;

um pai pode ter procurado fazer de um de seus filhos sua figura de apego ao desencorajá-lo a explorar o mundo para longe dele e a crer que o filho estará sempre capacitado para escolher seu caminho sozinho;

o papel não usual de uma criança na família pode ser o resultado de sua mãe ter tido um *affair* extraconjugal durante seu casamento, de forma que seu pai putativo não seja seu pai real;

uma outra causa do papel pouco usual da criança é quando um ou outro pai identifica a criança com um parente, freqüentemente com um dos avós da criança, com o qual ele/ela teve uma relação difícil e que é, então, revivida nessa relação com a criança;

uma criança pode ter sido alvo de abusos físicos mais ou menos sérios de um dos pais ou de algum padastro;

a criança pode ter sido envolvida em abuso sexual por parte de um dos pais, padastro ou irmãos mais velhos, por períodos curtos ou longos de tempo.

Para aqueles que não estão cientes dos efeitos mais comuns no desenvolvimento da personalidade da exposição a situações desse tipo, um certo número de referências é dado no apêndice à bibliografia.

Inevitavelmente, os eventos influentes nos dois ou três primeiros anos de vida de um indivíduo nunca serão registrados em sua memória ou não poderão, agora, ser lembrados. Aqui, certamente, o melhor que o terapeuta tem a fazer é inferir, com base na situação de transferência e nas informações que o paciente, com dificuldade, ofereceu sobre seus anos iniciais, combinado com o vasto conhecimento sobre desenvolvimento da personalidade que adquiriu, qual a possível natureza de tais eventos. Em outras

palavras, ele opta pela reconstrução; porém, ao fazê-lo, ele poderá, no futuro, contar com um conhecimento muito maior e mais confiável sobre as influências familiares no desenvolvimento da personalidade do que tradicionalmente esteve disponível aos psicoterapeutas treinados.

A postura do terapeuta

Respeitando esses princípios terapêuticos, os terapeutas reconhecerão muito do que há tempo lhes é familiar, embora frequentemente conhecido por outro nome. A aliança terapêutica aparece como uma base segura, um objeto interno assim como é o modelo representacional ou funcional de uma figura de apego, como uma reconstrução a partir da exploração de memórias do passado, como resistência (algumas vezes) ou profunda relutância em desobedecer as ordens antigas dos pais no que diz respeito a não contar ou não lembrar. Um aspecto diferente está na maior ênfase colocada no papel do terapeuta como um companheiro do paciente nas explorações de si mesmo e de suas experiências e menos nas interpretações do terapeuta. Enquanto alguns terapeutas tradicionais podem ser descritos como adotando uma postura: "Eu sei, vou dizer a você", eu defendo a posturas do "Você sabe, você vai me dizer". Desta forma, o paciente é encorajado a acreditar que com ajuda e orientação ocasional, ele poderá descobrir por si só a verdadeira natureza do que subjaz em seus pensamentos, sentimentos e ações e que, ao examinar a natureza das suas experiências iniciais com seus pais ou pais substitutos, ele compreenderá o que o levou a construir os modelos agora ativos nele e, dessa forma, sentir-se livre para reestruturá-los. Felizmente, o psiquismo humano, assim como os ossos humanos, está fortemente inclinado à autocura. O trabalho do psicoterapeuta, assim como o do ortopedista, é oferecer as condições nas quais a autocura possa ocorrer da melhor maneira.

Entre aqueles que, recentemente, ofereceram relatórios detalhados sobre o valor especial de adotar uma abordagem modesta e atraente estão Peterfreund (1983) e Casement (1985).

Nas descrições já citadas, o papel do terapeuta tem sido comparado ao da mãe, que oferece a seu filho uma base segura a partir da qual ele pode explorar. Em primeiro lugar, isso quer dizer que o terapeuta aceita e respeita seu paciente de forma plena, como um ser humano companheiro, que está com problemas e sua maior preocupação é promover o bem-estar de seu paciente, por todos os meios que lhe estão disponíveis. Com essa finalidade, o terapeuta luta para ser confiável, atento, empático e oferecer respostas simpáticas, assim como encorajar seu paciente a explorar o mundo de seus pensamentos, sentimentos e ações, não só no presente, mas, também, no passado. Embora encoraje sempre seu paciente a tomar a iniciativa, o terapeuta

não é, de modo algum, passivo. Por um lado, ele tenta estar atento e oferecer respostas sensíveis; por outro lado, ele reconhece que existem momentos em que ele mesmo deve tomar a iniciativa. Por exemplo, quando um paciente passa o tempo falando sobre tudo e qualquer coisa, exceto sobre seus pensamentos e sentimentos em relação às pessoas, será necessário chamar sua atenção para sua evitação nessa área e, talvez, para sua profunda desconfiança quanto aos esforços do terapeuta no sentido de ajudá-lo ou mesmo quanto à sua capacidade de manter um segredo. Com um outro paciente, que talvez esteja muito desejoso de explorar suas memórias da infância, existirão muitas ocasiões em que o terapeuta poderá, de forma útil, perguntar por maiores detalhes ou levantar questões sobre situações da infância que o paciente, até então, não tinha feito referências diretas, mas que parecem possibilidades plausíveis à luz daquilo que ele mesmo vem descrevendo e à luz daqueles problemas particulares que o paciente vem sofrendo. Além disso, ao fazê-lo, o terapeuta nunca pode esquecer que seu paciente ainda pode estar muito influenciado pelas instruções de seus pais, de não saber coisas que ele não deve saber e de não vivenciar sentimentos que não se espera que ele vivencie.

Uma interrupção na terapia sempre gera algumas reações no paciente; algumas vezes conscientes, outras inconscientes, mas, no entanto, evidentes. Quando consciente, ela pode tomar a forma de uma reclamação aberta ou de um protesto raivoso; quando inconsciente, pode se manifestar pela demonstração de um certo deboche acerca da terapia ou mesmo faltando a uma ou duas sessões antes da interrupção. A forma de o terapeuta avaliar essas reações e as respostas que dará refletirão sua posição teórica. Quem adota a teoria do apego respeita o sofrimento ou a raiva de seu paciente sobre a separação e reconhece as mesmas como respostas naturais de alguém que se tornou apegado a uma pessoa — respeito que está implícito em tudo que diz ou faz. Ao mesmo tempo, ele dá atenção à forma como o paciente reage. Se o sofrimento e a raiva forem expressos abertamente, o terapeuta mostrar-se-á simpático e capaz de aliviar o sofrimento de seu paciente, dando a ele informações de como poderá se comunicar durante as interrupções. Além disso, o terapeuta considerará como o paciente está elaborando a interrupção e, caso haja evidências de má construção, ele tentará descobrir como ela pode ter se originado. Se, por exemplo, o paciente está apreensivo sobre se o terapeuta irá ou não retornar, a possibilidade de ter sido exposto a ameaças de abandono por parte dos pais pode ser explorada. Caso a interrupção ocorra devido ao fato de o terapeuta não estar bem, ele deve ficar alerta para a possibilidade de o paciente estar apreensivo quanto a ter feito ou dito alguma coisa que tenha sido a responsável. Se for este o caso, o terapeuta deverá explorar a possibilidade de um dos pais do paciente ter tentado controlá-lo dizendo que a forma como ele se comportava estava fazendo a mãe ou o pai ficarem doentes.

De forma semelhante, se o paciente reage à interrupção com deboche ou faltando às sessões, o terapeuta que adota a teoria do apego se perguntará por que seu paciente teme expressar seus sentimentos abertamente e que experiências infantis poderiam justificar sua desconfiança.

É provável que a descrição que acabei de dar sobre a forma de um terapeuta responder às reações de seu paciente, no que se refere à interrupção, contraste com a do terapeuta que adota e aplica uma ou outra das teorias psicanalíticas tradicionais. Por exemplo, um terapeuta pode considerar as reações de seu paciente como sendo infantis e como se indicassem uma fixação na fase oral ou simbiótica. O que o terapeuta então dirá e, especialmente, a forma como irá dizê-lo, pode ser vivenciado pelo paciente como falta de respeito pelos seus sentimentos de apego, ansiedade ou raiva. Aqui, outra vez, pode ocorrer o perigo de o terapeuta parecer estar respondendo de forma fria e pouco simpática e de forma muito semelhante a um dos pais do paciente. Se for este o caso, a relação seria antiterapêutica.

O quanto o terapeuta poderá, inteligentemente, ir de encontro aos desejos do paciente de manter a comunicação durante a interrupção, por exemplo, por telefone, e confortá-lo quando angustiado, durante a sessão, depende de muitos fatores pessoais da relação entre eles. Por um lado, existe o perigo de o terapeuta parecer faltar com compreensão pelas ansiedades do paciente ou mesmo parecer oferecer mais do que está preparado para dar. Existem ocasiões em que seria desumano não permitir que um paciente angustiado estabelecesse alguma forma de contato físico; os papéis são, então, explicitamente, de confortador e confortado. Ainda assim, existe sempre o perigo de o contato físico provocar sentimentos sexualizados, especialmente quando os sexos são diferentes. Dependendo da situação, cada terapeuta pode tomar sua própria decisão e estabelecer suas próprias linhas. Quanto mais alerta o terapeuta estiver no que concerne a tais traços, mais capacitado estará para evitar conseqüências desastrosas.

Comunicações emocionais e reconstruções de modelos funcionais

Quando o terapeuta utiliza o tipo de técnica defendida aqui pode acontecer, às vezes, de a terapia entrar num esquema onde o paciente persiste, ininterruptamente, em descrever o terrível período que passou quando criança e como seus pais o tratavam mal, sem que nenhum progresso ocorra. A causa de tal perseveração, suspeito eu, é que o paciente está convencido de que o terapeuta não aceita a verdade do que está dizendo, apesar de repetir tanto essas histórias. Isto pode ser devido ao fato de o paciente ter sido sempre ridicularizado no passado por todos a quem contava a história ou, talvez, mais freqüentemente, pelo terapeuta ter indicado ceticismo

ou descrença. Isso pode ser feito de muitas formas: pelo tom de voz, questionando os detalhes, fracassando em dar um peso especial ao que o paciente descreveu.

Evidentemente, quando o problema está na incredulidade do terapeuta, a saída é deixar claro que ele sabe muito bem que tais coisas realmente acontecem com crianças e que não tem motivos para duvidar dos relatos de seu paciente. Mesmo assim, o impasse pode continuar, a história é contada e recontada de forma cínica e sem nenhuma demonstração de sentimento.

Essa situação foi discutida por Selma Fraiberg que, junto com sua equipe, iniciou uma ajuda a mães vulneráveis em vias de negligenciar ou abusar de seus filhos (Fraiberg, Adelson e Shapiro, 1975). Eles descrevem as visitas às casas de duas dessas mães, onde ouviram delas histórias angustiantes. Ambas contaram histórias de muita crueldade durante a infância, tendo sido sujeitas a violentos espancamentos, trancadas do lado de fora de suas casas no frio, freqüentemente abandonadas pelas mães, transferidas de um lugar para outro e não tendo ninguém a quem recorrer para pedir auxílio e conforto. Nenhuma das duas deu nenhuma pista de como teria se sentido, muito menos do que elas gostariam de ter feito. Uma delas, uma menina de dezesséis anos que evitava tocar ou segurar seu bebê (que gritava desesperadamente), insistia: "Mas de que adianta falar? Sempre guardei as coisas para mim. Quero esquecer. Não quero pensar". Foi este o ponto em que o terapeuta interveio — por ela ter expresso os sentimentos, que toda e qualquer criança parece ter em situações como as descritas: quão amedrontada, zangada, desesperada uma pessoa se sentiria e, também, como uma pessoa esperaria ter alguém que a compreendesse e oferecesse conforto e proteção. Ao fazê-lo, o terapeuta não só demonstrou uma compreensão de como a paciente deve ter sentido, como comunicou, à sua maneira, que a expressão de tal sentimento e desejo encontraria resposta simpática e reconfortante. Somente, então, foi possível à jovem mãe expressar toda sua dor, lágrimas e "a inexplicável angústia de si mesma, enquanto uma criança abandonada", que ela sempre sentiu, mas nunca ousara expressar.

No que se refere aos métodos de Fraiberg de ajudar o paciente a expressar as emoções que não ousa mostrar, eu, deliberadamente, enfatizei a união entre emoção e ação. O fracasso em demonstrar as emoções se deve, em grande escala, ao medo inconsciente de que a ação cuja emoção acompanha leve a um resultado ruim. Em muitas famílias, a raiva por um adulto pode levar a uma punição que pode, às vezes, ser severa. Além disso, um apelo por conforto e ajuda pode levar à rejeição e humilhação. É, talvez, freqüentemente esquecido pelos clínicos que muitas crianças quando ficam angustiadas e chorosas, buscando conforto, são colocadas de lado, consideradas "intoleráveis bebês-chorões". Ao invés do conforto oferecido por pais compreensivos e afetivos, essas crianças se defrontam com uma indiferença

crítica e pouco simpática. Não é de se espantar, que caso esse modelo prevaleça durante a infância, a criança aprenda a nunca mostrar angústia ou procurar conforto e, caso se submeta à terapia, assuma que o terapeuta também se mostrará tão intolerante em relação à sua raiva e às suas lágrimas como seus pais o foram.

Todos os terapeutas, que adotam uma perspectiva psicanalítica, já reconheceram que, para ser eficaz, a terapia requer que o paciente não só fale de suas memórias, idéias e sonhos, de seus desejos e esperanças, mas, também, expresse seus sentimentos. A discussão sobre a técnica de Fraiberg, para ajudar a jovem paciente cínica e fria a descobrir a profundidade de seus sentimentos e expressá-los livremente ao seu terapeuta, é, portanto, uma boa observação aqui.

Ao escrever esta conferência, estive bastante ciente de que ao usar termos tais como "informação", "comunicação" e "modelos funcionais" seria muito fácil para um leitor descuidado supor que estes termos pertencem a uma psicologia que se ocupa somente com a cognição e muito pouco com os sentimentos e a ação. Embora tenha sido comum, por muitos anos, os psicólogos cognitivos omitirem qualquer referência à emoção, agora é bastante reconhecido que fazê-lo é muito artificial e pouco frutífero (Hinde, Perret-Clermont e Stevenson-Hinde, 1985). De fato, não existem comunicações mais importantes do que as estabelecidas entre um ser humano e outro, expressas emocionalmente, e nenhuma informação é mais vital para a construção e reconstrução de modelos funcionais do *self* e dos outros do que a informação sobre o que cada um sente em relação ao outro. Durante os primeiros anos de vida, na verdade, a expressão emocional e a sua recepção são os únicos meios de comunicação que temos, de forma que as bases dos nossos modelos funcionais do *self* e das figuras de apego são necessariamente estabelecidas através das informações provenientes desta fonte. Não é de surpreender, portanto, que ao rever suas relações de apego durante o curso da terapia e reconstruir seus modelos funcionais, a comunicação emocional entre paciente e terapeuta representa a parte mais importante.

10/4/03

Índice de Assuntos

- abuso infantil 29-31,47,87-96,114-15
- adolescentes 18,19,25-6,50,69-70,86-7,119-20
- ameaças
 - de abandono 41-2,47,77-8,88-9,107-9,141-3,146-7; de não amar 139-40, 141; de suicídio 41-2,90-1,143
- amnésia 100,102-14
- ansiedade 19-20,40-2,57,88-9; *veja também*, apego, separação
- apego
 - ansioso com evitação 58-61,121-2, 126-8,129-30,138; ansioso resistente 121-2,126-8,129-30; história da teoria do 33-48; implicações do, para terapia 31-2,47-8,76-80,133-149; modelos de 120-26; seguro/inseguro 24-6,77-9,120-3; teoria do 19-20,38-40,69-73,85-6,87,117-32
- aprendizado e teoria do aprendizado 20-21,35
- avaliação da situação estranha 24-6,55-7,122-3,127-8
- base segura 25-6,46,76-7,119-20, 134, 135-6,145-6
- bebês, *veja* crianças
- behaviourismo 40
- caminhos desenvolvimentais 38,71-3, 118,130-2
- choro 57,61,91-2,106-7,119-20
- ciúme 19-20,53,84
- comportamento agressivo 29-31,82-99, 112,114-5
- comportamento de agarrar 44,121-2, 123,130-2
- comportamento exploratório 55-7,69-70, 119-20,135-6
- comportamento instintivo 20-1,37-8
- comportamento sexual 20-1,104-6,108-10,112,145
- construções malfeitas, percepções malfeitas etc. 102-6,136-7,134-45
- creche 35-6,53-4,61-2
- crianças
 - interação inicial mãe-filho 17-19,19-20,24,58,86-7; circunstâncias do nascimento 27-9
- crianças psicóticas 114-6
- culpa 38,84-5,102-3,142,135-6
- darwinismo e neodarwinismo 72-3
- dependência 19,26,36-9,61-2,69-70, 88,91-2,117
- depressão 19-20,38,57,105,107-8
- desapego 43,44-6,58-9,76
- desenvolvimento de personalidade 38, 117-32
- desespero 43,58,85-6
- dor, *veja* luto
- disciplina 26
- emoções, *veja* sentimento
- espancamento, *veja* abuso infantil
- etologia 17, 19-21,37-9,85-7,118

caso
TERRA

UMA BASE SEGURA/DILATINE

evolução 85-7,118
exclusão defensiva 38,44-6
experiências infantis, efeitos da
 no comportamento da criança 46-7,
 53-6; no comportamento parental 46-
 7,53-6,94-7,129-31
experimentos de dicotomia auditiva 110-11

false self 45,58,76,112-3,121-2,138
fantasia 35,43,83,101,115,135,137
figura de cuidado e busca de cuidado 18,
 85-7,119-21; *veja também* paternagem
fixação 131-2,147
fuga 112-14

grupo de auto-ajuda 32

Home Start 98
hipnose 113-14

inabilidade para expressar 106-8,128,
 134-5,148-9
incesto 105-6,112,145
interação mãe-filho 22-24,54-58,59,122-
 3
interação pais-filhos, *veja* paternagem
interação pai-filho 24-26,27,125-6,130;
 veja também paternagem
inversão de relações 31,42,47,89-90,
 125,138-9

libido 20-21,38,72-4,93
luto 38,42-4,122-3

manutenção da proximidade 19,38,40,
 69,85-7,119-21
medo 41-2,58,86-7,95-6
modelos operacionais, *veja* modelos re-
 presentacionais
modelos representacionais 40-41,69-70,
 72,118,119-20,125-9,134-6,
 138,145

narcisismo 45,58,76,112-3,121-2,131-2,
 138

nascimento, circunstâncias do parto 27-
 29

negativas 43,102-6,137-45
Newpin 98

paternagem
 afecções peri e pós-natal 27-29; como
 um fenômeno natural 17-18,19-20,
 24,58,86-7; experiências infantis 29-
 31,46-7,53-6,94-7,129-31; percep-
 ção 25-26; relações invertidas 31,42,
 47,89-90,125,138-9

perda 42-4,84,106-7
personalidade múltipla 100,112-14
personalidade esquizóide 68,76
perturbação cognitiva 100-15
perturbação da personalidade 100-15
pré-programação 19-21,24,86-7
privação, *veja* perda e luto
privação materna 36-7,46-8,53-4
processamento de informação 45-6,76-
 7,102-14

processos defensivos 38,44-6
psicanálise 36-8,42-3,44,37-8,49-65,66-
 81
psicologia cognitiva 45-6

raiva 19-20,38,41-2,58,84-6,107-8,139-
 40,148

regressão 26,72-3,118,130-2
rejeição 58,61,62-4,88-9,92-3,108-9,
 112

rejeições 102-6,137,142-5
relações simbióticas 42,45-6
repressão 76-7

sentimentos 19-20,20-21,68,76-7,84-6
separação e ansiedade de separação 30-
 31,40-2,43,45,60,61-2,77-8,121-2,
 146-7

sistemas de controle 38,44-5,69-71,118